AXIT URIC HUYẾT THANH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI BỆNH GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU

Châu Hữu Hầu, Đỗ Thị Quốc Trinh, Hia Kim Khuê

TÓM TẮT. Đặt vấn đề: Một số công trình đã chứng minh axit uric huyết thanh có thể là một thành tố trong hội chứng chuyển hóa và liên quan với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. **Đối tượng và phương pháp**: Hồi cứu có phân tích các trường hợp đến khám sức khỏe và khám bệnh tại bệnh viện Nhật Tân. **Kết quả**: Phân tích mối liên quan giữa các biến như giới, tuổi, glucose lúc đói, acit uric, creatinine, GFR, cholesterol toàn phần, HDL-C, LDL-C, triglyceride, viêm gan virus B, đo độ xơ hóa và nhiễm mỡ của gan. Sau khi phân tích hồi qui tuyến tính và biểu đồ ROC thì có 4 biến còn ý nghĩa thống kê glucose lúc đói, axit uric, LDL-C và triglyceride với p<0,001. **Kết luận**: Axit uric huyết thanh cùng với các biến khác liên quan độc lập với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Từ Khóa: Axit uric, axit uric huyết thanh, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

ABSTRACT. ***Serum Uric Acid And Its Association With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease.*** **Background:** Some studies have suggested that SUA may be a component of metabolic syndrome and is closely related to NAFLD cases. **Methods:** The retrospective analysis analyzed cases of health and medical examinations at Nhat Tan Hospital. **Results:** Analysis of relationship between variables such as gender, age, fasting glucose, uric acid, creatinine, GFR, total cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglycerides, viral hepatitis, assessment of liver steatosis and fibrosis. After linear regression analysis and ROC chart, there are 4 variables with statistical significance such as fasting glucose, LDL-C and triglycerides with p <0,001. **Conclusions:** Serum uric acid along with other variables are independently associated with nonalcoholic fatty liver disease.

Keywords: Serum Uric Acid, Non Alcoholic Fatty Liver Disease.

TỔNG QUAN

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (BGNMKDR) phổ biến trên toàn thế giới và là rối loạn gan hay gặp nhất ở các nước công nghiệp phương Tây, nhất là ở những người mắc hội chứng chuyển hóa. Tại Hoa Kỳ, các nghiên cứu báo cáo tỷ lệ BGNMKDR từ 10 đến 46%, trong đó khi dựa vào sinh thiết thì tỷ lệ viêm gan ứ mỡ không do rượu (VGỨMKDR) từ 3 đến 5% dân số. Tỷ lệ hiện mắc VGNMKDR ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương ước tính dao động từ 5 đến 30% [1].

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng mỡ thừa được lưu trữ trong gan không có nguyên nhân do rượu. BGNMKDR có 2 thể riêng biệt mà đôi khi những người mắc thể bệnh này, sau đó được chẩn đoán với một thể bệnh kia mà chưa rõ lý do. Hai thể đó là: (1) Gan nhiễm mỡ đơn thuần còn được gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu (GNMKDR), là một dạng có nhiễm mỡ gan nhưng ít bị viêm hoặc tổn thương tế bào gan, thường lành tính. (2) Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (VGỨMKDR) là dạng gan nhiễm mỡ có viêm và tổn thương tế bào gan, có thể dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan [2].

Các nghiên cứu cho thấy BGNMKDR tăng khi nồng độ axit uric huyết thanh (AUHT) tăng và dẫn đến bệnh suất và tỷ lệ tử vong cao. Bởi thế, nhiều tác giả đã xem AUHT như một

dấu ấn huyết thanh của tổn thương gan. Trong cơ thể, AUHT bị phá hủy khoảng 20% và tiếp tục bị oxy hóa thành allantoin, sau đó được bài tiết ở thận. Do AUHT chủ yếu là sản phẩm do gan sản xuất nên AUHT có thể giảm đi khi gan bị xơ hóa tiến triển ở bệnh nhân BGNMKDR. Ngoài ra một số nghiên cứu cho rằng nồng độ AUHT cao tác động đến lưới nội chất, làm tăng giải phóng các yếu tố gây viêm và do đó làm nặng thêm tình trạng kháng insulin nhất là ở bệnh nhân béo phì [2]. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ AUHT giảm có thể giảm tình trạng BGNMKDR. Do đó, việc chẩn đoán và điều trị sớm BGNMKDR có thể ngừa hoặc làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do BGNMKDR [3].

Trong nghiên cứu này, chúng tôi hồi cứu về mối liên quan giữa nồng độ axit uric và các yếu tố khác ảnh hưởng đến BGNMKDR

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân đến khám bệnh và nhân viên y tế bệnh viện Nhật Tân sau đợt khám sức khỏe hằng năm có làm các xét nghiệm AUHT, fibroscan cùng các xét nghiệm máu khác: bilan lipid, glucose đói , creatinie, urê, viêm gan B và C. Số bệnh nhân được chọn 24.523. **Tiêu chuẩn loại trừ:** Các BN không có đủ các xét nghiệm nêu trên. Cuối cùng còn lại 822 bệnh nhân.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu phân tích. **Thời gian**: 18 tháng từ 01/02/2018 đến 06/8/2019. **Địa điểm nghiên cứu**: Bệnh viện Nhật Tân, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang

Cách tiến hành nghiên cứu: Qua số liệu lưu trữ, chúng tôi chọn các bệnh nhân có các xét bilan lipid (choleterol toàn phần, HDL-C, LDL-C, triglyceride), viêm gan (HBsAg, HBsAb, Anti-HCV), glucose và AUHT. Fibroscan để xác định mức độ xơ gan và nhiễm mỡ gan. Sau đó loại trừ các bệnh nhân thiếu các biến mà chúng tôi muốn nghiên cứu. Chúng tôi không chẩn đoán phân biệt giữa GNMKDR và VGỨMKDR mà gọi chung là BGNMKDR.

Xét nghiệm: Các xét nghiệm được thực hiện trên Roche Cobas c311 và Cobas e411. ***Đo gan nhiễm mỡ:*** FibroScan502Touch (Echosens, 2017)**:** ***Đo độ nhiễm mỡ*** qua "thông số giảm âm được kiểm soát" (TSGA=CAP, đơn vị dB/m).

XỬ LÝ THỐNG KÊ

SPSS Statistics 20 được dùng để phân tích. Đối với các biến liên tục có phân phối chuẩn được phân tích bằng ANOVA. Lấy TSGA từ 258 dB/m trở đi (≥S1, gan nhiễm mỡ độ 1) cũng như các biến phân loại làm hệ số (factor) để phân tích. Các biến số có ý nghĩa sau đó được phân tích bằng hồi qui tuyến tính đa biến. Cuối cùng các biến có ý nghĩa được phân tích qua biểu đồ ROC. Có ý nghĩa thống kê khi $p<0,05$.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. ***Phân tích các biến liên tục theo ANOVA, lấy BGNMKDR làm hệ số.***

Các thông số (n=822)	**Nhóm chứng (n=428)**	**BGNMKDR (n=394)**	**p**
Tuổi, năm	48,8 ± 16,0	51,7 ± 12,8	0,004
Glucose lúc đói, mmol/l	5,74 ± 2,29	6,46 ± 2,77	0,000
AUHT, μmol/l	333,1 ± 101,6	358,7 ± 97,10	0,000
Creatinine, μmol/l	72,6 ± 30,8	70,6 ± 22,8	0,288
Urea, mmol/l	4,26 ± 1,97	4,30 ± 1,55	0,769
Cholesterol, mmol/l	4,41 ± 1,21	5,27 ± 3,31	0,000
HDL-C, mmol/l	1,03 ± 0,34	1,00 ± 0,29	0,127
LDL-C, mmol/l	3,05 ± 1,08	3,50 ± 1,14	0,000
Triglyceride, mmol/l	1,81 ± 1,06	2,79 ± 1,87	0,000
TSGÂ, dB/m	194,0 ± 30,6	284,3 ± 33,0	0,000

Chỉ có creatinine, urê và HDL-Cholesterol không có ý nghĩa thống kê, p >0,05

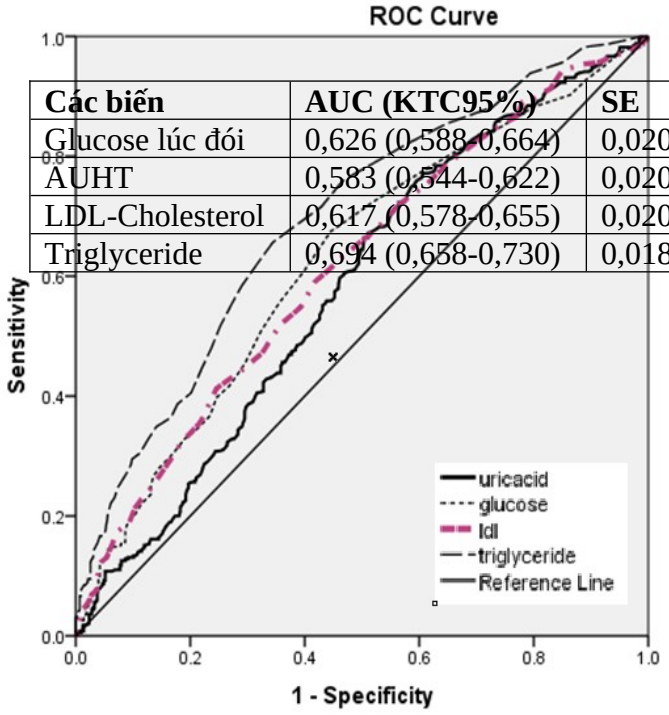
Bảng 2. ***Phân tích theo ANOVA lấy các biến số phân loại làm hệ số, các biến AUHT và TSGÂ là biến phụ thuộc.***

Biến số	**Nhóm**	**N**	**Axit uric**	**p**	**BGNMKDR**	**p**
Giới	Nữ	332	294,1 ± 83,9	0,000	241,6 ± 54,1	0,163
	Nam	490	380,2 ± 95,4		234,9 ± 55,4	
Viêm gan B	Không	661	348,2 ± 101,2	0,107	240,6 ± 54,9	0,001
	Có	161	334,0 ± 95,6		225,0 ± 54,4	
Đái tháo đường	Không	658	347,0 ± 98,4	0,364	232,5 ± 52,0	0,000
	Có	164	339,2 ± 114,2		257,6 ± 61,7	
Suy thận	Độ ≤2	500	326,3 ± 90,0	0,000	236,0 ± 53,9	0,312
	Độ ≥3	322	375,1 ± 107,9		239,9 ± 56,6	
Nhóm bệnh nhân	KSK	366	337,8 ± 94,9	0,050	233,3 ± 50,8	0,051
	Có bệnh	456	351,6 ± 104,0		240,9 ± 57,9	

Bảng 3. ***Tương quan giữa TSGÂ (≥S1=258 dB/m) và các thông số xét nghiệm qua phân tích ANOVA và hồi qui logistic đa biến.***

Các thông số (n=822)	Không NAFLD (n=428)	Nhóm NAFLD (n=394)	Giá trị p	Phân tích hồi qui logit chỉ còn 5 biến có ý nghĩa thống kê với p <0,01		
				OR	KTC95%	Gía trị p
Glucose đói	5,74±2,29	6,46±2,77	0,000	1,108	1,035-1,187	0,003
Axit uric	333,1±101,6	358,7±97,1	0,000	1,002	1,001-1,004	0,009
Creatinine	72,6±30,8	70,6±22,8	0,288	0,987	0,979-0,996	0,003
LDL-C	3,05 ± 1,08	3,50±1,14	0,000	1,426	1,239-1,640	0,000
Triglyceride	1,81 ± 1,06	2,79±1,87	0,000	1,588	1,389-1,815	0,000

Bảng 4. ***Biểu thị trên biểu đồ ROC thì chỉ còn 4 biến do loại creatinine vì p=0,466.***



Các biến	AUC (KTC95%)	SE	Độ nhạy %	Độ đặc hiệu %	p
Glucose lúc đói	0,626 (0,588-0,664)	0,020	67,4	55,5	0,000
AUHT	0,583 (0,544-0,622)	0,020	77,2	39,3	0,000
LDL-Cholesterol	0,617 (0,578-0,655)	0,020	59,0	58,3	0,000
Triglyceride	0,694 (0,658-0,730)	0,018	65,6	65,6	0,000

Hình 1. ***Biểu đồ ROC cho 4 biến AUHT, glucose, LDL-cholesterol và triglyceride.***

BÀN LUẬN

Khi phân tích giữa 2 nhóm BGNMKDR và nhóm còn lại (nhóm chứng) ở bảng 1 thì thấy có 7 biến khác biệt có ý nghĩa thống kê: tuổi, glucose, AUHT, cholesterol toàn phần, LDL-C, triglyceride và TSGÂ có ý nghĩa thống kê với p<0,01.

Phân tích theo nhóm bệnh nhân ở bảng 2: Nồng độ AUHT khác biệt giữa nam và nữ với 380,2±95,4 μmol/l và 294,1±83,0 μmol/l, với p <0,001; theo nghiên cứu của Yu và cs ở người Trung Quốc thì cũng thấy khác biệt giữa nam 355,53±77,42 μmol/l và nữ 272,31±58,85 μmol/l [4]. Desideri và cs [5] cho rằng có sự khác biệt nồng độ AUHT ở nam và nữ với nồng độ được chấp nhận rộng rãi từ 208,2 đến 428,3 μmol/l ở nam giới trưởng thành và phụ nữ mãn kinh và từ 154,7 đến 356,9 μmol/l ở phụ nữ tiền mãn kinh. Nồng độ AUHT ở nghiên cứu của chúng tôi, người bị suy thận ≥ độ 3 cao hơn nhóm người còn lại 375,1 ± 107,9 và 326,3 ± 90,0 μmol/l, vì thận là nơi đào thải chính của AUHT.

Cuối cùng dùng hồi qui logistic đa biến với BGNMKDR làm biến số phụ thuộc và các biến có ý nghĩa thống kê làm biến độc lập (bảng 3), chỉ còn 5 biến có ý nghĩa thống kê với p<0,001, đó là glucose máu, axit uric, creatinine, LDL-C và triglyceride. Khi biểu thị 5 biến trên biểu đồ ROC (bảng 4) thì thấy creatinine không còn ý nghĩa thống kê với p=0,466. Vì thế, trên biểu đồ ROC chỉ còn lại 4 biến với AUC không cao nhưng đều có ý nghĩa thống kê với p<0,001. AUHT có AUC thấp nhất 0,583 với độ nhạy 77,2% và độ đặc hiệu là 39,3%. Cùng với các yếu tố khác, AUHT là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với tình trạng NAFLD với AUHT ở người không có và có NAFLD (333,1 ± 101,6 μmol/l so với 358,7 ± 97,10 μmol/l), p <0,001. Một nghiên cứu tại Hoa Kỳ [6] đã phân tích 5.370 đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 74 từ kỳ kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia lần thứ ba (NHANES III) (1988-1994). Sau khi điều chỉnh, người có tăng AUHT có nhiều khả năng

mắc BGNMKDR gấp 1,4 lần (OR 1,4, KTC 95% từ 1,1 đến 11,1), cho thấy NAFLD và AUHT có liên kết mạnh mẽ và độc lập sau khi điều chỉnh qua nhiều yếu tố.

Đường huyết giữa người không có và có NAFLD (5,74±2,29 mmol/l so với 6,46±2,77 mmol/l), p <0,001. Đối với nồng độ glucose máu ảnh hưởng đến BGNMKDR với độ nhạy và độ đặc hiệu là 67,4% và 55,5% có ý nghĩa thống kê với p <0,001. Nghiên cứu của Utzschneider và cs [7] cho rằng kháng insulin là một tính năng chính của BGNMKDR và ở một số bệnh nhân, có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ. Một số phương pháp điều trị nhằm giảm kháng insulin đã đạt được một số thành công làm giảm tình trạng BGNMKDR.

LDL-C và triglyceride ở người không NAFLD thấp hơn người có NAFLD với 1,81 ± 1,06 mmol/l và 2,79 ± 1,87 mmol/l, p <0,001 phù hợp với nghiên cứu của Peng và cs ở Đài Loan thấy LDL-C, triglyceride, cholesterol toàn phần có liên quan chặt chẽ với nồng độ AUHT, trong khi nồng độ HDL-C huyết thanh lại tỷ lệ nghịch với nồng độ AUHT [8]. Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi, nồng độ cholesterol toàn phần và HDL-C không có ý nghĩa thống kê khác với nghiên cứu của Peng và cs [8].

Đây là một nghiên cứu hồi cứu, cỡ mẫu tương đối nhỏ, nhưng cho thấy AUHT cùng một số yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển hóa như máu, glucose, LDL-C và triglyceride. Qua đó, AUHT có thể là một thành tố của hội chứng chuyển hóa. Bởi thế, nếu muốn điều trị hội chứng chuyển hóa thì phải điều trị giảm các yếu tố này.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 4 biến có ý nghĩa thống kê với p<0,001, đó là glucose máu, axit uric, LDL-C và triglyceride. Cùng với các yếu tố khác, AUHT là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với BGNMKDR.

THAM KHẢO

1. **Sheth SG, Chopra S, Lindor KD, M Robson KM.** Epidemiology, clinical features, and diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease in adults. UpToDate, Jun 2020.
2. NIH, National Institude of diabetes and digestive and kidney diseases. Definition & Facts of NAFLD & NASH. https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/nafld-nash/definition-facts
3. **Zhengli Tang, Minh Pham, Yiming Hao, Fang Wang, Devashru Patel, Lori Jean-Baptiste, Lin Fan, Weijian Wang, Yiqin Wang, and Feng Cheng**. Sex, Age, and BMI Modulate the Association of Physical Examinations and Blood Biochemistry Parameters and NAFLD: A Retrospective Study on 1994 Cases Observed at Shuguang Hospital, China. Biomed Res Int. 2019; 2019: 1246518.
4. **Yu XL, Shu L, Shen XM, Zhang XY, Zheng PZ.** Gender difference on the relationship between hyperuricemia and nonalcoholic fatty liver disease among Chinese. Medicine (Baltimore). 2017 Sep; 96(39).
5. **Desideri G, Castaldo G, Lombardi A, Mussap M, Testa A, Pontremoli R, Punzi L, Borghi C.** Is it time to revise the normal range of serum uric acid levels? European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2014; 18: 1295-1306.
6. **Shih MH, Lazo M, Liu SH, Bonekamp S, Hernaez R, et al.** Association between serum uric acid and nonalcoholic fatty liver disease in the US population. J Formos Med Assoc, 2015, 114: 314-20
7. **Utzschneider KM, Kahn SE**. The Role of Insulin Resistance in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *J. Clinical Endocrinology & Metabolism*, V91 (12) 1 Dec 2006: 4753–4761.
8. **Peng TC, Wang CC, Kao TW, Chan JYH, Yang YH, Chang YW, and Chen WL**. Relationship between Hyperuricemia and Lipid Profiles in US Adults. BioMed Research International. Vol. 2015, ID 127596, 7 pages.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY CHỎM BIPOLAR ĐIỀU TRỊ GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN 175

Nguyễn Minh Phong
(Bệnh viện 121 Cần Thơ)

TÓM TẮT

49 bệnh nhân gãy cổ xương đùi được điều trị bằng thay chỏm Bipolar tại Khoa Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện 175 từ 01/2009 – 04/2003, đạt được kết quả rất khả quan: 100% bệnh nhân liền vết mổ kỳ đầu, phục hồi vận động khớp háng tốt là 91.49. tất cả các bệnh nhân không có biến chứng sau phẫu thuật, sớm vận động và phục hồi chức năng.

SUMMARY

Assessment of the results of bipolar prosthetic surgery in treatment of old patients in the 175 Military Hospital.

Nguyen Minh Phong (121 Military Hospital in Cần Thơ)

There were 49 patients with femoral neck fracture treated with hip bipolar prosthetic surgery at the Department of Orthopedic Trauma of the 175 Hospital from January 2009 to April 2003, with very positive results: The patients healed the wound first with 100%, recovery of good hip joint movement is 91.49%. All patients have no complications after surgery, early mobility and rehabilitation.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Gãy cổ xương đùi là một loại gãy xương nặng thường gặp ở người già, khó khăn trong điều trị, để lại nhiều biến chứng và di chứng tại chỗ cũng như toàn thân. Có rất nhiều phương pháp điều trị gãy cổ xương đùi: điều trị bảo tồn không phẫu thuật (bó bột hoặc xuyên đinh kéo liên tục) cho tỷ lệ liền xương thấp (khoảng 30%), gây ra nhiều biến chứng toàn thân (viêm phổi, viêm đường tiết niệu…) và tại chỗ (loét các điểm tỳ) do phải nằm bất động kéo dài dễ dẫn đến tử vong. Kết hợp xương nẹp vít hoặc vít xốp ở người cao tuổi tỷ lệ liền xương thấp, gây khớp giả hoặc hoại tử tiêu chỏm xương đùi, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và hoạt động. Thay chỏm xương đùi Bipolar trong gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi là một phương pháp điều trị có chọn lựa, giúp cho bệnh nhân đi lại sớm, tránh để xảy ra các biến chứng do nằm lâu. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này tại Bệnh viện 175 nhằm: "*Đánh giá kết quả điều trị thay chỏm Bipolar điều trị gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi và rút ra một số nhận xét về chỉ định, kỹ thuật"*.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

49 bệnh nhân tuổi trên 60, chẩn đoán gãy cổ xương đùi được điều trị thay chỏm Bipolar tại Bệnh Viện 175, từ tháng 01/2009 đến tháng 04/2013.

2. Phương pháp nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu: phương pháp mô tả lâm sàng cắt ngang không đối chứng (hồi cứu và tiến cứu), kết hợp theo dõi dọc.
- Kỹ thuật mổ:

+ Bệnh nhân được gây tê tủy sống, nằng nghiêng 90°, khung chậu cố định vững chắc vào bàn mổ.

+ Đường mổ: sử dụng đường mổ Gibson. Mở bao khớp, làm trật cổ xương đùi ở đầu ngoại vi ra sau.

+ Cắt phẳng lại cổ xương đùi cách mấu chuyển bé khoảng 12mm. Lấy bỏ phần cổ, chỏm kiểm tra ổ cối và đo đường kính chỏm xương đùi.

+ Khoan và doa ống tủy xương đùi.để tạo khuôn ống tủy xương đùi, từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn; cỡ lớn nhất nhỏ hơn 1 số (0,5mm) so với chuôi nhân tạo cần thay. Phải lấy hết xương xốp ở phần ống tủy xương đùi rồi mới thử chuôi. Bơm rửa ống tủy, đặt nút chặn và bơm xi măng. Đặt chuôi và đóng chắc chuôi, chuôi đạt yêu cầu khi: chân hơi dạng góc cổ thân khoảng 135-140o , thử head và đo chiều dài cổ chỏm (hai gối bằng nhau là đạt yêu cầu). Lắp chỏm Bipolar bằng kích thước chỏm xương đùi, đặt lại chỏm nhân tạo vào ổ cối.

- Kiểm tra cầm máu, bơm rửa vết mổ, khâu phục hồi bao khớp. Dẫn lưu, khâu phục hồi tốt nhóm cơ chậu hông mấu chuyển, khâu cân, khâu da.

3. Đánh giá kết quả: Đánh giá kết quả gần và kết quả xa theo chỉ số của Merle D ′Aubigné- Postel.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Yếu tố dịch tễ:

**** Tuổi và giới:***

- Tuổi nhóm bệnh nhân nghiên cứu đều trên 60, tuổi cao nhất là 96 tuổi, thấp nhất là 60 tuổi. Tuổi trung bình là 71.8±8.9.
- Giới nam 11/49 (24.49%), giới nữ 38/49 (75.51%).

**** Nguyên nhân gây gãy cổ xương đùi***

- Tai nạn sinh hoạt nhiều hơn cả 45/49 (91.8%), tai nạn giao thông 3/49 (6.1%), tai nạn lao động 1/49 (2.1%).

**** Bảng 1.*** Thời gian từ khi bị gãy cổ xương đùi đến khi thay chỏm (n=49)

Thời gian	Số lượng BN	Tỷ lệ %
≤ 1Tuần	14	28,6%
≤ 2 Tuần	22	44,9%
≤ 3 Tuần	8	16,3%
≤ 4 Tuần	5	10,2%
Tổng cộng	**49**	**100%**

**** Các bệnh nội khoa kết hợp***

- Có 20/49 bệnh nhân có bệnh nội khoa mạn tính kèm theo chiếm 40,8 %. Bệnh lý tim mạch, chủ yếu là cao huyết áp với 10 bệnh nhân chiếm 20,4%. Tiểu đường có 7 bệnh nhân chiếm 14,3% và lao có 2 bệnh nhân chiếm 4,1%. Có 1 bệnh nhân bị hai bệnh kết hợp cao huyết áp và lao củ đã ổn định chiếm 2%. Tất cả các bệnh nhân bị bệnh lý mạn tính đều được điều trị ổn định trước khi phẫu thuật.

*** *Bảng 2*.** Đường kính chỏm nhân tạo được sử dụng (n = 49)

Đường kính	**38 – 40mm**	**41 - 45mm**	**46 - 50 mm**	**Tổng**
Số lượng	7	25	17	**49**
Tỷ lệ %	14.29%	51.02%	34.69%	**100%**

2. Kết quả điều trị:

**** Kết quả gần***

- Diễn biến tại vết mổ: liền sẹo trong kỳ đầu 100%.
- Thời gian nằm viện sau PT: Trung bình là 11,9±2,3 ngày số ngày nằm viện ngắn nhất là 8 ngày và dài nhất 19 ngày.
- Thời gian tập vận động sau PT: tập gấp khớp háng (khoảng 45°), gấp khớp gối, vận động cổ chân và ngồi dậy vào ngày thứ 2. Ngày thứ 3 tập đứng. Ngày thứ 4- 5 tập đi bằng khung hoặc đi có người trợ giúp.

*** Kết quả xa**

- Chúng tôi đã kiểm tra được 47/49 bệnh nhân. Có 01 bệnh nhân không kiểm tra được do tử vong sau mổ 06 tháng với lý do do trụy tim mạch, 1 bệnh nhân 60 tuổi không liên lạc được.
- Số bệnh nhân theo dõi dưới 1 năm là 16/47 ca, 1 – 2 năm là 19/47 ca, trên 2 năm là 12/47 ca.
- Đau sau mổ: không đau 44/47 ca (93.6%), đau nhẹ và vừa 3/47 ca (6.3%).
- Biên độ gấp của khớp háng sau phẫu thuật: có 32/47 trường hợp có biên độ gấp háng > 90◦ chiếm 68,1%, 12/47 trường hợp biên độ gấp háng từ 500 – 850, có 3/47 trường hợp có biên độ gấp háng nhỏ hơn 30◦, là do những bệnh nhân này mới được phẫu thuật thay khớp nên còn hạn chế vận động.

**** Kết quả chung***

- Rất tốt và tốt là 43/47 trường hợp chiếm 91.49%
- Khá là 3/47 trường hợp chiếm 6.38%
- Trung bình là 1/47 trường hợp chiếm 2.13%
- Không có trường hợp nào có kết quả kém.

BÀN LUẬN

1. Yếu tố dịch tễ*:* gãy cổ xương đùi hay gặp ở người cao tuổi, nữ gặp nhiều hơn nam. Theo Lauren A. Beaupre các người cao tuổi thường loãng xương, cổ xương đùi trở nên yếu, đến mức các chấn thương nhẹ cũng có thể gây gãy xương. Tỉ lệ mắc bệnh ở hai giới cũng có sự chênh lệch đáng kể, nguyên nhân là do nội tiết và đặc điểm sinh lí của phụ nữ. Sau tuổi 50 tỉ lệ gãy cổ xương đùi ở nữ cao gấp 3- 4 lần so với nam. Theo nghiên cứu của chúng tôi tai nạn sinh hoạt nhiều hơn cả 45/49 (91.8%), nữ 37/49 trường hợp gấp 3 lần nam 12/49 trường hợp phù hợp với nghiên cứu một số tác giả trên thế giới.

2. Chỉ định điều trị:

Gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi liên quan nhiều với tình trạng loãng xương. Thậm chí có tác giả còn coi đây là gãy xương bệnh lí. Do vậy, nếu lựa chọn kết hợp xương thì nguy cơ không liền xương và mổ lại rất cao. Theo Frihagen tỉ lệ không liền xương và hoại tử chỏm tới 47%.

Sau thay chỏm Bipolar bệnh nhân hết đau ngay, có thể ngồi dậy và tập vận động đi lại sớm và khôi phục nhanh chức năng của khớp háng và cũng ngăn ngừa được các biến chứng do nằm bất động kéo dài.

3. Kỹ thuật mổ

- ***Đường mổ*****:** Có nhiều rất nhiều đường mổ được sử dụng trong thay khớp Bipolar. Chúng tôi lựa chọn đường mổ Gibson vì thuận lợi cho kỹ thuật thay chỏm, giảm chấn thương mô mềm, giảm đau, phục hồi chức năng sớm.
- ***Khôi phục hình thể giải phẫu cổ xương đùi:*** Mục tiêu chính trong PT thay chỏm Bipolar là khôi phục chiều dài cổ xương đùi. Gãy mới dễ khôi phục. Gãy cũ có biến dạng tiêu cổ chỏm, các cơ co rút nhiều, nên kéo liên tục trước để dãn cơ.
- ***Kỹ thuật xi măng:*** Nút chặn xi măng có vai trò duy trì áp lực khi nén xi măng, sử dụng nút chặn plastic là tốt nhất. Khoảng cách giữa nút chặn và đầu dưới của chuôi từ 2-3 cm. Thời điểm tốt nhất để nhồi xi măng vào ống tủy là xi măng không còn dính găng. Lúc đó xi măng sẻ đạt được độ xâm nhập cao nhất (thời gian từ 10 đến 12 phút).
- ***Lựa chọn kích thước chỏm nhân tạo:*** Chúng tôi cho rằng chọn chỏm nhân tạo có đường kính bằng chỏm thật là tốt nhất để giảm mòn ổ cối. Mặt khác nếu chỏm nhân tạo quá to hoặt quá nhỏ thì sẽ không duy trì được áp lực hút của ổ cối với chỏm làm nguy cơ trật khớp cao. Trong nghiên cứu của chúng tôi không có trường hợp nào sử dụng chỏm nhỏ hơn chỏm thật 1 số (1mm).
- ***Phục hồi vết mổ:*** Khâu phục hồi tốt các lớp: bao khớp, các cơ bị cắt, khâu cân, đóng tổ chức dưới da tốt. Tốt nhất là đặt dẫn lưu hút áp lực âm, vừa có áp lực hút hết máu tụ vừa kín, hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào vùng mổ. Rút bỏ dẫn lưu sau 48 giờ.

4. Kết quả điều trị:

***** ***Đánh giá kết quả gần***:

- Liền sẹo kỳ đầu: có 49/49 (tỷ lệ 100%) trường hợp vết mổ sau phẫu thuật được đánh giá là tốt, vết mổ liền sẹo kỳ đầu. Không có trường hợp nào nhiễm trùng vết mổ.
- Chụp Xquang sau mổ: Sau mổ ổn định 2- 4 ngày chụp Xquang kiểm tra. Kết quả 49/49 khớp nhân tạo, chuôi được đặt đúng vị trí, hướng cổ khớp nhân tạo trùng với hướng lồi cầu đùi. Chuôi nghiêng trước 10◦ đến 15◦ , chuôi vào chính giữa ống tủy hoặc đầu dưới chuôi hơi hướng về lồi cầu trong xương đùi, đây là tư thế tương tự với tư thế cổ xương đùi.
- Chăm sóc và phục hồi chức năng sau mổ:

Sau mổ giữ 2 chân bệnh nhân ở tư thế giạng 40° bằng một nẹp tam giác đặt giữa 2 chân và đặt 1 gối ở dưới kheo chân bên phẫu thuật để giữ cho khớp háng gấp khoảng 30°. Tập vẫn động sớm giúp cho bệnh nhân tránh được các biến chứng toàn thân và tại chỗ, căn cứ vào tình trạng xương và bệnh lý cụ thể của từng người bệnh mà chúng tôi đưa ra các liệu pháp vận động cho phù hợp. Trung bình sau mổ 2 ngày bệnh nhân được hướng dẫn tập các động tác chủ động với các động tác lên gân cơ đùi, cơ cẳng chân, gấp duỗi cổ chân và tập nhấc gót chân lên khỏi mặt giường, thẳng gối. Từ ngày thứ 3 trở đi bệnh nhân được tập đứng lên

với sự trợ giúp của khung tập đi. Chân bên thay chỏm được tỳ nén tăng dần, tránh các tư thế có thể gây sai khớp háng.

**** Đánh giá kết quả xa:***

Qua đánh giá chức năng sau phẫu thuật của 47 bệnh nhân với thời gian theo dõi trung bình là 2.78 ±1.45 năm. Chúng tôi sử dụng thang điểm của Merle d'Aubigné – Postel và thu được kết quả sau.

Rất tốt và tốt: 43 trường hợp tỷ lệ 91.49%

Khá : 3 trường hợp tỷ lệ 6.38%

Trung bình : 1 trường hợp tỷ lệ 2.13%

KẾT LUẬN

Phẫu thuật thay chỏm Bipolar điều trị gãy cổ xương đùi trên các bệnh nhân cao tuổi có nhiều điểm ưu việt hơn các phương pháp điều trị khác. Thay chỏm Bipolar giúp cho bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt, hoạt động và phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tránh được các biến chứng tại chỗ như chậm liền xương, khớp giả và các biến chứng toàn thân như viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét điểm tỳ do điều trị bằng các phương pháp khác. Qua 49 bệnh nhân được gãy cổ xương đùi được điều trị thay chỏm Bipolar, theo dõi được 47 bệnh nhân, bệnh viện 175 đạt được kết quả điều trị khả quan: Rất tốt và tốt tỷ lệ 91.49% .Khá: 6.38%, trung bình: 2.13%, không có trường hợp nào có kết quả kém.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt nam

1. **Nguyễn Tiến Bình, Trần Lê Đồng (2000):**" Đánh giá kết quả sau thay khớp háng toàn phần và bán phần". Phẫu thuật tạo hình, tập VI, số 1, trang 36- 38, 2000.
2. **Trần Đình Chiến, Phạm Đăng Ninh và cộng sự (2009):"** Một số nhận xét qua 10 năm ứng dụng phẫu thuật thay khớp háng tại khoa CTCH Bệnh viện 103, *Tạp chí y dược học quân sự*. tr 90-95.
3. **Nguyễn Trọng Tài (2012):"** Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần Bipolar tại bệnh viện Việt Đức. *Luận văn thạc sỹ, Học Viện Quân Y.*

Tài liệu tiếng Anh

4. **Emery R.J.H**: Bipolar hemiarthroplasty for subcapital fracture of *the* femoral neck. *JBJS (Br) 73-3:322-4 (1991).*
5. **Frihagen F. et al:** Hemiarthroplasty or internal fixation for intracapsular displaced femoral neck fractures: randomised controlled trial. *BMJ, 2007: 335: 1251- 1254.*
6. **James W. Harkess (1998):"**Arthroplasty in Hip". Campbell′s operative orthopeadics ninth edition, *pp. 296- 458.*
7. **NiKoLopoulos K:** long-term outcome of pateints with avascular necrosis,after internal fixation of femoral neck fractures. Injury 2003 *Jul; 34 (7):525-8*

Ý NGHĨA CỦA CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ÁP LIÊN TỤC 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Châu Hữu Hầu, Hia Kim Khuê, Đỗ Thị Quốc Trinh

TÓM TẮT

Mục tiêu: Tìm hiểu ý nghĩa lâm sàng của các thông số huyết áp liên tục 24 giờ ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa. **Phương pháp**: Mô tả và phân tích so sánh các thông số huyết áp, nghiên cứu tiến cứu. **Địa điểm và thời gian nghiên cứu**: Nghiên cứu tại bệnh viện Nhật Tân, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thời gian 1 năm từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2020. **Kết quả:** Nghiên cứu trên 134 đối tượng, gồm 67 người có hội chứng chuyển hóa và 67 đối chứng; trong đó nữ gồm 73 người, chiếm 54.5%, nhưng mắc hội chứng chuyển hóa là 61,6%. Có 3 thông số có có liên quan chặt chẽ với hội chứng chuyển hóa là: huyết áp tâm trương trung bình 24 giờ có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 46,3% và 77,6%; nhịp tim trung bình 24 giờ là 56,7% và 68,7% và huyết áp trung bình (MAP) 24 giờ là 35,8% và 86,6%. **Kết luận**: Nghiên cứu cho thấy việc theo dõi các thông số huyết áp liên tục trong 24 giờ là một biện pháp hiệu quả để chẩn đoán chính xác tăng huyết áp và dự đoán yếu tố nguy cơ liên quan đến tăng huyết áp. Qua đó điều trị thích hợp nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng cũng như các biến chứng gây tàn phế cho bệnh nhân.

Từ khóa: Hội chứng chuyển hóa, HA liên tục 24 giờ, HA tâm thu trung bình 24 giờ, HA tâm trương trung bình 24 giờ, nhịp tim trung bình 24 giờ, HA trung bình 24 giờ.

SUMMARY

SIGNIFICANCE OF A 24-HOUR BLOOD PRESSURE AMBULATORY MONITORING IN THE PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

Objectives: To understand the clinical significance of 24-hour continuous blood pressure parameters in patients with metabolic syndrome. **Methods**: description and comparative analysis of blood pressure parameters, prospective study. Study location and time: Research at Nhat Tan Hospital, Chau Doc City, An Giang Province. The study period was 1 year from July 1, 2019 to June 30, 2020. **Results**: Research on 134 subjects, including 67 people with metabolic syndrome and 67 controls; in which female included 73 people, accounting for 54.5%, but metabolic syndrome was 61.6%. There were three parameters that were closely related to the metabolic syndrome: 24-hr mean diastolic blood pressure with sensitivity and specificity of 46.3% and 77.6% respectively; 24-hr mean heart rate was 56.7% and 68.7% and 24-hr mean blood pressure was 35.8% and 86.6%. **Conclusion**: Research showed that monitoring 24 hours of blood pressure parameters was an effective way to accurately diagnose hypertension and predict risk factors associated with hypertension, Thereby appropriate treatment was to avoid life-threatening complications as well as those causing disability to patients.

Key works: Ambulance Blood Pressure Monitoring; Blood Pressure; Diastolic Blood Pressure; 24-hour Heart Rate; Mean Arterial Pressure; Metabolic syndrome; Pulse Pressure.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh tim mạch (TM) là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu với số chết hàng năm do bệnh TM hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác. Năm 2016. ước tính có 17,9 triệu người đã chết vì bệnh TM, chiếm 31% tổng số ca tử vong toàn cầu. Những yếu tố nguy cơ của bệnh TM như tăng huyết áp [THA], đái tháo đường, tăng lipid máu…) cần được phát hiện và xử trí sớm bằng cách tư vấn và điều trị [1].

THA là bệnh lý thường gặp nhất trong các bệnh lý TM, bệnh diễn biến thường thầm lặng nhưng lại gây ra các biến chứng rất nặng nề. THA cần được chẩn đoán kịp thời, điều trị tối ưu góp phần cải thiện các biến chứng và tỷ lệ tử vong. Hiện nay, chẩn đoán THA ở nước ta thường dựa trên đo huyết áp (HA) trong phòng khám bằng máy đo HA cơ hoặc máy đo điện tử. Các loại máy này thường không ổn định và kém chính xác, do đó dễ dẫn đến định hướng điều trị sai. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy đo HA liên tục trong 24 giờ (HALT24 giờ), kể cả đo HA trong khi ngủ, là yếu tố dự báo tốt hơn về các biến cố TM (như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, bao gồm cả tổn thương cơ quan đích) so với các phương pháp đo HA truyền thống được thực hiện tại phòng khám. Hơn nữa, HALT24 giờ còn giúp giảm thiểu sai sót trong việc loại trừ THA áo choàng trắng (người có HA trên mức bình thường khi đến khám bệnh, dù họ không THA ở nơi khác), xác định rõ hơn các trường hợp người bệnh không có THA, THA ẩn giấu và THA thật mà các phương pháp đo HA truyền thống chưa xác định được [2].

HALT 24 giờ còn có thể giải quyết các vấn đề khác như chẩn đoán THA vào ban đêm, THA ẩn giấu và THA áo choàng trắng. Việc ứng dụng HALT 24 giờ có thể giúp cải thiện chẩn đoán THA và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, HALT24 giờ còn giúp xác định được các thông số khác khá quan trọng trong việc xác định tổn thương cơ quan đích như: tình trạng trũng (dipper, người bình thường HA giảm từ 10 đến 20% vào ban đêm) hoặc không trũng (HA không giảm vào ban đêm, non dipper); hiệu áp tăng (PP), nhất là khi bệnh nhân bị hội chứng chuyển hóa (HCCH); nhịp tim trung bình 24 giờ và nhiều thông tin khác giúp cho thầy thuốc can thiệp đúng mức cho bệnh nhân.

Hiện nay, HCCH ở nước ta ngày càng tăng và nghiên cứu để có hiểu biết sâu hơn về HCCH là cần thiết. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả và phân tích mối liên quan giữa HCCH và các kết quả HALT 24 giờ trên bệnh nhân tại bệnh viện Nhật Tân (BVNT), qua đó xác định các yếu tố nguy cơ giúp chẩn đoán và điều trị tốt hơn cho các bệnh nhân này.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân đến khám hoặc nằm viện tại bệnh viện Nhật Tân (BVNT) cùng một số nhân viên của bệnh viện có HCCH theo tiêu chí IDF 2009. Có tất cả 134 người được đưa vào nghiên cứu. Số đối tượng ở nhóm mắc HCCH chọn từ người bệnh nằm viện hay khám ngoại trú (41 người) và từ nhân viên của BVNT (26 người), tổng cộng 67 người. Số đối tượng ở nhóm đối chứng là 67 người không mắc HCCH chọn từ bệnh nhân đến khám chữa bệnh (32 người) và nhân viên của BVNT (35 người) trong năm 2019. **Tiêu chuẩn loại trừ**: Các bệnh nhân và nhân viên không đồng ý tham gia, hoặc không đủ số liệu cần thiết cho nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả và phân tích so sánh các thông số trong chẩn đoán bệnh được thực hiện cho các bệnh nhân nội và ngoại trú tại bệnh viện Nhật Tân.

2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành tại BVNT, TP Châu Đốc, An Giang. Thời gian nghiên cứu: 1 năm, từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2020.

2.4. Cách tiến hành nghiên cứu

Tiêu chí chọn bệnh: Sử dụng tiêu chí chẩn đoán của Liên đoàn Đái Tháo Đường Quốc tế (IDF 2009). Người mắc HCCH có ít nhất 3 trong số 5 tiêu chí sau đây:

1. Glucose lúc đói ≥5,6 mmol/l (100 mg/dl) hoặc bệnh đái tháo đường đã được chẩn đoán

2. HDL-Cholesterol <1,0 mmol/l (40 mg/dl) (nam); <1,3 mmol/l (50 mg/dl) (phụ nữ) hoặc điều trị bằng thuốc tăng HDL Cholesterol.

3. Triglyceride ≥1,7 mmol/l (150 mg/dl) hoặc dùng thuốc điều trị giảm triglyceride

4. Vòng eo ≥94 cm (ở nam) hoặc ≥80 cm (ở nữ)

5. Huyết áp ≥130/85 mmHg hoặc dùng thuốc điều trị THA.

Cách đo: Các phương pháp đo HA 24 giờ đã được ghi lại bằng máy đo HALT WatchBP*03, sản xuất 2019. Máy đã được Hiệp hội THA châu Âu (ESH) và Hiệp hội Tim Hoa Kỳ chấp thuận. Thiết bị được mang ở cánh tay không thuận của người bệnh vào khoảng từ 8 giờ đến 16 giờ, và được lấy ra 24 giờ sau đó. Thiết bị được lập trình để ghi lại HA mỗi 30 phút vào ban ngày (6 giờ sáng đến 10 giờ tối) và 60 phút vào ban đêm (20 giờ tối đến 6 giờ sáng).

Xét nghiệm: Các xét nghiệm glucose, HDL-C, triglycerides được đo bằng máy sinh hóa Cobas của Roche.

HA: Do không thể chọn số đo HA ở phòng khám do hiện tượng THA áo choàng trắng (HA chỉ tăng khi đến khám bệnh), HA ở nhà cũng khó do không thể chuẩn hóa máy đo và cách đo được, chúng tôi lấy HA ban ngày sau khi đo HALT24 giờ để làm 1 tiêu chí xếp loại người bệnh vào HCCH với HATT ≥135 mmHg hoặc HATTr ≥85 mmHg.

Hiệu áp *(Pulse Pressure, PP)* được xác định bằng cách trừ HATT với HATTr. khi hiệu áp tăng cao được xem là có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.

HA trung bình (HATB, MAP): Theo công thức: HATB = HATTr + 1/3 (hiệu áp, PP)-

2.5. Xử lý thống kê

Nhập và xử trí số liệu trên SPSS Statistics 20.0; dùng crosstabs để phân tích các biến định tính; dùng one way ANOVA để phân tích các biến liên tục. Dùng biểu đồ ROC để tính độ nhạy, độ đặc hiệu các cặp thông số so sánh. Ngưỡng có ý nghĩa thống kê khi p <0,05.

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu: Các đối tượng được thông báo chi tiết về các nội dung và mục tiêu nghiên cứu và lấy ý kiến đồng thuận. Mọi thông tin cá nhân đều được bảo vệ. Người tham gia được miễn một phần viện phí.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Mẫu nghiên cứu bao gồm 134 người; 73 phụ nữ, chiếm tỷ lệ 54.5%, nhưng tỷ lệ nữ mắc HCCH là 61,6% cao hơn có ý nghĩa so với nam (36,1%, p<0,05).

Bảng 1. ***Các đặc trưng dân số học của người tham gia***

Các biến số	**Tổng số**	**Có HCCH**	**Không HCCH**	χ^2	**p**
Số người nghiên cứu				2.437	0.118
Nhân viên BVNT	61 (45,5%)	26 (42,6%)	35 (57,4%)		
Bệnh nhân	73 (54,5%)	41 (56,2%)	32 (43,8%)		
Giới				8.697	0,003
Nữ	73 (54,5%)	45 (61,6%)	28 (38,4%)		
Nam	61 (45,5%)	22 (36,1%)	39 (63,9%)		

Bảng 2. ***Các biến số định lượng liên quan về HCCH***

Các biến số (giá trị trung bình)	**Đối tượng nghiên cứu**		**F**	**p**
	Có HCCH	**Không HCCH**		
Tuổi	52.7 ± 13,6	49.7 ± 17,8	1.216	0.272
Chiều cao, cm	157.7 ± 8.1	158.8 ± 7.7	0,664	0,417
Cân nặng, kg	64.6 ± 11.7	59.1 ± 9.9	8,583	0,004
BMI, kg/m^2	25.9 ± 3.4	23.4 ± 2.8	21,421	0,000

Vòng eo, cm	91.1 ± 9.3	81.8 ± 10.1	30,231	0,000
Glucose, mmol/l	8.3 ± 5.6	6.4 ± 3.4	20.616	0,000
HDL-C, mmol/l	0.95 ± 0.30	1.10 ± 0.39	33,397	0,000
Triglyceride, mmol/l	3.85 ± 2.22	3.31 ± 1.95	12,011	0,001

Trong khi yếu tố tuổi và chiều cao không có sự khác biệt giữa 2 nhóm đối tượng có và không có HCCH, thì các chỉ số trong tiêu chí chẩn đoán IDF-2009 có khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,05

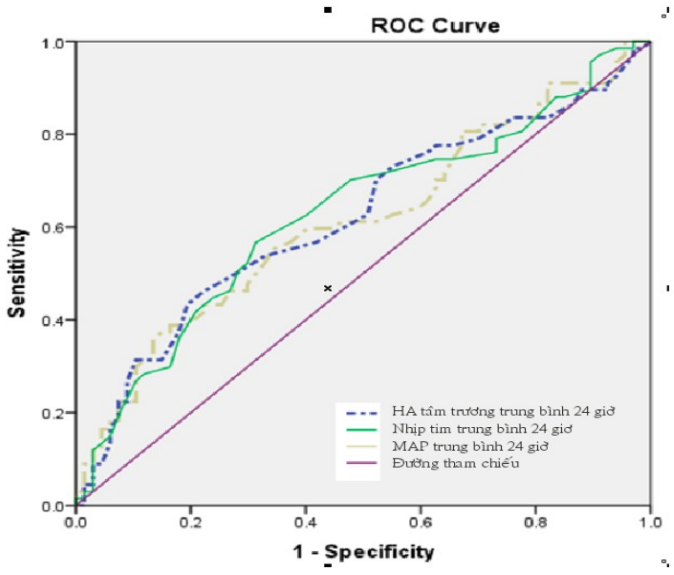
Bảng 3. ***Các biến số thu được bằng HALT***

Các thông số (giá trị trung bình)	**Đối tượng nghiên cứu**		**F**	**p**
	Có HCCH	**Không HCCH**		
HATT 24 giờ	121.3 ± 13.9	116.6 ± 13.2	3.416	0.067
HATTr 24 giờ	74.9 ± 10.3	70.9 ± 8.6	5.894	0.017
Nhịp tim TB 24 giờ	76.8 ± 10.7	71,3 ± 12.4	7.594	0.007
HA TB 24 giờ	85.1 ± 10.6	80.5 ± 12.9	5.206	0.024
Hiệu áp 24 giờ	46.4 ± 10.0	45.6 ± 10.5	0.207	0.650
Trũng	0.48 ± 0.50	0.39 ± 0.49	1.087	0.299

Trong 60 trường hợp có trũng được chia ra như sau: trũng 39 ca (65%), trũng quá độ 19 ca (31,7%) và trũng ngược 2 ca (3,3%).

Bảng 4. ***Phân tích bằng biểu đồ ROC***

Các biến trung bình	**Ngưỡng mmHg**	**Độ nhạy %**	**Độ đặc hiệu %**	**AUC (KTC95%)**	**p**
HATTr 24 giờ	75,5	46,3	77,6	0,620 (0,524-0,715)	0,017
Nhịp tim TB 24 giờ	75.5	56,7	68,7	0,629 (0,533-0,724)	0,010
HATB (MAP) 24 giờ	95,2	35,8	86,6	0,613 (0,517-0,709)	0,024



Qua biểu đồ ROC cho thấy trong các chỉ số đưa vào phân tích, có 3 chỉ số khác biệt có ý nghĩa thống kê là HATTrTB 24giờ, nhịp tim TB 24giờ và HATB 24giờ với p<0,05

Hình 1. ***Biểu đồ ROC với 3 thông số có ý nghĩa thống kê***

BÀN LUẬN

Tổng số người được nghiên cứu là 134 người. Trong số này, 67 người có HCCH và 67 người không có HCCH dùng để so sánh đối chứng.

Trong mẫu nghiên cứu, số lượng nam mắc HCCH chỉ chiếm 36,1% trong tổng số nam, nữ có 61,6% trong số nữ. Một nghiên cứu trước đó của chúng tôi về HCCH của nhân viên y tế

tại BVNT cũng có kết quả tương tự, số nam mắc HCCH là 15,6% trong khi nữ mắc 29,8% trong cộng đồng nhân viên BVNT [3].

Các biến số định lượng có liên quan đến HCCH, ngoài tuổi và chiều cao, không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Các biến số khác như cân nặng, BMI, vòng eo, glucose, HDL-Cholesterol và triglyceride đều có ý nghĩa thống kê khi phân tích bằng ANOVA. Tuy nhiên các biến số này không được phân tích tiếp do chúng tôi chọn người có HCCH và một số lượng tương đương không có HCCH làm đối chứng, nên có sự khác biệt là đương nhiên.

Các biến số khác như: HATT 24 giờ, HATTr 24 giờ, MAP 24 giờ, nhịp tim 24 giờ, PP 24 giờ và tình trạng trũng được phân tích bằng ANOVA thì chỉ có 4 yếu tố có ý nghĩa thống kê là HATT 24 giờ, HATTr 24 giờ, MAP 24 giờ, nhịp tim TB 24 giờ. Tất cả các biến số này được đưa vào phân tích bằng biểu đồ ROC thì chỉ còn 3 biến trung bình còn ý nghĩa thống kê là HATTr 24 giờ, HATB 24 giờ và nhịp tim TB 24 giờ.

HATTr 24 giờ ở nhóm có HCCH cao hơn nhóm không mắc bệnh (74.9 ± 10.3 và 70.9 ± 8.6), khác biệt có ý nghĩa thống kê khi phân tích theo ANOVA với $p<0,05$. Khi phân tích trên đường cong ROC, khác biệt này vẫn còn có ý nghĩa. Theo Hsu và cs [8] HATTr cũng giúp dự báo HCCH trong tương lai ở những người có tuổi, nhưng không bằng MAP.

HA trung bình (HATB, MAP) 24 giờ: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy HATB 24 giờ ở người có HCCH cao hơn người không HCCH (85.1 ± 10.6 mmHg so với 80.5 ± 12.9 mmHg, $p<0,05$) khi phân tích bằng ANOVA cũng như trên biểu đồ ROC. Theo Hsu và cs HATB chính xác hơn HATT, HATTr và hiệu áp (PP) 24 giờ trong việc dự đoán HCCH trong tương lai ở những người lớn tuổi có HA bình thường [8]. Một công thức hay dùng để ước tính MAP là HATB = HATTr + 1/3 hiệu áp (PP). HATB có chức năng tưới máu đến tất cả các mô của cơ thể để giữ cho chúng hoạt động với HATB tối thiểu là 60 mmHg [5]. Nếu MAP giảm xuống kéo dài dưới điểm này, các biểu hiện ở cơ quan cuối như thiếu máu cục bộ và nhồi máu có thể xảy ra. Khi MAP tăng, làm tăng kích thích áp thụ quan, làm giảm hoạt động giao cảm và tăng hoạt động phó giao cảm. Sự gia tăng của trương lực phó giao cảm sẽ làm giảm rối loạn nhịp (chronotropy) và thay đổi dẫn truyền nhĩ thất (dromotropy) và tác động lên kỳ tâm trương (lusitropy). Kết quả là giảm cung lượng tim và giảm MAP sau đó.

Nhịp tim TB 24 giờ ở nhóm có HCCH là 76.8 ± 10.7 cao hơn nhóm không có HCCH là 71,3 ± 12.4 có ý nghĩa thống kê với $p= 0.007$ khi phân tích trên biểu đồ ROC. Đây có thể do nhịp tim nhanh hơn ở người có HCCH khiến cho HATTr 24 giờ cao hơn ở nhóm có HCCH.

Trong nghiên cứu của chúng tôi các biến số sau đây không có ý nghĩa thống kê:

- Trũng phản ảnh tình trạng HA giảm sinh học bình thường, do khác biệt giữa HATT TB ban ngày và HATT TB ban đêm, biểu thị bằng phần trăm so với HATB ban ngày, với mức từ 10% đến 20%. Trong nghiên cứu này, 60 trường hợp có trũng phân chia như sau: trũng 39 ca (65%), trũng quá độ 19 ca (31,7%) và trũng dốc ngược (river) 2 ca (3,3%).
- Hiệu áp (PP) liên tục là khoảng chênh lệch giữa HA tối đa và HA tối thiểu, có giá trị bình thường khoảng 40 mmHg. Hiệu áp tăng khi lớn hơn 50 mmHg, thường xuất hiện sau như một đáp ứng sinh lý như sốt, thời tiết nóng, lo lắng…[5]. Khi tuổi càng cao, hiệu áp càng tăng lên. Verdecchia và cs cho rằng khi hiệu áp >53 mmHg được xem là có nguy cơ bệnh TM [4]. Nhưng trong báo cáo của Hsu và cs [8], cũng như nghiên cứu của chúng tôi, PP không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa người có và không có HCCH.

Hạn chế trong nghiên cứu này là cỡ mẫu còn nhỏ và cách chọn mẫu chưa được đồng nhất và điển hình, chưa trả lời được giá trị của các thông số HATB cho các cấp độ HCCH.

IV. KẾT LUẬN

Nghiên cứu so sánh trên 67 người có hội chứng chuyển hóa và 67 người đối chứng không mắc hội chứng này, nhận thấy các yếu tố sau đây có liên quan có ý nghĩa thống kê với hội chứng chuyển hóa là HA tâm trương trung bình 24 giờ, HA trung bình 24 giờ và nhịp tim trung bình 24 giờ. Đo HA liên tục trong 24 giờ là một biện pháp có hiệu quả để chẩn đoán chính xác THA và nhờ đó điều trị thích hợp nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng cũng như các biến chứng gây tàn phế cho bệnh nhân.

THAM KHẢO

1. **WHO.** Cardiovascular diseases (CVDs). 17 May 2017. **https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/ detail/cardiovascular-diseases-(cvds)**.
2. **Mendes MSF; Horta TG; Ribeiro ALP; Kac G; de Fátima Silqueir SM; Meléndez GV.** Association between metabolic syndrome and parameters of 24-hour blood pressure ambulatory monitoring. Arq Bras Endocrinol Metab vol.55 no.6 São Paulo Aug. 2011.
3. **Châu Hữu Hầu, Hia Kim Khuê, Đỗ Thị Quốc Trinh**. Hội chứng chuyển hóa ở nhân viện y tế trước và sau khi can thiệp. Y học Việt Nam, tập 488, tháng 10, số 2, 2019, tr 131-135.
4. **Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C, Ciucci A, Pede S, Porcellati C.** Ambulatory pulse pressure: a potent predictor of total cardiovascular risk in hypertension. Hypertension. 1998;32(6):983-8.
5. **Bloomfield D, Park A.** Night time blood pressure dip. World J Cardiol 2015 July 26; 7(7): 373-376.
6. Glynn RJ, Chae CU, Guralnik JM, **et al.** Pulse Pressure and Mortality in Older People. Arch Intern Med. 2000;160(18):2765-2772.
7. **DeMers D; Wachs D.** Physiology, Mean Arterial Pressure. **https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ NBK538226/?report=printable**.
8. Hsu **CH**, Chang **JB**, Liu **IC**, Lau **SC**, Yu **SM**, Hsieh **CH**, Lin **JD**, Liang **YJ**, Pei **D**, Chen **YL.** Mean Arterial Pressure Is Better at Predicting Future Metabolic Syndrome in the Normotensive Elderly: A Prospective Cohort Study in Taiwan. Prev Med, 2015 Mar;72:76-82.

ĐÁNH GIÁ THỊ LỰC VÀ ĐỘ KHÚC XẠ TỒN DƯ TRÊN 2 NHÓM BỆNH NHÂN SAU MỔ ĐỤC THUỶ TINH THỂ ĐẶT THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO

Trương Hoàng Nam

TÓM TẮT: Đánh giá về thị lực và khúc xạ trên 602 bệnh nhân tái khám 1 tháng sau phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phacoemulsification tại khoa mắt, bệnh viện Nhật Tân, từ tháng 3 đến tháng 7/ 2020. Tổng số mắt đã phẫu thuật là 867 mắt. Số bệnh nhân bị đái đường là 153, chiếm tỷ lệ 25,4%. Nhóm không đái đường có thị lực trung bình sau chỉnh kính cao hơn 2 hàng thị lực so với mắt của nhóm đái đường (mắt phải 8.49/10, mắt trái 8.35/10 so với mắt phải 6.61/10 và mắt trái 6.43/10). Số mắt có thị lực tốt 7/10 trở lên sau chỉnh kính ở nhóm không đái đường cao hơn nhóm có đái đường bình quân 40% (mắt phải 92,23%, mắt trái 97,69% so với mắt phải 54,16% mắt trái 42,59%). Ở nhóm thị lực dưới 7/10 sau phẫu thuật cần chỉnh kính là 23,9% bệnh nhân, thị lực sau chỉnh kính tăng trung bình mắt phải 4,08 hàng thị lực, mắt trái tăng 3,65 hàng thị lực. Độ khúc xạ tồn dư tối đa bình quân cầu là: viễn +0,91D cận -0,98D. Độ trụ là: viễn + 0.87D, cận - 1.22D.

Từ khóa: thị lực, độ khúc xạ tồn dư, độ cận, độ viễn, phương pháp mổ phaco

SUMMARY: Assessment of the visual acuity and the residual refraction error on 2 patient groups after phacoemulsification with intraocular lens (IOL) implantation.

Assessment of the visual acuity and the residual refraction on 602 patients re-examined 1 month after phacoemulsification with IOL implantation at Ophthalmology Department, Nhat Tan Hospital, from March to July 2020. Total 867 eyes operated. Number of patients with diabetes is 153, accounting for 25.4%. The non-diabetic group had 2 lines of visual acuity after correcting lenses higher than the eyes of the diabetic group (right eye 8.49/10, left eye 8.35/10 vs. right eye 6.61/10 and left eye 6.43/10). The number of eyes with good vision 7/10 or more after correcting glasses in the group without diabetes is 40% higher than the average group with diabetes (right eye 92.23%, left eye 97.69% compared to right eye 54.16 % left eye 42.59%). In the group of visual acuity less than 7/10 after surgery requiring correction lenses was 23.9% of patients, the visual acuity after correction has increased the right eye an average of 4.08 lines of vision, the left eye increases 3.65 lines of vision. The average maximum residual refractive error of spherical error was: hypermetropia + 0.91D, myopia -0.98D. Cylinder was: hypermetropia + 0.87D, myopia - 1.22D.

Key words: Visual acuity, residual refraction error, hypermetropia, myopia, phacoemulsification with intraocular lens (IOL) implantation.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Sau phẫu thuật đục thủy tinh thể (TTT) đặt TTT nhân tạo (IOL), ngoài vấn đề các biến chứng hậu phẫu thì thị lực sau phẫu thuật là mối quan tâm lớn nhất của người bệnh và thầy thuốc. Tuy nhiên có nhiều ca phẫu thuật rất tốt, không biến chứng, nhưng thị lực vẫn không đạt tối ưu, do nhiều lý do. Trong nghiên cứu này chúng tôi xem xét thị lực hậu phẫu trên 2 nhóm bệnh nhân có và không có đái tháo đường (ĐTĐ) về chênh lệch thị lực, độ khúc xạ tồn dư hậu phẫu để có hướng khắc phục.

TỔNG QUAN

Đục TTT là nguyên nhân chính gây mù trên toàn thế giới, theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới tỷ lệ mù này ở người lớn đến 51%, thậm chí một số cộng đồng người già ở Trung Quốc tỷ lệ này đến 60%. Phẫu thuật phaco là phương pháp điều trị chủ yếu để giải quyết vấn đề

mù lòa này. Một hậu phẫu phaco hoàn hảo trên mắt bình thường thì phải đạt thị lực nhìn xa 10/10, trong đó độ KX tồn dư nếu có tính theo độ cầu tương đương phải dưới 0,5 điop.

Biến chứng bệnh võng mạc ĐTĐ là một biến chứng nặng nề gây giảm thị lực dù cho phẫu thuật có hoàn hảo. Trong vài nghiên cứu của Việt Nam tỉ lệ biến chứng võng mạc ĐTĐ tupe I sau 5 năm từ 25-41%, sau 15 năm là 100% (6). Một nghiên cứu cắt ngang của Singapore trên 742 bệnh nhân từ 21 đến 92 tuổi tỉ lệ biến chứng võng mạc ĐTĐ là 38,1%. Trong đó đe dọa thị lực là 11,8%(7).

Sau một phẫu thuật phaco hoàn hảo, không tai biến, mắt bệnh nhân không có bệnh nền nhưng thị lực vẫn có thể không đạt tối ưu vì nhiều lý do. Trong đó yếu tố khúc xạ tồn dư được xem là vấn đề lớn. Tật khúc xạ tồn dư sau phẫu thuật phacô có nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan: vì sự biến dạng cấu trúc nhãn cầu như sự thay đổi bán kính cong giác mạc, vì sự thay đổi chiều dài trục nhãn cầu, sự thay đổi độ sâu tiền phòng và kể cả sự tính toán đo đạt không đúng công suất IOL. Trong đó sự thay đổi độ sâu tiền phòng 1mm đã làm thay đổi hơn 0,32 điop khúc xạ cận hoặc viễn thị.(2)(5)

Theo nhóm nghiên cứu của Pengcheng Zhang từ BMC Opthalmology 2020 cho thấy tình trạng khúc xạ sau mổ phaco được ổn định sau 1 tháng và độ khúc xạ tồn dư trung bình chênh lệch giữa 2 mắt là 0.76 điops (2).

MỤC TIÊU: Ghi nhận đánh giá thị lực sau mổ đục TTT. Đo chỉnh chính xác công suất TTT để đặt cho bệnh nhân. Đo chỉnh độ khúc xạ để nâng lên thị lực hậu phẫu tối ưu. Tính toán độ cầu và độ trụ tồn dư để có phương án điều chỉnh tốt hơn. Trong nhóm có ĐTĐ theo dõi thị lực để cảnh báo tầm soát bệnh VM ĐTĐ.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu:

- Bệnh nhân đã mổ đục TTT tại khoa mắt bệnh viện Nhật Tân, đặt IOL tái khám sau 1 tháng tại phòng khám mắt.
- Tiêu chuẩn loại trừ: mắt đã mổ đục TTT đặt IOL nhưng có bệnh về môi trường trong suốt gây giảm thị lực như sẹo giác mạc, tăng nhãn áp, bệnh võng mạc khác không do ĐTĐ và có biến chứng phẫu thuật…
- Phương tiện Phẫu Thuật: máy phẫu thuật Phaco OPTICON model PULSAR 2(Italy). kính hiển vi phẫu thuật TAKAGI seiko (Japan) máy zaval kế OF-M2(Brazil), máy siêu âm A Sonomed (USA), Máy đo khúc xạ tự động SHIN- NIPPON, bảng thị lực Logmax

Phương pháp phẫu thuật:

Bệnh nhân sau khi được chẩn đoán đục TTT, có chỉ định PT, được làm các xét nghiệm tiền phẫu, siêu âm mắt B, đo zaval bán kính cong giác mạc, đo siêu âm mắt A và tính công suất IOL.

Bệnh nhân được PT bằng phương pháp Phaco: dùng dao 2.8 tạo vết mổ đường hầm giác mạc, bơm nhầy xé bao trước liên tục, thủy tách nhân, phaco tán nhuyễn loại bỏ nhân, rửa hút sạch cortex, đặt IOL mềm trong bao, rửa sạch nhầy, đóng vết mổ tái tạo tiền phòng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, ghi nhận thị lực 2 nhóm bệnh có và không có ĐTĐ. Nhóm ĐTĐ được khoa nội tiết chẩn đoán có bệnh sử điều trị và lượng đường lúc khám. Những bệnh nhân thị lực dưới 7/10 được đo khúc xạ chỉnh kính và ghi nhận độ kính.

Thời gian nghiên cứu: Thời gian thực hiện 5 tháng, từ 01/03 đến 30/07 năm 2020.

Phân tích thống kê: Dùng SPSS 20.0 để phân tích số liệu. Dùng ANOVA để phân tích các biến trung bình thị lực-khúc xạ. Ý nghĩa thống kê khi $p<0,05$.

KẾT QUẢ:

Bảng 1. Nơi cư trú bệnh nhân:

STT	**Địa chỉ**	**N**	**Tỷ lệ %**
1	TP Châu Đốc	112	18.6
2	Huyện Tân Châu	73	12.1
3	Huyện An Phú	140	23.3
4	Huyện Châu Phú	124	20.6
5	Huyện Phú Tân	58	9.6
6	Huyện Tịnh Biên	40	6.6
7	Huyện Tri Tôn	15	2.5
8	Huyện Tỉnh khác	40	6.6
Tổng cộng		602	100.0

Bảng 2. Giới tính

Giới	**N**	**Tỷ lệ %**
Nữ	413	68,6
Nam	189	31,4
Tổng cộng	602	100,0

Bảng 3: Đặc điểm bệnh nhân và số mắt đã phẫu thuật:

BN đã PT		Đặc điểm BN ĐTĐ		Số mắt đã PT	
Không ĐĐ	Có ĐĐ	Đường huyết trung bình mg/dl	Số năm trung bình mắc ĐTĐ	MP	MT
449	153	152,25	6,868	455	412

Đường huyết trung bình không cao có lẽ do bệnh nhân được chọn để phẫu thuật đang điều trị đường ổn định trước phẫu thuật.

Bảng 4: Thị lực sau chỉnh kính trên 2 nhóm bệnh nhân.

	Không ĐTĐ		Có ĐTĐ	
	Mắt phải	Mắt trái	Mắt phải	Mắt trái
Số mắt đã phẫu thuật	335	304	120	108
Thị lực bình quân/10	8,49	8,35	6,61	6,43
Số mắt thị lực ≥7/10	309	297	65	46
Tỷ lệ %	92,2	97,7	54,2	42,6

Thị lực trung bình sau PT nhóm không ĐTĐ cao hơn nhóm ĐTĐ tương đương 2 hàng thị lực. Số thị lực tốt từ 7/10 trở lên sau chỉnh kính nhóm không ĐTĐ cao bình quân hơn nhóm ĐTĐ 40%.

Bảng 5: Số BN chỉnh kính, số mắt và số hàng thị lực tăng sau chỉnh kính trên 2 mắt

	Số Bn chỉnh kính	Số Mắt được chỉnh kính			Số hàng TL tăng	
	144/602	2M	MP	MT	MP	MT
Tổng	23,9%	58	50	61	4,08	3,65

Thị lực tăng trung bình sau chỉnh kính MP tăng 4,08 hàng thị lực. MT tăng 3,65 hàng thị lực.

Bảng 6: Thị lực những BN được chỉnh kính mắt phải

Thị Lực- Khúc xạ (108 Mắt phải)	Mean	t	p
Có kính	8.79±1.46	22.570	0.001
Không kính	4.71±1.82		

Bảng 7. Thị lực những BN được chỉnh kính mắt trái

Thị lực - khúc xạ (119 Mắt trái)	Mean	t	p
Có kính	8.67±1.52	20.820	0.001
Không kính	5.01±2.14		

Bảng 7: Độ Khúc xạ tồn dư

Độ cầu bình quân tối đa		**Độ trụ BQTĐ (loạn)**	
Cận	Viễn	Cận	Viễn
-0,98D	0,91D	-1,22	0,87

BÀN LUẬN

Thị lực trung bình sau PT ở nhóm không ĐTĐ cao hơn nhóm ĐTĐ bình quân hơn 2 hàng thị lực. Trong nghiên cứu này thị lực bình quân của nhóm ĐTĐ là MP 6.61/10 và MT 6.43/10 Điều này thể hiện một số bệnh nhân đã có tổn thương bệnh võng mạc ĐTĐ đi kèm, vì thời gian mắc bệnh ĐTĐ trung bình trong nhóm nghiên cứu này là 6,8 năm(trong đó nhiều bệnh nhân đã có thời gian mắc ĐTĐ đến 20 năm). theo Guidelines The Royal opthalmology 2013, tổn thương phù hoàng điểm trong bệnh võng mạc ĐTĐ đa số làm giảm thị lực xuống <6/10, trong đó tổn thương phù hoàng điểm có khi lên đến 6,9% (7). Đó là chưa kể nhiều biến chứng khác nữa của võng mạc đi kèm.

Về thị lực bình quân sau phẫu thuật so với nghiên cứu của Đỗ Như Hơn (1) và Phạm Hùng (3) thì tỉ lệ thị lực hậu phẫu bình quân đạt từ 7/10 trở lên là 67% và 60,7%. Cũng tương đương nghiên cứu của chúng tôi(71,7%) Trong khi đó của Nguyễn Quốc Toản, Lê Minh Thông (4) thì có kết quả cao hơn(82,9%)

Trong số thị lực thấp dưới 7/10 nhóm không ĐTĐ chỉnh kính thị lực rất tốt (92,23% - 97,69%), trong khi đó nhóm bị ĐTĐ thị lực tăng ít hơn (54,16%- 42,59%). Mức độ chênh lệch thị lực tốt giữa 2 nhóm sau chỉnh kính lên đến hơn 40%, nghĩa là nhóm không ĐTĐ có thị lực 7/10 trở lên đạt trên 90% số mắt PT, trong khi đó nhóm có ĐTĐ chỉ đạt thị lực tốt khoảng 50% số mắt đã PT. Điều này thể hiện sự giảm thị lực nhiều do biến chứng bệnh võng mạc ĐTĐ.

Tổng số bệnh nhân cần được chỉnh kính lên đến 23,9%. Trong đó bình quân số dòng thị lực tăng lên sau chỉnh kính là 3,65 đến 4,08 hàng thị lực, có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Điều này cho thấy độ khúc xạ tồn dư còn cao, trung bình cả độ cầu và trụ là +-1,0D . Cũng tương đương với nghiên cứu của Phạm Hùng (3) là 0,72 +- 0,34D. Tuy nhiên tỉ lệ mắt PT bị KX tồn dư còn nhiều. Điều này nói lên sự đo đạt công suất IOL chưa đạt tối ưu, còn nhiều sai

sót, sai sót này cũng có thể do yếu tố thiết bị máy móc, cũng có thể do kỷ thuật thực hành của nhân viên khoa mắt trong khi đo đạt IOL. Việc đo công suất IOL bệnh viện cũng nên sớm đầu tư máy IOL MASTER để có kết quả chính xác cao, tránh bớt tồn dư độ KX, đem lại kết quả thị lực hậu phẫu tốt hơn.

KẾT LUẬN

Trong số 602 bệnh nhân PT đục TTT đặt IOL, tổng số mắt đã PT 867. Số bệnh nhân không ĐTĐ là 449, có ĐTĐ là 153. Trong nhóm bệnh nhân không ĐTĐ thị lực trung bình sau PT có chỉnh kính cao hơn nhóm ĐTĐ là 2 hàng thị lực. Số mắt có thị lực tốt từ 7/10 trở lên sau chỉnh kính ở nhóm không ĐTĐ cao hơn nhóm ĐTĐ bình quân 40%. Số bệnh nhân cần chỉnh kính là 23,9%, bình quân thị lực tăng 3,65 đến 4.08 hàng ở mắt sau chỉnh kính. Độ khúc xạ tồn dư tối đa bình quân cầu là: viễn +0,91D cận -0,98D. Độ trụ là: viễn +0,87D cận – 1,22D.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Đỗ Như Hơn** : Kết quả can thiệp mổ đục thủy tinh thể trên 16 tỉnh thành Y học Việt Nam tháng 10 số 1-2013.(thị lực sau mổ tốt là 67%, TL tốt > 6/18)
2. **Pengcheng Zhang, Yuhuan Yang, Hong Yan, Jie Zhang and WeiJia Yan. Zhang et al.** BMC Opthalmology 2020.
3. **Phạm Hùng, Lê Thị Đông Phương, Phạm Tân Tiến, Nguyễn Thị hà Giang, Đặng Bích Thủy, Đinh Viết Nghĩa**. Hội nghị khoa học toàn quan chuyên ngành mắt lần thứ I, BV Trung Ương quân đội 108, năm 2003 (độ loạn sau PT 0,72+- 0,34D), thị lực sau mổ đạt >= 7/10 60,7%)
4. **Nguyễn Quốc Toản, Lê Minh Thông, Lê Minh Tuấn.** Đánh giá kết quả phẫu thuật đục thủy tinh thể tuổi già bằng phương pháp phaco kiểu xoay (Ozil Torsional) Y học Thực hành (739) số 10-1010 (thị lực sau mổ 1 tháng trên 8/10 là 82,9%)
5. **Jeevan S Ladi**. Prevention and corection of residual refactive errors after cataract surgery. Department of cataract and refractive surgery Maharashtra, India. 5/2017.
6. **Ngô Phương Nga, Chu Thị Hường, Nguyễn Kim Lương**. Biến chứng mạn tính ở ĐTĐ type 1. Tạp chí YHTH 9/2013.
7. **Marcus CC Lim,1MRCSEd, Shu Yen Lee,1FRCSEd, Bobby CL Cheng,1FRCSEd, Doric WK Wong,1FRCSEd, Sze Guan** "Diabetic Retinopathy in Diabetics Referred to a Tertiary Centre from a Nationwide Screening Programme" Ann Acad Med Singapore 2008;37:753-9.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH NỘI TỦY CÓ CHỐT SIGN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 121

Nguyễn Minh Phong
Bệnh viện Quân dân y TP.Cần Thơ

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Gãy thân xương đùi là một tổn thương hay gặp, do lực chấn thương mạnh. Đây là một tổn thương nặng, thường kết hợp với những tổn thương khác ở hệ vận động hoặc các cơ quan khác. Trong nhiều trường hợp nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, đúng phương pháp có thể để lại những di chứng kéo dài, làm chi thể bị tàn phế nặng nề, thậm chí có thể đe doạ tính mạng.

Tư liệu và phương pháp: Đối tượng nghiên cứu 41 BN gãy xương đùi, được điều trị bằng đóng đinh nội tủy SIGN, tuổi nhỏ nhất 18 tuổi, lớn nhất 70 tuổi. Các bệnh nhân được khám và chẩn đoán gãy kín, hở thân xương đùi được điều trị ổn định tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 121 – Quân khu 9 trong thời gian từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 04 năm 2015. Phương pháp nghiên mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu.

Kết quả: Tuổi tuổi nhỏ nhất 18 tuổi, lớn nhất 70 tuổi. Tỷ lệ nam 34 (82,9%) , tỷ lệ nữ 7 (17,1%). Thời gian phẫu thuật 45- 60 phút. Thời gian điều trị sau phẫu thuật từ 5 -7 ngày . Kết quả rất tốt và tốt: 96,2%.

Kết luận: Phẫu thuật đóng đinh chốt là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân: thời gian nằm viện ngắn, hồi phục nhanh, sớm trở lại làm việc, thẩm mỹ cao

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Gãy thân xương đùi là một tổn thương hay gặp, do lực chấn thương mạnh. Đây là một tổn thương nặng, thường kết hợp với những tổn thương khác ở hệ vận động hoặc các cơ quan khác. Trong nhiều trường hợp nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, đúng phương pháp có thể để lại những di chứng kéo dài, làm chi thể bị tàn phế nặng nề, thậm chí có thể đe doạ tính mạng.

Xương đùi là xương dài nhất, lớn nhất, bền nhất và chịu lực chính của cơ thể, xung quanh xương được bao bọc bởi các khối cơ dày, chắc và khỏe. Vì vậy khi gãy xương đùi, dưới tác động của lực chấn thương lớn và sự co kéo của các khối cơ nên các đoạn xương gãy di lệch rất lớn, rất khó nắn chỉnh và khó cố định vững chắc, dễ di lệch thứ phát. Thời gian để hình thành khối can xương vững chắc đủ để chịu lực tỳ nén, lực uốn bẻ lại khá dài. Do đó chỉ định điều trị gãy thân xương đùi bằng phẫu thuật gần như là chỉ định tuyệt đối.

Có nhiều phương pháp điều trị gãy thân xương đùi như: nắn chỉnh bó bột, kéo liên tục, nắn chỉnh và kết hợp xương bằng khung cố định ngoài, phẫu thuật kết hợp xương bên trong bằng nẹp vít, đinh nội tủy…Do đặc điểm về giải phẫu, chức năng cơ sinh học và tổn thương giải phẫu bệnh trong gãy thân xương đùi nên hầu hết các tác giả trong và ngoài nước hiện nay đều có xu hướng phẫu thuật kết hợp xương bên trong bằng nẹp vít hoặc đinh nội tủy. Phương pháp kết hợp xương bên trong cho phép sắp xếp các đầu gãy và mảnh gãy về vị trí giải phẫu, cố định vững chắc ổ gãy, tạo điều kiện cho quá trình liền xương và phục hồi chức năng sớm. Tuy vậy phương pháp kết xương bằng nẹp vít có nhược điểm như can thiệp phẫu thuật lớn, bộc lộ rộng làm ảnh hưởng đến các nguồn mạch nuôi xương, dẫn đến chậm liền xương, khớp giả, bật nẹp, nguy cơ nhiễm khuẩn cao… nên không phải là phương pháp tối

ưu trong điều trị gãy thân xương dài. Phương pháp đóng đinh nội tủy đã được nhiều tác giả trên thế giới đề cập đến, từ những năm 1940 Küntscher đã giới thiệu thế hệ đinh nội tủy đầu tiên mang tên ông cùng với các nguyên lý sinh học và các kỹ thuật đóng

Tuy vậy đinh nội tủy Küntscher còn bộc lộ một số nhược điểm, nên các tác giả khác đã không ngừng cải tiến, phát triển thêm những thế hệ đinh nội tủy mới có tính năng ưu việt hơn, trong đó đinh nội tủy có chốt được xem như là một phương tiện kết hợp xương bên trong lý tưởng nhất trong điều trị gãy thân xương đùi hiện nay. Ở Việt nam những năm gần đây, nhiều bệnh viện và các cơ sở y tế lớn đã sử dụng đinh nội tủy có chốt để điều trị gãy thân xương đùi (nhất là các gãy xương đùi không vững 1/3 trên, 1/3 dưới, gãy có mảnh rời…). Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 121 cũng đã áp dụng điều trị cho bệnh nhân gãy thân xương đùi bằng phương pháp này. Nhằm đánh giá kết quả và rút ra một số nhận xét về chỉ định và kỹ thuật trong điều trị gãy kín thân xương đùi tại bệnh viện tuyến Quân khu, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài **"Đánh giá kết quả điều trị gãy thân xương đùi bằng đinh nội tủy có chốt SIGN tại bệnh viện Quân Y 121"** với 2 mục tiêu:

1. Đánh giá kết quả điều trị gãy thân xương đùi bằng đinh nội tủy có chốt SIGN .

2. Nhận xét về chỉ định và kỹ thuật của phương pháp

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Qua nghiên cứu 41 BN gãy xương đùi, được điều trị bằng đóng đinh nội tủy SIGN, tuổi nhỏ nhất 18 tuổi, lớn nhất 70 tuổi. Các bệnh nhân được khám và chẩn đoán gãy kín, hở thân xương đùi được điều trị ổn định tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 121 – Quân khu 9 trong thời gian từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 04 năm 2015

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang không đối chứng hồi cứu kết hợp tiến cứu. Với các chỉ tiêu nghiên cứu:

Chỉ tiêu nghiên cứu: tuổi, giới, tỷ lệ, vị trí gãy, cỡ đinh, bắt chốt mổ, kỹ thuật mổ, thời gian phẫu thuật, thời gian tập vận động, thời gian nằm viện, tai biến và biến chứng.

Tiêu chuẩn phân loại kết quả phục hồi chức năng theo Ter-schiphort.

Mức độ	**Mức độ liền xương**	**Đau tại các khớp cổ chân, gối**	**Vận động khớp gối**	**Vận động khớp cổ chân**	**Teo cơ vùng đùi**
Rất tốt	Liền xương vững, thẳng trục như xương lành	Không đau	Bình thường	Bình thường	Không
Tốt	Liền xương vững nhưng còn di lệch mở góc ra ngoài, ra trước < 5^0, vào trong, ra sau < 10^0, ngắn chi < 1cm	Đau khi gắng sức	Gấp gối 90 - 120^0, duỗi 0 - 10^0	Gấp mu = 0^0	Không đáng kể
Trung bình	Liền xương di lệch quá mức trên	Đau liên tục nhưng chịu được	Gấp < 90^0,duỗi > 10^0	Chân thuổng	Teo cơ nhiều
Kém	Không liền xương hoặc liền xương ở mức trung bình + di lệch xoay	Đau liên tục không chịu được	Cứng khớp	Cứng khớp	Teo cơ nhiều

- Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1. *Liên quan giữa tuổi và giới (n= 41).*

Tuổi	Nam	Nữ	Tổng	Tỉ lệ (%)
18 - 30	22	01	23	**56.1%**
31- 50	10	03	13	**31,7%**
>51	02	03	5	**12.2%**
Tổng cộng	**34**	**07**	**41**	**100%**

Nhận xét: Trong 41 BN gãy xương đùi, được điều trị đóng đinh nội tủy SIGN, tuổi nhỏ nhất 18, lớn nhất 70 tuổi.Đa số các trường hợp đều trong lứa tuổi lao động, trong đó lứa tuổi từ 18-30 chiếm tỉ lệ cao nhất (56,1%).Tỷ lệ gãy xương đùi của giới nam/nữ = 34/7 (82.1%)

3.1.2. Nguyên nhân chấn thương

Tai nạn giao thông: 33/41 trường hợp chiếm tỷ lệ 80.5%
Tai nạn lao động: 3/41 trường hợp chiếm tỷ lệ 7.3%
Tai nạn sinh hoạt: 5/41 trường hợp chiếm tỷ lệ 12.2%

3.1.3. Vị trí đường gãy

Bảng 3.2. *Phân loại theo vị trí gãy (n = 41).*

Vị trí xương gãy	Gãy 1/3T	Gãy 1/3 G	Gãy 1/3 D	Tổng cộng
Số lượng	12	25	4	41
Tỷ lệ %	29.2%	60.1%	10.7%	100%

Trong 41 BN, chúng tôi nhận thấy gãy 1/3G chiếm tỉ lệ cao 25/41 (60.1%), tiếp đến là gãy 1/3T là 12/41 (29.2%).

Bảng 3.3. *Tổn thương kết hợp (n = 41)*

Tổn thương kết hợp	Số BN	Tỉ lệ (%)
CTSN	5	12.2%
Sốc chấn thương	2	4.8%
Chấn thương bụng kín + CTSN	1	2.4%
Gãy xương bánh chè cùng bên	2	4.8%
Gãy cẳng chân cùng bên	3	7.3%
Khác (gãy lại)	3	7.3%
Không có tổn thương kết hợp	25	60.1%
Tổng cộng	41	100%

Trong 41 BN gãy thân xương đùi được phẫu thuật, thì tỷ lệ gãy xương đùi đơn thuần, không có tổn thương kết hợp chiếm 25/41 trường hợp (60.1%), sau đó là tổn thương xương đùi kết hợp với CTSN 5/41 trường hợp (12.2%), các trường hợp CTSN tùy mức độ, sau khi đã điều trị ổn định, chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật kết hợp xương đùi, thường phẫu thuật 10 – 14 ngày. Có 1 trường hợp chấn thương bụng kín, dập phân thùy gan, vỡ tạng rỗng, kết hợp CTSN, chưa có chỉ định phẫu thuật, chúng tôi tiến hành điều trị bảo tồn và phẫu thuật ở tuần thứ 4, khi bệnh nhân đã ổn định về bụng ngoại khoa cũng như CTSN. Các trường hợp BN có sốc, chúng tôi điều trị ổn định, thoát sốc, các chỉ số M, HA ổn định, chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật kết xương. Các trường hợp gãy xương nhỏ cùng với xương đùi, chúng tôi xử trí bằng PT sau khi kết xương đùi hoặc điều trị bảo tồn.

3.2. Thời điểm phẫu thuật

Trong 41 trường hợp gãy kín thân xương đùi được phẫu thuật kết xương bằng đinh SIGN thì có 35/41 được chúng tôi kéo liên tục trong thời gian chuẩn bị phẫu thuật. Có 32/41 trường hợp được phẫu thuật trong 2 - 5 ngày đầu sau khi gãy xương.

Thời điểm phẫu thuật sớm nhất là từ ngày 2, muộn nhất là ngày 32 của bệnh.

Các trường hợp phẫu thuật muộn là do có tổn thương kết hợp. Chúng tôi xử trí các tổn thương kết hợp ổn định, đảm bảo an toàn trong PT, mới tiến hành PT.

3.3. Kết quả điều trị

3.3.1. Kết quả gần

Diễn biến tại vết mổ:

Có 41/41BN liền vết mổ kỳ đầu, không có trường hợp nào bị nhiễm khuẩn vết mổ nông, sâu. Không bị nhiễm khuẩn vết mổ là do khâu chuẩn bị bệnh nhân tốt và chúng tôi dùng khánh sinh dự phòng trước mổ, quan trọng nữa là khâu vô trùng của phòng mổ tốt.

Kết quả chỉnh trục xương:

Kết quả chỉnh trục xương đánh giá dựa trên hình ảnh Xquang sau phẫu thuật ở hai tư thế thẳng và nghiêng.

Các tai biến, biến chứng và sai sót trong phẫu thuật:

Trong 41 thân xương đùi gãy được đóng đinh SIGN từ đầu trên xương đùi xuống có mở ổ gãy, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào bị vỡ xương hoặc kẹt đinh trong khi phẫu thuật. Không có trường hợp nào đinh quá dài hoặc quá ngắn. Không có trường hợp nào khoan làm vỡ đỉnh mấu chuyển lớn.

Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, có những bệnh nhân chúng tôi mổ đường mổ quá dài để lại sẹo, gây ảnh hưởng đến thẩm mỉ và quá trình tập vận động phục hồi chức năng của người bệnh.

3.3.2. Kết quả sau 6 tháng

Đánh giá kết quả xa dựa vào thời gian sau phẫu thuật trên 6 tháng

** Thời gian theo dõi:*

Bảng 3.4. *Phân bố thời gian kiểm tra kết quả (n = 41)*

Thời gian theo dõi (tháng)	Số ca	Tỉ lệ (%)
<6 tháng	15	36,5
6 – 12 tháng	17	41,5
>12 tháng	9	22,0
Tổng cộng	**41**	**100 %**

Chúng tôi theo dõi đánh giá kết quả xa được 26/41 BN , theo dõi kết quả xa với thời gian sau phẫu thuật trên 6 tháng, thời gian theo dõi dài nhất là 16 tháng. Trong đó chúng tôi đã phẫu thuật rút đinh được 2 trường hợp, 2 trường hợp đều cho kết quả tốt về liền xương.

** Tình trạng vết mổ*

Trong suốt thời gian theo dõi bệnh nhân, không có trường hợp nào bị viêm rò vết mổ

**Kết quả liền xương tại ổ gãy:*

Tất cả 26 trường hợp được phẫu thuật trên 6 tháng đều liền xương. Có 3 trường hợp liền xương còn di lệch ít và không có trường hợp nào bị di lệch thứ phát sau phẫu thuật.

**Kết quả phục hồi vận động khớp háng:*

Trong 26 trường hợp được đánh giá kết quả sau 6 tháng không có trường hợp nào bị hạn chế vận động khớp háng.

Có 1 trường hợp hạn chế vận động khớp gối, BN này bị tổn thương kết hợp, CTSN+ gãy xương bánh chè, nằm bất động lâu và ngại tập vận động.

3.4. Kết quả chung

41 thân xương đùi gãy kín được điều trị bằng phương pháp đóng ĐNTCC (SIGN) từ đầu trên xương đùi xuống, có mở ổ gãy, khoan ống tủy. Có 26 trường hợp được đánh giá kết quả sau 6 tháng, mỗi trường hợp bị gãy 1 xương đùi, với các loại gãy và vị trí gãy khác nhau ở 1/3T, 1/3G và 1/3D xương đùi. Đánh giá kết quả chung dựa theo tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị của Larson – Bostman và tiêu chuẩn phục hồi chức năng của **Ter – Schiphort**, chung tôi có kết quả chung sau.

Bảng 3.5. *Kết quả chung (n = 26)*

Kết quả	Số BN	Tỉ lệ (%)
Rất tốt	21	**81.4%**
Tốt	4	**14,8%**
Trung bình	1	**3.7%**
Kém	-	**0%**
Tổng cộng	**26**	**100%**

Trong 26 trường hợp đủ thời gian đánh giá kết quả sau 6 tháng có 25/26 trường hợp đạt kết quả tốt và rất tốt. Có 1 trường hợp kết quả trung bình, đây là trường hợp bị hạn chế gấp gối. Bệnh nhân gấp gối chưa được quá 90º.

4. BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm về tuổi, giới, nguyên nhân gãy xương đùi

Gãy thân xương đùi là tai nạn hay gặp, ở mọi lứa tuổi, nhưng hay gặp nhất ở lứa tuổi lao động. Trong nghiên cứu này, bệnh nhân trẻ nhất là 18 tuổi, cao tuổi nhất là 70 tuổi, trong đó lứa tuổi từ 18 đến 30 chiếm tỉ lệ cao hơn . Đây là độ tuổi lao động, hoạt động đi lại nhiều, nên xác suất gặp phải tai nạn thường cao, kết quả của chúng tôi nghiên cứu phù hợp với kết quả nghiên cứu của một số tác giải khác.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, TNGTcó 33/41 trường hợp chiếm tỷ lệ 80.5%. **Nguyễn Xuân Lành** (1995) gặp gãy thân xương đùi do TNGT là 71.4%, **Nguyễn Trọng Hiếu** (2001) là 90.03%.

Cùng với đó bệnh nhân còn bị tổn thương kết hợp, trong nghiên cứu của chúng tôi hay gặp CTSN. Đây là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn phương pháp điều trị và kết quả liền xương. Điều này cũng phù hợp với nguyên nhân gây gãy xương chủ yếu là do TNGT (là nguyên nhân gây đa tổn thương và đa chấn thương).

4.2. Lựa chọn phương pháp điều trị

Có rất nhiều phương pháp điều trị gãy kín thân xương đùi: như điều trị bảo tồn (bó bột, xuyên đinh kéo liên tục…), kết xương CĐN, kết hợp xương bằng nẹp vít, kết xương bằng

đinh nội tủy. Mỗi phương pháp điều trị đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, việc chọn lựa phương pháp điều trị hợp lý thì phải dựa vào nhiều yếu tố như: mức độ tổn thương xương (vị trí gãy, tính chất đường gãy), thương tổn phần mềm, tình trạng sức khỏe người bệnh, trang thiết bị của cơ sở y tế hiện có và trình độ của phẫu thuật viên.

Phương pháp nắn chỉnh và bó bột điều trị gãy kín thân xương đùi hiện nay thường áp dụng để điều trị cho trẻ em, không chỉ định cho người lớn vì ổ gãy di lệch lớn, khó nắn chỉnh và thường gây di lệch thứ phát sau bó bột dẫn đến chậm liền xương, khớp giả, liền lệch. Mặt khác để duy trì đủ thời gian liền xương thì hầu như không thể tránh khỏi các biến chứng teo cơ, cứng khớp, loãng xương… Ngoài ra phương pháp này còn gây ra nhiều biến chứng do nằm lâu dẫn đến: loét điểm tỳ, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, … Nghiên cứu của **Webb L.X**. và cộng sự cho thấy thời gian bó bột để cho xương đùi liền vững là 34 tuần, trong khi đó chỉ cần 18 tuần xương đùi đã liền vững khi được kết xương bằng ĐNT có chốt.

Phương pháp điều trị bảo tồn bằng kéo liên tục đã được áp dụng trong điều trị gãy thân xương đùi nhưng kết quả đạt được không cao, chăm sóc phức tạp, nằm lâu trên giường bệnh và phục hồi chức năng kém do bất động lâu. Ngày nay, phương pháp này thường dùng cố định tạm thời ổ gãy, kéo dãn để giảm mức độ di lệch chồng và giảm đau để chuẩn bị cho phẫu thuật kết hợp xương. Trong quá trình điều trị, chúng tôi thường áp dụng phương pháp này khi BN mới nhập viện đến khi chuẩn bị đầy đủ phương tiện thì tiến hành PT theo chương trình.

Phương pháp kết xương bằng CĐN thường áp dụng trong gãy xương hở đến muộn hoặc gãy hở độ III. Tuy nhiên khác với ở cẳng chân, CĐN ở xương đùi rất bất tiện trong sinh hoạt và chăm sóc nên ngày nay có xu hướng chuyển từ CĐN vào kết xương bên trong khi vết thương ổn định, không còn nguy cơ nhiễm khuẩn. Cố định ngoài có tác dụng tốt trong giữ được độ dài và trục của chi gãy, thuận lợi cho chăm sóc vết thương **Phạm Đăng Ninh (2000)**. Tuy nhiên phương pháp này có một số nhược điểm như cồng kềnh, dễ nhiễm khuẩn chân đinh nếu không chăm sóc tốt gây lỏng đinh làm mất tác dụng cố định, cồng kềnh, vướng víu của CĐN đã gây khó khăn trong sinh hoạt và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Do đó CĐN không phải là phương pháp được lựa chọn trong điều trị gãy kín thân xương đùi.

Phương pháp kết hợp xương nẹp vít (có giai đoạn được xem như là một cuộc cách mạng trong mổ kết hợp xương) được sử dụng phổ biến ở thập niên 60 và 70 bởi nhóm AO, là một trong những phương pháp kết hợp xương cố định ổ gãy vững chắc và được áp dụng ở nhiều vị trí và tính chất đường gãy của thân xương đùi 1/3T, 1/3D, đặc biệt là gãy không vững (gãy chéo vát dài, gãy xoắn, gãy có mảnh rời, gãy hai tầng…) và mang lại kết quả liền xương cao. **Mahmood T**. và cộng sự điều trị cho 40 trường hợp bị gãy phức tạp thân xương đùi (20 trường hợp được kết hợp xương bằng nẹp vít). Thời gian liền xương trung bình là 17,5 tuần, tỉ lệ liền xương đạt 90%, 2 trường hợp không liền xương.

Khi kết xương bằng ĐNT thì đinh chịu lực trung tâm, cân bằng được các cơ, khi bệnh nhân tập đi thì lực tỳ nén áp sát hai mặt gãy sẽ giúp cho liền xương được thuận lợi hơn. Theo nghiên cứu của **Richar R.T**. cho thấy ĐNTCC có thể chịu lực được 300 – 400% trọng lượng của cơ thể, trong khi đó với trọng lượng 200 – 300% cơ thể thì nẹp vít đã bị cong, thậm chí bị gãy. Kết xương đùi bằng nẹp vít thì đường mổ dài, bóc tách nhiều mô mềm và lóc cốt mạc rộng trên cả đoạn xương, làm giảm nguồn máu đến xương nên nguy cơ nhiễm khuẩn cao, dễ bị chậm liền xương, lỏng vít, bong nẹp. Đến nay phương pháp này vẫn được áp dụng đan xen trong điều trị gãy thân xương đùi (trường hợp gãy thấp không có chỉ định đóng đinh nội tủy). Vì vậy phương pháp kết hợp xương bằng nẹp vít dần dần thu hẹp. Gần đây, để hạn chế các nhược điểm của nẹp vít, loại nẹp mới (nẹp khóa) đã được nghiên cứu và

ứng dụng trong lâm sàng. Tuy nhiên loại nẹp này vẫn chủ yếu được chỉ định cho gãy đầu xương, giá thành cao lên vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi.

ĐNTCC ra đời đã đáp ứng tốt các yêu cầu trong điều trị gãy thân xương dài, nhất là xương đùi và xương chày. ĐNTCC có thể được chỉ định cho gãy thân xương đùi không vững.

4.3. Chỉ định

4.3.1. Chỉ định theo vị trí gãy

Phương pháp kết xương bằng ĐNTCC điều trị gãy kín thân xương đùi có ưu điểm cố định ổ gãy vững chắc, chống được di lệch xoay, di lệch chồng nhờ các vít chốt cố định ở hai đầu ổ gãy.

Do phương pháp kết xương bằng đinh Küntscher chỉ áp dụng được cho gãy thân xương đùi ở vị trí 1/3 G với đường gãy ngang hoặc gãy chéo vát ngắn. Như vậy nếu chọn phương pháp kết xương bằng đinh Küntscher thì không thể chỉ định cho các loại gãy ở vị trí 1/3 G với đường gãy chéo vát dài, gãy có mảnh rời, gãy nhiều tầng, gãy ở 1/3T hoặc 1/3D. Do đó nếu dùng đinh Küntscher đơn thuần thì phải bó bột thêm một thời gian.

Ling H. T., Kwan M. K. và cộng sự báo cáo 88 trường hợp bị gãy ở 1/3 G thân xương đùi loại I và II theo Winquist được điều trị bằng đinh nội tủy Küntscher. Kết quả: tỉ lệ liền xương đạt 97,7%, 1 trường hợp bị nhiễm khuẩn và 2 trường hợp không liền xương, thời gian liền xương trung bình là 16 tuần. Tác giả kết luận: kết xương bằng đinh Küntscher điều trị cho gãy 1/3 G xương đùi loại I và II theo Winquist có tỉ lệ liền xương cao và ít biến chứng. Các vị trí gãy xương đùi ở 1/3 T, 1/3 D với đường gãy vững thì đinh Küntscher cũng không đảm bảo vững chắc vì không chống được di lệch xoay.

Chỉ định kết xương bằng ĐNTCC rất tốt trong những trường hợp gãy 1/3T, 1/3D thân xương đùi với các hình thái gãy (gãy chéo vát, gãy có mảnh rời…). Đinh có tác dụng chống xoay tốt, ổ gãy được cố định vững chắc, ổn định về mặt cơ sinh học tạo điều kiện thuận lợi cho ổ gãy nhanh liền xương và BN có thể tập vận động sớm, phục hồi chức năng nhanh hơn

Năm 2004, **Hàn Khởi Quang** đã điều trị cho 21 trường hợp bị gãy 1/3T xương đùi, trong đó có 19 trường hợp gãy không vững, 5 trường hợp gãy vững và 2 trường hợp gãy 2 tầng, các bệnh nhân được kết xương bằng đinh SIGN từ đầu trên xương đùi xuống, kết quả đạt tốt.

Có 2 xương đùi bị gãy ở 1/3D, đường gãy tương đối phức tạp (type II) được chúng tôi bắt vít chốt 2 đầu, trong đó có 1 trường hợp liền xương di lệch ít do từ khi kết xương chưa nắn chỉnh hết di lệch.

Bằng đinh SIGN, chúng tôi đã kết hợp xương vững chắc ổ gãy, trục chi thẳng và không cần phải bó bột hay đặt nẹp sau PT. Phương pháp kết xương bằng đinh Küntscher thì không thể chỉ định cho các vị trí gãy ở 1/3T và 1/3D. Phương pháp kết hợp xương nẹp vít có thể chỉ định trong các trường hợp gãy không vững ở các vị trí 1/3T và 1/3D nhưng phải bóc tách phần mềm rộng và lóc cốt mạc trên cả đoạn xương đặt nẹp vít, ảnh hưởng đến khả năng liền xương tại ổ gãy và nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

ĐNTCC chỉ định rất tốt trong những trường hợp gãy ở 1/3G thân xương đùi với các hình thái đường gãy chéo vát dài, gãy có mảnh rời. Trong 41 xương đùi bị gãy được phẫu thuật, có 30 xương đùi bị gãy tại 1/3G (gãy type I có 14 xương đùi, gãy type II có 13 xương đùi, gãy type III có 2 xương đùi, gãy type IV có 1 xương).

Trong 41 xương đùi bị gãy chúng tôi phẫu thuật bắt vít chốt chốt 2 đầu. Đinh Küntscher có thể chỉ định trong các trường hợp gãy 1/3G với đường gãy ngang hoặc chéo vát ngắn nên các trường hợp gãy có mảnh rời lớn nếu dùng đinh Küntscher thì phải bó bột tăng cường. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi chức năng sớm cho người bệnh.

4.3.2. Chỉ định theo tính chất đường gãy

Trong 41 chi bị gãy kín thân xương đùi, chúng tôi có thể sử dụng phương pháp kết xương không mở ổ gãy nhưng do không có đủ điều kiện trang bị nên chúng tôi phải mở ổ gãy để nắn chỉnh và kết xương.

Đây là các trường hợp gãy xương có mảnh lớn dưới 50 % chu vi vỏ xương. Các trường hợp này cũng có thể kết xương không mở ổ gãy nếu có đủ trang bị, tuy nhiên cần thận trọng để không bị kẹt mảnh xương vào trong lòng ống tủy. Do chưa đủ trang thiết bị nên chúng tôi mở ổ gãy, vì vậy không có hiện tượng kẹt mảnh xương trong ống tủy. Loại gãy này trước đây dùng đinh Kuntcher nhưng có nguy cơ cong và gãy đinh.

4.3.3. Chỉ định khi có tổn thương kết hợp

** Bệnh nhân có CTSN*

Trong 41 BN có 5 trường hợp bị CTSN kèm theo với gãy thân xương đùi. Trong các trường hợp này hoặc BN bị chấn động não, hoặc có ổ máu tụ nhỏ dưới màng cứng hoặc khoang dưới nhện, dập não ổ nhỏ ... (xác định bằng CT Scanner) không có chỉ định PT sọ não. Chúng tôi xuyên đinh kéo liên tục tại giường, điều trị tích cực bằng bất động, giảm đau, chống phù não, theo dõi sát tình trạng tri giác theo thang điểm Glassgow đến khi tỉnh táo hoàn toàn và chụp cắt lớp vi tính sọ não kiểm tra bình thường thì mới tiến hành PT kết hợp xương.

Vấn đề quan trọng nhất là ưu tiên cứu sống người bệnh, nếu PT sớm mà bệnh nhân chưa ổn định về tổn thương sọ não thì cuộc PT sẽ làm tổn thương sọ não nặng thêm. Cả 5 BN có CTSN, chúng tôi đều tiến hành PT kết xương đùi sớm nhất là sau 3 tuần điều trị ổn định sọ não.

** Bệnh nhân có chấn thương bụng*

Có 1 trường hợp bị gãy thân xương đùi kèm theo chấn thương bụng kín, tổn thương gan và thủng tạng rỗng, đã được xác định bằng siêu âm và chụp CT Scanner, không có chỉ định PT mở vào ổ bụng, chúng tôi tiến hành điều trị bảo tồn chấn thương bụng kín, xương đùi được xuyên đinh kéo liên tục, theo dõi sát trong hai tuần, bệnh nhân hoàn toàn ổn định về chấn thương bụng kín (bằng khám xét lâm sàng và các xét nghiệm chẩn đoán), chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật kết xương.

** Bệnh nhân bị gãy xương đùi, xương chày, xương bánh chè*

Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi, có 3 BN bị gãy kín xương chày và 2 trường hợp gãy xương bánh chè cùng bên do TNGT. Chúng tôi đã tiến hành phòng chống sốc ngay từ lúc vào viện, sau đó kéo liên tục qua đầu trên xương chày đối với gãy xương bánh chè, kéo qua xương gót đối với gãy xương chày. Cho đến khi bệnh nhân hoàn toàn ổn định chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật kết hợp xương đùi và xương chày, bánh chè cùng lúc. Sau PT, bệnh nhân ổn định, vết mổ liền kỳ đầu.

5. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu 41 trường hợp gãy kín thân xương đùi được phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh nội tủy có chốt SIGN tại Bệnh viện Quân Y 121 từ tháng 9/2013 – 04/2015, chúng tôi rút ra một số nhận xét: + Kết quả: Liền vết mổ kỳ đầu 100%, 40 trường hợp hết di lệch (97,6 %), 1 trường hợp di lệch ít (2,44 %), phục hồi hoàn toàn vận động khớp háng là 100% và phục hồi hoàn toàn vận động khớp gối là 97,6 %, - Kết quả chung: Rất tốt 21 trường hợp (81,4 %), tốt 4 trường hợp (14,8%), trung bình 1 trường hợp (3,7%), không có kết quả kém. + Chỉ định: gãy 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới, gãy phức tạp, gãy chéo vát, gãy có

đoạn trung gian thân xương đùi, + Kỹ thuật: + Xác định đúng điểm vào xương khi đóng đinh là ½ sau đỉnh mấu chuyển lớn.

Phẫu thuật đóng đinh chốt là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân: thời gian nằm viện ngắn, hồi phục nhanh, sớm trở lại làm việc, thẩm mỹ cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Nguyễn Tiến Bình** (2003): "*Phương pháp kết xương đinh nội tủy kín". Một số vấn đề cơ bản trong chấn thương chỉnh hình, tài liệu tập huấn nâng cao cho cán bộ chuyên khoa tuyến trước, tr. 167 – 176*.

2.**Nguyễn Trọng Hiếu** (2001), "Đánh giá kết quả phẫu thuật đóng đinh nội tủy kín điều trị gãy thân xương đùi người lớn", *Luận văn thạc sỹ, Học Viện Quân Y – Hà Nội.*

3. **Nguyễn Xuân Lành**: Nhận xét kết quả điều trị phẫu thuật 270 trường hợp gãy kín thân xương đùi ở người lớn do chấn thương. *Luận văn Thạc sĩ Y học – Học viện Quân y.*

4. **Nguyễn Tiến Linh** (2003*),* "Điều trị gãy thân xương đùi bằng đinh nội tủy có chốt dưới màn hình tăng sáng". *Luận án chuyên khoa II.*

5. **Phạm Đăng Ninh** (2000), "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cố định ngoài một bên bằng cọc ép răng ngược chiều trong điều trị gãy mở hai xương cẳng chân*", Luận án tiến sỹ y học – Hà Nội.*

6. **Hàn Khởi Quang** (2004), "Đóng đinh SIGN xuôi dòng điều trị gãy 1/3 T thân xương đùi tại BVĐK Bình Dương", *Hội nghị thường niên hội chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh*, lần thứ 11-2004.

7. **Nguyễn Thành Tấn** (2005), "Đánh giá kết quả điều trị gãy thân xương đùi bằng đinh SIGN", *Luận văn thạc sỹ Y học - Học Viện Quân y – Hà nội*

8. **Nguyễn Thế Thử** (2009), "Điều trị phẫu thuật gãy kín 1/3 dưới thân xương đùi bằng đinh nội tuỷ Küntscher cải biên", *Tạp chí Y Dược học Quân sự HVQY*, số 34/2009, tr. 108 - 111.

9. **Christian Krettek** (2001): "Intramedullary nailing", AO principles of fracture management, pp. 195 – 219

10. **Lewis G. Zirkle Jr, M.D** (2008): Technique Manual of SIGN IM Nail and Interlocking Screw System Insertion and Extraction Guid.

11. **Ling H.T., Kwan M. K. et al.** (2008), "Use of Unlocked Intramedullary Nailing in Winquist Type I and II Femoral Isthmus Fracture", *Malaysian Orthopaedic Journal*, Volume 2, No.1, pp 17-22.

12. **Mahmood T. et al.** (2009), "Comminuted fractures of shaft of femur; Bridge plate versus interlocking nail in low velocity gun shot injuries", *Professional Med Journal*, Vol. 16, No. 3, pp 351-356.

13. **Ter - Schiphort** (1987), Fracture et pseudarthros de Jambes traitées par fixatenr d'Hoffmanen cadrae, bilan informatise de 200 cases sur 17 and d'experience, These medecine, Montpellier, June 1987.

14. **Richard R. Tarr, Donald v. Wiss** (1985) "The mechanics and biology of intramedullary fracture fixation", *Clinical orthopaedics and relatec research, 212*, pp. 10 – 17.

15. **Webb L.X., Gristian A.G., Fowler H.L,** (1998) "Unstable femoral shaft fractures: a comporision of interlocking nailing versus traction and casting methods", *J Orthop Trauma, 2(1*), pp. 10 – 12.

16. **Winquist R. A., Hansen S. T. et al.** (1984), "Closed intramedullary nailing of femoral fracture. A report of five hundred and twenty cases", *Journal Bone Joint Surg*, Vol. 66, pp 529-539.

TỶ LỆ MẮC ĐTĐTK Ở BỆNH VIỆN NHẬT TÂN

Dương Thị Nhan, Ngụy Khiêm Thắng, Trịnh Thanh Nhung,
Nguyễn Thị Huệ, Trương Thanh Thanh

TÓM TẮT

Mục tiêu: Tìm hiểu về tỷ lệ ĐTĐTK và một số các yếu tố nguy cơ trên 223 thai phụ tại bệnh viện đa khoa Nhật Tân. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tất cả các thai phụ đến khám thai và sanh tại bệnh viện Nhật Tân trong 23 tháng từ tháng 8/2018 đến ngày tháng 7/2020. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu. Kết quả nghiên cứu: ĐTĐ thai kỳ 23,3% và ĐTĐ mang thai là 2,2%. Kết luận: Tỷ lệ ĐTĐTK và ĐTĐ mang thai là một thực tế ngày càng trở nên quan trọng cho sức khỏe thai phụ và thai nhi mà thầy thuốc và cộng đồng phải cùng nhau khắc phục.

Từ khóa: đái tháo đường, đái tháo đường mang thai**.**

ABSTRACT

Objective: To find out about the prevalence of diabetics and some risk factors per 223 pregnant women at Nhat Tan General Hospital. **Method**: all pregnant women who came for antenatal care and give birth at Nhat Tan Hospital for 23 months from August 2018 to July 2020. **Research method**: prospective study. **Results**: Prevalence of gestational diabetes was 23.3% and diabetes mellitus in pregnancy was 2.2%. **Conclusion**: The prevalence of diabetes mellitus in pregnancy and gestational diabetes is actually an increasingly important fact for the health of pregnant women and fetuses that doctors and the community have to overcome together.

Key works: Gestational Diabetes, Diabetes mellitus in pregnancy.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường trong thai kỳ đang gia tăng ở khắp nơi trên thế giới. Không chỉ tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 1 và bệnh tiểu đường loại 2 đang gia tăng ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản mà ĐTĐTK cũng gia tăng khá ấn tượng. Bệnh tiểu đường gây ra nhiều nguy cơ cho bà mẹ và thai nhi và thường liên quan đến mức tăng đường huyết nhưng cũng liên quan đến các biến chứng mạn tính và bệnh đi kèm của bệnh tiểu đường. Nói chung, các nguy cơ cụ thể của bệnh tiểu đường trong thai kỳ bao gồm sảy thai tự nhiên, dị tật thai nhi, tiền sản giật, thai chết lưu, thai to, hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh, tăng bilirubin trong máu và hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, trong một số khác. Ngoài ra, bệnh tiểu đường trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ béo phì, cao huyết áp và bệnh tiểu đường loại 2 ở con cái sau này trong cuộc sống [1].

Các thai phụ bị ĐTĐTK cần được điều trị. Các thử nghiệm ngẫu nhiên đã cho thấy một chương trình điều trị dinh dưỡng, tự theo dõi đường huyết, liệu pháp insulin, khi cần thiết, sẽ cải thiện kết quả chu sinh (giảm tiền sản giật, bệnh thai to, sanh kẹt vai)[2].

Ngoài ra, thai phụ mắc ĐTĐTK nên tập thể dục vừa phải nếu không có chống chỉ định. Đối với những phụ nữ không kiểm soát được đường huyết với liệu pháp dinh dưỡng và thể dục, nên điều trị thuốc hạ đường huyết, tốt nhất là insulin. Glyburide hoặc metformin là một sự thay thế hợp lý cho những phụ nữ không dùng insulin. Tác dụng lâu dài của việc truyền qua nhau thai của các thuốc hạ đường huyết uống chưa rõ [2].

Phụ nữ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ có nhiều nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sau khi mang thai. Nên kiểm tra ĐTĐ thường xuyên cũng như các biện pháp can thiệp lối sống (cân nặng hợp lý, các hoạt động thể chất phù hợp) [2].

Nhìn chung, Trung Đông và Bắc Phi có tỷ lệ phổ biến GDM cao nhất với mức trung bình ước tính 12,9% (dao động 8,4–24,5%), tiếp theo là Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, Nam và Trung Mỹ, Châu Phi và Bắc Mỹ và Caribe (tỷ lệ hiện mắc trung vị lần lượt là 11,7, 11,7, 11,2, 8,9 và 7,0%), trong khi Châu Âu có tỷ lệ hiện mắc thấp nhất (trung vị 5,8%; khoảng 1,8–22,3%). Trong khu vực Tây Thái Bình Dương, ước tính tỷ lệ hiện mắc có phạm vi rộng từ 4,5% ở Nhật Bản đến 25,1% ở Singapore, với các tiêu chí chẩn đoán GDM khác nhau đã áp dụng [3].

Ở Việt Nam nghiên cứu về ĐTĐTK còn ít. Một số công trình tại Việt nam công bố trước đó thì tỷ lệ ĐTĐTK còn thấp: Năm 1999, Ngô Kim Phụng là 3,9%, năm 2000 với Nguyễn Thị Kim Chi với 3,6%, năm 2002 với Tạ Văn Bình với 5,7%, năm 2007 với Tô Thị Minh Nguyệt với 10,69%. [7,8]. Năm 2009, Nguyễn Việt Hùng nghiên cứu trên 3620 sản phụ tại khoa Phụ Sản bệnh viện Bạch Mai thì thấy "ĐTĐTK là 0,94% và ĐTĐTK sau khi tiến hành nghiệm pháp tăng đường huyết là 8,19%". Thuở đó tác giả nghiên cứu chưa xác định tên gọi ĐTĐ thực và ĐTĐTK [5]. Năm 2010. Nguyễn Hoa Ngần và cs nghiên cứu tại bệnh viện A Thái Nguyên trên 106 thai phụ thì có 9,4% ĐTĐTK. [7]. Năm 2011, Nguyễn Thị Kim Liên và cs nghiên cứu tại bệnh viện Phủ Sản Trung ương thì thấy có 79 thai phụ có đường niệu dương tính thì 18 trường hợp được chẩn đoán ĐTĐTK chiếm tỷ lệ 22,8%. Tại TP. Hồ Chí Minh, hai bệnh viện Sản phụ khoa: Từ Dũ và Hùng Vương tỷ lệ ghi nhận quanh 20% trên hàng chục ngàn trường hợp tầm soát hàng năm. [6,8]

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

Tất cả các thai phụ đến khám tiền thai tại khoa Phụ Sản bệnh viện Nhật Tân được khám đều đặn, đúng hẹn và đồng ý tham gia nghiên cứu. Tổng cộng 23 tháng có tổng số 691, số có xét nghiệm 368 trường hợp, số nhập viện sanh 329 ca, số chưa sanh 29 trường hợp. Số có khám thai nhưng không đến sanh là 333 trường hợp. Số còn lại là 223 trường hợp.

Đối tượng loại trừ:

Các thai phụ không đống ý tham gia nghiên cứu, không chịu làm hoặc không thực hiện đầy đủ nghiệm pháp tăng đường huyết.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành tại khoa Phụ Sản bệnh viện đa khoa Nhật Tân từ tháng 8/2018 đến ngày tháng 7/2020

2. Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu

Cách tiến hành nghiên cứu:

***Nghiệm pháp dung nạp đường huyết*:** Chuẩn bị bệnh nhân nhịn đói, được nghỉ ngơi ít nhất 30 phút. Lúc đói lấy máu định lượng glucose. Sau đó, cho bệnh nhân uống 75g glucose pha trogn 250 ml nước sỏi để nguội, trong thời gian 5 phút. Sau thi uống 1 và 2 giờ lấy máu định lượng glucose.

Chẩn đoán ĐTĐTK theo tiêu chuẩn của WHO năm 2013:

Cách và thời gian xét nghiệm	Đường huyết
Nhịn ăn	92-125 mg/dl (5,1-6,9 mmol/l)
Hoặc là 1 giờ sau	≥180 mg / dL (10,0 mmol/l)
Hoặc là 2 giờ sau	153 đến 199 mg / dL (8,5 đến 11,0 mmol/l)

Trong khi đó, chẩn đoán "ĐTĐ rõ, ĐTĐ mang thai" được thực hiện khi đáp ứng ≥1 tiêu chuẩn sau: glucose HT lúc đói ≥126 mg/dL (7,0 mmol/l), glucose HT 2 giờ ≥200 mg/dl (11,1 mmol/l) sau khi uống 75 gam glucose, đường huyết ngẫu nhiên ≥200 mg/dL (11,1 mmol/l).

3. Xử lý thống kê: Nhập số l;iệu vào Excel, dùng phần mềm SPSS20.0 để phân tích. Các số định lượng được phân tích bằng ANOVA với 3 tình trạng: Không ĐTĐ, ĐTĐ thai kỳ và ĐTĐ mang thai. Số trung bình ± độ lệch chuẩn (SD). Ý nghĩa thống kê khi p <0,05.

4. Đạo đức trong nghiên cứu: Giải thích rõ cho thai phụ mục đích của nghiên cứu và chỉ thực hiện khi thai phụ đã đồng thuận.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. ***Tỷ lệ mắc ĐTĐTK và ĐTĐ thực***

Tình trạng ĐTĐ	**N**	**Tỷ lệ %**	**Cộng dồn %**
Không ĐTĐ	166	74,4	97.8
ĐTĐ thai kỳ	52	23,3	23,3
ĐTĐ mang thai	5	2,2	100
Cộng chung	223	100	100

Bảng 2. ***Cân nặng bé lúc sanh***

Tình trạng ĐTĐ	**N**	Trọng lượng bé lúc sanh (g) ± SD	KTC 95% Trung bình		Giá trị p
			Thấp	Cao	
Không ĐTĐ	52	3123 ± 54	2994	3251	≥0,05; <0,001; ≥0,05; <0,001; ≥0,05
ĐTĐ thai kỳ	166	3176 ± 46	3125	3227	
ĐTĐ mang thai	5	3770 ± 03	3316	4223	
Chung	223	3177± 67	3127	3227	

Bảng 3. ***BMI bà mẹ trước lúc mang thai***

Tình trạng ĐTĐ	**N**	BMI mẹ trước lúc mang thai (kg)±SD	KTC 95% Trung bình		Giá trị p
			Thấp	Cao	
Không ĐTĐ	52	21.6 ± 4.2	20.4	22.7	>0,05; <0,001; ≥0,05; <0,001; ≥0,05
ĐTĐ thai kỳ	166	20.7 ± 3.9	20.1	21.3	
ĐTĐ mang thai	5	26.3 ± 3.7	21.7	31.0	
Chung	223	21.1 ± 4.0	20.5	21.6	

Bảng 4. ***Tuổi thai lúc sanh***

Tuổi thai lúc sanh	**N**	**Tuần thai lúc sanh** ± SD	KTC 95% Trung bình		Giá trị p
			Thấp	Cao	
Không ĐTĐ	52	31.3 ± 1,7	37.9	38.3	=0,05; >0,05; ≥0,05; >0,05; ≥0,05
ĐTĐ thai kỳ	166	38.7 ± 1,0	38.6	38.9	
ĐTĐ mang thai	5	37.3 ± 1.3	35.6	39.0	
Chung	223	38.6 ± 1.2	38.4	38.7	

Bảng 5. Tuổi mẹ lúc mang thai

Tuổi thai lúc sanh	**N**	**Tuần thai lúc sanh** ± SD	KTC 95% Trung bình		Giá trị p
			Thấp	Cao	
Không ĐTĐ	52	29.8 ± 5.1	28.4	31.3	>0,05
ĐTĐ thai kỳ	166	28.8 ± 5.3	28.0	29.5	>0,05
ĐTĐ mang thai	5	30.6 ± 3.8	25.8	35.4	≥0,05
Chung	223	29.1 ± 5.0	28.4	29.7	

Bảng 6. Mổ lấy thai và ĐTĐTK

Tình trạng ĐTĐTK	**N**	**Mổ lấy thai (%)**	**Không mổ lấy thai (%)**	χ^2	**p**
Không ĐTĐ	52	29 (55,8)	23 (44,2)	0,074	>0,05
ĐTĐ thai kỳ	166	89 (53,6)	77 (46,4)		
Công chung	218	118	100		

BÀN LUẬN

Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy tỷ lệ hiện mắc ĐTĐTK là 23,3% và ĐTĐ mang thai là 2,2%. Điều này cho thấy tình trạng ĐTĐTK cũng như ĐTĐ mang thai là một nguy cơ ngày càng tăng. Ở Việt Nam nghiên cứu về ĐTĐTK còn ít nhưng cũng cho thấy tỷ lệ ĐTĐTK ngày càng tăng cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội: Tỷ lệ mắc ĐTĐTK được báo cáo vào năm 1999 là 3,9% [7] cho đến năm 2011 thì tăng lên 22,8% [6]. Trên thế giới, tỷ lệ béo phì, ĐTĐ mang thai và ĐTĐTK ngày càng càng tăng cao.

Cơ chế, tần suất và các biện pháp dự phòng và chữa trị ĐTĐTK còn chưa được chú ý tại Việt Nam. Lúc đầu, nhiều nghiên cứu vẫn chưa phân biệt được ĐTĐ mang thai và ĐTĐTK như nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng vào năm 2009 nghiên cứu trên 3620 sản phụ tại khoa Phụ Sản bệnh viện Bạch Mai thì thấy "ĐTĐTK là 0,94% và ĐTĐTK sau khi tiến hành nghiệm pháp tăng đường huyết là 8,19%" [5]. Hay như chẩn đoán chưa chuẩn như nghiên cứu vào năm 2011, Nguyễn Thị Kim Liên và cs nghiên cứu tại bệnh viện Phủ Sản Trung ương thì thấy có 79 thai phụ có đường niệu dương tính thì 18 trường hợp được chẩn đoán ĐTĐTK chiếm tỷ lệ 22,8%. [6].

Tỷ lệ MLT trong nghiên cứu của chúng tôi ở thai phụ có và không có ĐTĐTK không khác biệt có ý nghĩa thống kê (53,6% so với 55,8%, p >0,05). Trong nghiên cứu của Trần Thùy Linh và cs nghiên cứu tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương vào năm 2009 nhận thấy ĐTĐTK làm tăng nguy cơ mổ lấy thai với tỷ lệ mổ 85,33%. [4]. Riêng 5 thai phụ ĐTĐ mang thai, đều phải mổ lấy thai do trông lượng trung bình của trẻ sinh ra bởi bà mẹ ĐTĐ mang thai cao hơn nhiều (3770 ± 03) so với cân nặng của bé sanh ra từ bà mẹ bình thường (3123 ± 54) và bà mẹ ĐTĐTK (3176 ± 46).

Nghiên cứu của chúng tôi không cho thấy có ý nghĩa thống kê về lứa tuổi, tiền sử sản khoa, tiền sử gia đình, tỷ lệ mổ lấy thai… Ngay cả cân nặng bé lúc sanh, BMI bà mẹ trước mang thai, tuổi thai lúc sanh cũng không khác biệt có ý nghĩa thống kê với p >0,05. Lý giải cho các vấn đề trên có thể là do:

- ✓ Tác động của bác sĩ buồng khám đã giải thích rõ về tác hại của ĐTĐTK cho thai phụ về các biện pháp chế độ dinh dưỡng, luyện tập để không tăng cân quá độ, và dùng thuốc. Thuốc ở đây chủ yếu sử dụng thuốc uống metformin và gliclazide do thai phụ chưa muốn dùng insulin. Riêng insulin chỉ dùng cho thai phụ mắc ĐTĐ mang thai.
- ✓ Có thể thai phụ không tuân thủ nhịn đói trước khi lấy máu thử lần đầu, và 2 lần lấy máu sau cũng không có người kiểm soát vấn đề ăn uống của thai phụ.

KẾT LUẬN

Tỷ lệ ĐTĐTK và ĐTĐ mang thai là một thực tế ngày càng trở nên quan trọng cho sức khỏe thai phụ và thai nhi mà thầy thuốc và cộng đồng phải cùng nhau khắc phục.

THAM KHẢO

1. **ADA Standards of Medical Care in Diabetes 2020**. The Journal of Clinical and Applied Research and Education. Diabetes Care Volume 43, Supplement 1, January 2020: S183-S192
2. **Durnwald C, Nathan DM, Werner EF, Barss VA.** Gestational diabetes mellitus: Glycemic control and maternal prognosis. UpToDate. Jul 07, 2020.
3. **Zhu Y, Zhang C**. Prevalence of Gestational Diabetes and Risk of Progression to Type 2 Diabetes: a Global Perspective. Curr Diab Rep. 2016 January ; 16(1).
4. **Trần Thùy Linh**; **Đặng Thị Minh Nguyệt**; Thái độ xử trí sản khoa đối với thai phụ ĐTĐTK tại bệnh viện phụ sản trung ương. Tạp chí Nghiên cứu Y học - 2011 - no.3 - tr.66-71.
5. **Nguyễn Việt Hùng**; Sàng lọc và xử trí ĐTĐ thài kỳ tại khoa Phụ - Sản Bệnh viện Bạch Mai trong năm 2007. Y học lâm sàng - 2009 - no.46 - tr.24-31
6. **Nguyễn Thị Kim Liên**; **Đặng Thị Minh Nguyệt**. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở nhóm thai phụ có yếu tố nguy cơ cao tại bệnh viện phụ sản trung ương / // Tạp chí Y học Thực hành - 2011 - no.2 - tr.41-43
7. **Nguyễn Hoa Ngần**; **Nguyễn Kim Luân**. Nghiên cứu thực trạng ĐTĐTK ở phụ nữ được khám thai tại bệnh viện A Thái Nguyên / // Tạp chí Y học Thực hành - 2010 - no.10 - tr.46-49.
8. **Bộ Y tế.** Hướng dẫn quốc gia dự phòng và kiểm soát ĐTĐ thai kỳ. QĐ số 6173/QĐ-BYT ngày 12/10/2018.

SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY

Đỗ Thị Quốc Trinh, Lê Trung Thi, Châu Hữu Hầu

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng siêu âm trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay (HCOCT) so sánh với các phương pháp chẩn đoán cổ điển. **Phương pháp**: Mô tả và phân tích so sánh chẩn đoán bệnh, tiến cứu. **Thời gian nghiên cứu**: 10 tháng, từ 5/2019 đến 3/2020. **Kết quả**: Nghiên cứu trên 77 người với 54 bàn tay bị bệnh và 54 bàn tay đối chứng, trong đó nữ chiếm 85,7%; tuổi trung bình 43,6 ± 11.7, chỉ số Kappa = 0,315 với p=0.001. Biểu đồ ROC cho thấy kỹ thuật chẩn đoán siêu âm có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt 70,4% và 71,1%; khi hiệu số 2 diện tích mặt cắt thần kinh giữa ở đầu vào ống cổ tay và ở khoảng cơ sấp vuông ≥1,5 mm^2 thì sẽ được chẩn đoán HCOCT. **Kết luận**: Siêu âm là kỹ thuật chẩn đoán HCOCT khá tốt giúp phát hiện bệnh nhanh, giá thành rẻ và dễ tiếp cận.

Từ khóa: Hội chứng ống cổ tay (HCOCT), diện tích mặt cắt (DTMC), siêu âm (SA)

ABSTRACT

Ultrasound in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Objectives: The study aimed to evaluate the effectiveness of ultrasound use in the diagnosis of carpal tunnel syndrome (HCOCT) compared with classical diagnostic methods. **Methods**: Prospective study, describing and analyzing, comparing and diagnosing diseases. **Research period**: 10 months, from May 2019 to March 2020. **Results**: The study included 77 people with 54 diseased hands and 54 control hands, of which female accounted for 85.7%; mean age 43.6 ± 11.7, Kappa index = 0.315 with p = 0.001. The ROC chart shows that ultrasound diagnostic technique has sensitivity and specificity of 70.4% and 71.1% respectively. When the difference of the 2 cross-sectional areas of the medial nerve at the inlet of the carpal tunnel and at the pronator quadratus muscle ≥1.5 mm^2 will be diagnosed with CTS. **Conclusion**: Ultrasound is a good technique for CTS diagnosis that helps to detect these diseases quickly, cheaply and accessibly ease.

Key words: Carpal tunnel syndrome (CTS), cross-sectional area (CSA), ultrasound (US)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hội chứng ống cổ tay (HCOCT) là bệnh cảnh dây thần kinh giữa bị chèn ép khi đi ngang qua ống cổ tay (OCT). Theo một nghiên cứu ở Mỹ, tỷ lệ hiện mắc HCOCT là 7,8% và tỷ lệ mới mắc tăng thêm 2,3 người-năm mỗi 100 người [1]. HCOCT là một trong những bệnh thần kinh phổ biến nhất, hay gặp ở phụ nữ và hay xảy ra ở tay thuận. Chẩn đoán HCOCT thường được nghĩ đến khi các triệu chứng điển hình bao gồm đau, rối loạn chức năng ở vùng thần kinh giữa. Các triệu chứng thường xảy ra khi vận động có thể dẫn đến teo các cơ do dây thần kinh giữa chi phối và tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống.

Hiện chưa có tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán HCOCT, chỉ có các chứng cứ về bệnh sử, khám lâm sàng, cao hơn nữa là chẩn đoán điện sinh lý thần kinh để có thể giúp bệnh nhân được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Chẩn đoán điện thường củng cố cho chẩn đoán lâm sàng, nhưng có một số hạn chế như khiến bệnh nhân khó chịu và có một tỷ lệ âm tính giả. Ngoài ra, chẩn đoán điện cung cấp thông tin liên quan đến việc làm chậm dẫn truyền thần kinh và mất sợi trục nhưng không đưa ra chi tiết giải phẫu. Trong trường hợp này, siêu âm (SA) sẽ giúp bổ sung vào chẩn đoán quyết định bệnh.

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đáng giá vai trò của SA trong chẩn đoán HCOCT khi mà chẩn đoán điện sinh lý thần kinh không phải nơi nào cũng có.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân đến khám vì đau ở cổ tay và trên lâm sàng có chẩn đoán HCOCT tại bệnh viện Nhật Tân, thành phố Châu Đốc. Một số bệnh nhân chỉ đau 1 cổ tay, cổ tay bên kia được đo để làm nhóm chứng. Một số người tình nguyện là nhân viên y tế không mắc HCOCT cũng được thêm vào nhóm chứng, Có tất cả 77 người tham gia, trong đó nữ chiếm ưu thế với 66 người. Số bàn tay được nghiên cứu là 108, nữ chiếm 89 (82,4%), trong đó có 54 nhóm chứng. Nhóm bệnh và nhóm chứng bằng nhau là do chúng tôi chọn thêm người tình nguyện cùng lứa tuổi cho đủ. **Đối tượng loại trừ**: Các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, suy thận mạn... và các bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả và phân tích so sánh chẩn đoán bệnh, tiến cứu.

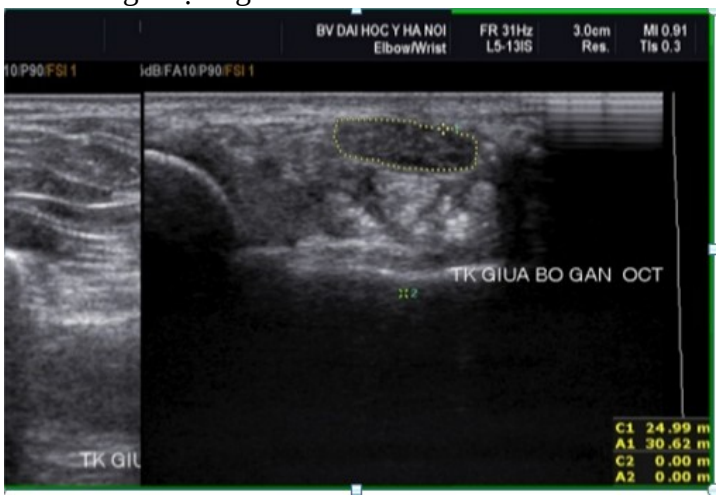
2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành tại bệnh viện Nhật Tân, thuộc TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang trong 10 tháng từ 15/5/2019 đến 15/3/2020.

2.4. Cách tiến hành và tiêu chí chẩn đoán: Tất cả bệnh nhân được hỏi bệnh sử, khám lâm sàng, được làm 2 nghiệm pháp Phalen và Tinel. Sau đó tiến hành đo dẫn truyền thần kinh giữa và SA đoạn cổ tay. Với các tiêu chí chẩn đoán HCOCT như sau [2,3]:

Tiêu chí chẩn đoán điện HCOCT theo Hội thần kinh học Hoa Kỳ: Thời gian tiềm vận động (DML) tăng >4.2ms; tốc độ dẫn truyền cảm giác (SCV) giảm <50ms. Chẩn đoán điện bằng máy Nihon Kohden, Model DC-940BK, sản xuất tại Nhật năm 2016. Khảo sát điện cơ kim: dạng ngón cái ngắn, gấp chung các ngón nông, tam đầu, cơ dạng ngón út.

Tiêu chí chẩn đoán lâm sàng HCOCT: Khi có ≥1 triệu chứng cơ năng và 1 triệu chứng thực thể. *Triệu chứng:* (1) Tê, đau bàn tay, mặt trước cẳng hoặc cánh tay. (2) Dị cảm hoặc mất cảm giác ở nơi do thần kinh giữa chi phối. (3) Yếu hoặc vụng về bàn tay.(4) Da khô, sưng, đổi màu da bàn tay. (5) ≥1 trong các triệu chứng trên theo đường đi của dây thần kinh giữa. *Các yếu tố khởi phát*: (1) Thường xuất hiện về đêm, (2) Đặt tay lâu ở một vị trí, (3) Các hoạt động lặp đi lặp lại của tay. *Các yếu tố làm thuyên giảm bệnh*: (1) Thay đổi tư thế bàn tay, (2) Cử động bàn tay. *Khám lâm sàng*: Phát hiện triệu chứng thực thể: (1) Có thể bình thường, (2) Dấu hiệu Tinel (+), Phalen (+). (3) Yếu hoặc teo cơ ô mô cái.

Tiêu chí chẩn đoán SA: Dùng máy LOGIQ P9 của GE, Mỹ với đầu dò linear L4-12t RS, sản xuất 2019. Trong nghiên cứu, chúng tôi chú ý đến độ phình to của dây thần kinh giữa bị chèn khi vào ống cổ tay (OCT). Đo diện tích mặt cắt (DTMC) của thần kinh giữa ở 2 điểm: đầu vào của OCT và chỗ cơ sấp vuông. Hiệu số của 2 DTMC này sẽ giúp xác định chẩn đoán HCOCT qua SA. Các dị dạng, thay đổi cấu trúc, tăng tưới máu, mạc giữ gân gấp… đều không được nghiên cứu.



Hình 1. ***SA đo diện tích cắt ngang dây thần kinh giữa.***

2.5. Xử lý thống kê: Chọn cỡ mẫu 108, 54 bàn tay (của 77 người) trong đó có 54 bàn tay có HCOCT và 54 bàn tay bình thường ở nhóm chứng. Kết quả của chẩn đoán bằng SA và chẩn đoán cổ điển (thường qui) được so sánh bằng bảng 2×2, từ đó tính chỉ số Kappa và các chỉ số đọ nhạy, độ đặc hiệu; đồng thời được phân tích trên biểu đồ ROC. Kết quả kiểm định so sánh 2 giá trị được coi là có ý nghĩa thống kê khi p-value <0,05.

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu: Các đối tượng được thông báo chi tiết về các nội dung nghiên cứu và lấy ý kiến đồng thuận. Mọi thông tin cá nhân được bảo vệ bí mật. Người tham gia thử nghiệm được miễn một phần viện phí.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. ***Đặc trưng của người tham gia***

Biến số	**n**	**Tỷ lệ %**
Giới tính (n=77)		
Nữ	66	85,7
Nam	11	14,3
Số bàn tay (n=108)		
Nữ	89	82,4
Nam	19	17,6
Tuổi (n=77, tuổi trung bình 43,6±11,7)		
<40	31	40,2
40-59	41	53,4
≥60	5	6,4
Bàn tay được khám		
Trái	23	21,3
Phải	43	39,8
Hai tay	42	38,9

Bảng 2. ***Các phương pháp chẩn đoán HCOCT***

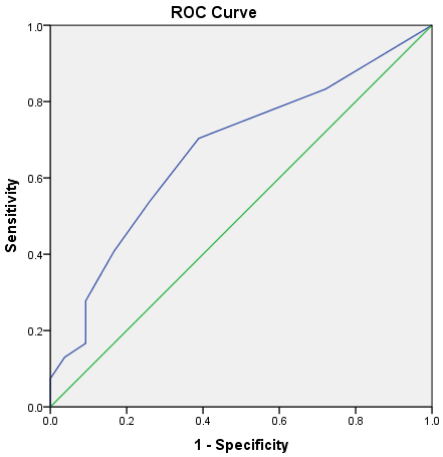
Biến số	**n**	**Tỷ lệ %**
HCOCT chẩn đoán lâm sàng		
Có bệnh	59	54,6
Không	49	45,4
HCOCT chẩn đoán điện		
Có bệnh	63	58,3
Không	45	41,7
HCOCT chẩn đoán trên SA		
Có bệnh	59	54.6
Không	49	45,4
Số ca xác định HCOCT		
Có bệnh	54	50,0
Không	54	50,0

Bảng 4. ***Bảng 2x2 so sánh kết quả của chẩn đoán cổ điển và chẩn đoán bằng SA***

			Chẩn đoán cổ điển		Tổng cộng	Chỉ số Kappa	p
			Có bệnh	Không bệnh			
Chẩn đoán bằng SA	Có bệnh	21	38	59	0.315	0.001	
	Không bệnh	33	16	49			
Total		54	54	108			

Chỉ số kappa =0,315 với p=0.001, có sự tương hợp giữa 2 phương pháp chẩn đoán.

Công thức Youden J=max(Se+Sp-1) → J=0,315, và điểm cắt của SA 1,500 mm^2. Khi đo DTMC dây thần kinh giữa, tính hiệu số DTMC đầu vào-DTMC ở cơ sấp vuông ≥1,5 mm^2 → có chẩn đoán HCOCT.



Hình 2. M*ối tương quan của chẩn đoán cổ điển và SA qua biểu đồ ROC.*

Bảng 4. ***Độ chính xác chẩn đoán trong tiên lượng SA so với chẩn đoán cổ điển***

	Ngưỡng	**Độ nhạy (%)**	**Độ đặc hiệu (%)**	**AUC (95% CI)**	**p**
Kết quả SA	1,50 mm^2	70,4	71,1	0.672 (0.570-0,770)	0,002

IV. BÀN LUẬN

Nghiên cứu thực hiện trên 77 người với 108 bàn tay, trong đó nữ chiếm tới 85,7%, tuổi trung bình 43,6±11,7. Số bàn tay được xác định mắc HCOCT là 54 chiếm tỷ lệ 50% là do cách chọn mẫu của chúng tôi. Nghiên cứu của Lê Thị Liễu, nữ mắc HCOCT 93.0% và tuổi trung bình 49,1 ± 9,3 gần tương đương với công trình của chúng tôi [3]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn công thức tính hiệu số giữa 2 DTMC ở đầu vào ống cổ tay và ở cơ sấp vuông để đánh giá sự tương hợp giữa chẩn đoán HCOCT qua SA và chẩn đoán thường qui. Chỉ số Kappa = 0,315 với p=0,001, cho thấy có sự tương hợp giữa 2 phương pháp chẩn đoán, với độ mạnh tương đối cao. Biểu đồ ROC cho thấy chẩn đoán SA có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 70,4% và 71,1%, trong khi công trình của Lê Thị Liễu dựa theo phân độ 4 mức HCOCT, SA có độ nhạy và độ đặc hiệu trên 70% [3]. Điểm ngưỡng (cut-off) trong chẩn đoán SA của chúng tôi là 1,50 mm^2, có nghĩa khi đo DTMC dây thần kinh giữa, hiệu số DTMC đầu vào ống cổ tay và ở cơ sấp vuông ≥1,5 mm^2 thì chẩn đoán SA dương tính, có mắc HCOCT. Emril và cs cũng chọn cách tính hiệu số như của chúng tôi, nhưng sự khác biệt giữa 2 DTMC ≥2 mm^2 được chẩn đoán HCOCT [1]. Độ nhạy và độ đặc hiệu trong nghiên cứu của chúng tôi cũng như của Lê Thị Liễu có thể là do các bệnh nhân HCOCT trong các nghiên cứu này bao gồm từ các trường hợp từ nhẹ đến nặng. Theo Bouchal và cs cho rằng SA chỉ nhạy với HCOCT khi có hình ảnh điện cơ nặng [8].

Về đánh giá SA trong HCOCT, nhiều tác giả chọn nhiều công thức tính khác nhau. Fu et al [5] đã đánh giá ý nghĩa chẩn đoán của tỷ lệ DTMC dây thần kinh giữa ở đầu vào và đầu ra (inlet-to-outlet, IOR) ống cổ tay ở bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng và điện sinh lý của HCOCT. DTMC đầu vào trung bình là 8,7 mm^2 ở người khỏe mạnh và 14,6 mm^2 ở bệnh nhân mắc HCOCT. IOR trung bình là 1,0 trong nhóm chứng và 1,6 ở những người bị HCOCT. Giá trị cắt IOR ≥1,3 có độ đặc hiệu 93% và độ nhạy 91% trong chẩn đoán HCOCT [7]. Georgiev và cs [4] cho rằng các DTMC >10 mm^2 có ý nghĩa chẩn đoán đối với HCOCT. Tác giả còn nhận thấy 2 thông số quan trọng khác là sự nén của dây thần kinh giữa với dạng trương phình hình cầu, có thể được quan sát tại điểm mà dây thần kinh đi qua phía dưới mạc giữ gân gấp. Thông số khác là lưu lượng máu nội tại ống cổ tay tăng. Sự tăng tưới máu, echo kém của dây thần kinh được quan sát cùng với DTMC lớn hơn; trên thực tế, có xác suất 90% bị HCOCT nếu cả 3 tham số này đều dương, ngay cả trong trường hợp điện sinh lý bình thường [4]. Aggarwal và cs dùng nhóm chứng có DTMC của dây thần kinh giữa nằm trong khoảng từ 5 đến 7,3 mm2, trong khi ở nhóm có triệu chứng, dao động

từ 8.4 đến 16.5 mm2. Với mức cắt 9 mm2, độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác của SA trong chẩn đoán HCOCT lần lượt là 95%, 100% và 97% [7].

Qua đó, chúng tôi nhận thấy SA là một kỹ thuật chẩn đoán khá tốt giúp cho người bệnh được chẩn đoán nhanh chóng, tin cậy, giá thành rẻ và dễ tiếp cận hơn. SA còn có thể phát hiện được các biến thể giải phẫu trong HCOCT như: động mạch giữa còn tồn tại, dây thần kinh giữa chẻ đôi, v.v... Hiện nay trang bị và kỹ thuật SA được sử dụng rất phổ biến ở tất cả các tuyến bệnh viện. vì vậy giá trị ứng dụng của biện pháp chẩn đoán HCOCT bằng siêu âm càng cao hơn.

V. KẾT LUẬN

SA là một biện pháp chẩn đoán bổ sung khá tốt trong HCOCT bên cạnh các biện pháp cổ điển, giúp người bệnh được chẩn đoán nhanh, chính xác, giá thành rẻ và dễ tiếp cận.

THAM KHẢO

1. **Emril DR, Zakaria I, Amrya M.** Agreement Between High-Resolution Ultrasound and Electro-Physiological Examinations for Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome in the Indonesian Population. Frontiers in Neurology | www.frontiersin.org. August 2019 |Volume 10 | Article 888
2. **AAEM.** Practice Parameter For Electrodiagnostic Studies In Carpal Tunnel Syndrome: Summary Statement. 2002 American Association of Electrodiagnostic Medicine. Published online 7 May 2002 in W iley InterScience (www.interscience. wiley.com).
3. **Lê Thị Liễu.** Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm Doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay, Luận án Tiến sĩ Y học, Đai học Y Hà Nội, 2018.
4. **Georgiev GP, Karabinov V, Kotov G, Iliev A.** Medical Ultrasound in the Evaluation of the Carpal Tunnel: A Critical Review. Cureus 10(10): 2018. 2018, e3487. DOI10.7759/cureus.3487.
5. **Fu T, Cao M, Liu F, et al. (2015)**, "Carpal tunnel syndrome assessment with ultrasonography: value of inlet-to-outlet median nerve area ratio in patients versus healthy volunteers", *PLoS One*. 10(1), pp. e0116777.
6. **Dale AM, Harris-Adamson C, Rempel D, Gerr F, Hegmann K, Silverstein B, Burt S, Garg A, Kapellusch J, Merlino L, Thiese MS, Eisen EA, Evanoff B.** Prevalence and incidence of carpal tunnel syndrome in US working populations: pooled analysis of six prospective studies. Scand J Work Environ Health. 2013 Sep 1;39(5):495-505.
7. **Aggarwal P, Jirankali V, Garg SK.** Accuracy of high-resolution ultrasonography in establishing the diagnosis of carpal tunnel syndrome. ANZ J Surg. 2020 Jan 26.
8. **Bouchal S, Midaoui A, Berrada K, Zahra AF, Aradoini N, Harzy T, Belahsen MF.** Comparaison des données de l'échographie par rapport à l'électroneuromyogramme dans le diagnostic de syndrome de canal carpien. **Pan Afr Med J. 2019; 34: 50.**

TÌNH TRẠNG TRŨNG QUA HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN LỌC THẬN

Châu Hữu Hầu, Nguyễn Minh Trí

TÓM TẮT

Mục tiêu: Tìm hiểu ý nghĩa của tình trạng trũng trên huyết áp liên tục 24 giờ ở bệnh nhân lọc thận. **Phương pháp**: nghiên cứu tiến cứu. **Địa điểm và thời gian nghiên cứu**: Trong 3 tháng từ tháng 6/2020 đến tháng 08/2020, tại bệnh viện đa khoa Nhật Tân, tỉnh An Giang. **Kết quả**: Tình trạng trũng ở nhóm lọc thận chỉ chiếm 10%; không trũng chiếm 90% bao gồm không trũng thực 40%, trũng ngược 48% và trũng cực độ 2%. Trong khi đó, nhóm chứng khỏe mạnh không lọc thận cùng lứa tuổi và cùng giới tính thì các tỷ lệ này lần lượt là 34%, 52%, 10% và 4%. Nhóm lọc thận có trạng thái không trũng cao gấp 4,6 lần nhóm chứng, với p <0,004. Sau khi phân tích hồi quy logistic, chỉ có 2 yếu tố có ý nghĩa thống kê: HATT 24 giờ làm giảm sự xuất hiện của tình trạng không trũng gần phân nửa [0,515 (0,370-0,716)] thì HATT ban ngày làm tăng tình trạng này gần gấp đôi [1,882 (1,360-2,605)]. **Kết luận**: Các tình trạng trũng ở bệnh nhân lọc thận trong nghiên cứu của chúng tôi là: 10% trũng; 90% không trũng trong đó bao gồm 40% không trũng thực, 48% trũng ngược và 2% trũng cực độ. HATT rung bình 24 giờ làm giảm sự xuất hiện của trạng thái không trũng, trong khi HATT trung bình ban ngày làm tăng tình trạng này.

Từ khóa: Huyết áp lưu động, suy thận mạn, lọc thận, trũng, không trũng

Viết tắt: HA, huyết áp; HATT, HA tâm thu; HATTr, HA tâm trương; HAĐM, HA động mạch: HALĐ, HA lưu động; STM, suy thận mạn; THA, tăng HA.

Dipper pattern on Ambulatory Blood Pressure Monitoring in the hemolysis patients

ABSTRACT: Dipper pattern on Ambulatory Blood Pressure Monitoring in the hemolysis patients. **Objective**: To understand the significance of the dipping state on 24-hour ambulatory blood pressure in hemodialysis patients. **Methods**: prospective study. **Study location and time**: Study during 3 months from June 2020 to August 2020, at Nhat Tan General Hospital, An Giang province. **Results**: Dipping status in the dialysis group only accounted for 10%; non-dipping status with 90%, including non-dipping 40%, reverse dipping 48% and extreme dipping 2%. Meanwhile, the healthy control group without dialysis of the same age and sex, these rates were 34%, 52%, 10%, and 4% respectively.The hemodialysis group has a non-dipping state was 4.6 times higher than that of the control group, with statistical significance with p <0.004. After analyzing logistic regression, only 2 risk factors were statistically significant: 24-hour SBP reduced the occurrence of non-dipping by nearly half [0,515 (0,370-0,716)], while daytime SBP nearly doubled this state [1,882 (1,360-2,605)]. **Conclusion**: Dipping states in patients on hemodialysis in our study were: 10% dipping; 90% non-dipping, of which 40% was non-dipping, 48% was reverse dipping and 2% was extreme one. The 24-hour SBP reduced the occurrence of non-dipping by nearly half [1,882 (1,360-2,605)], while daytime SBP nearly doubled this state [1,882 (1,360-2,605)].

Keywords: Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM), chonic kidney disease, hemodialysis, dipping, non-dipping.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tăng huyết áp (THA) là một bệnh lý thường gặp ở bệnh nhân suy thận mạn (STM), tỷ lệ mắc THA và độ THA càng tăng khi mức lọc cầu thận càng giảm. Một nghiên cứu ở Mỹ đã

ước tính tăng huyết áp xảy ra ở khoảng 23,3% người không mắc STM và ở bệnh nhân STM thì các tỷ lệ là 35,8% giai đoạn 1; 48,1% giai đoạn 2; 59,9% giai đoạn 3 và 84,1% ở giai đoạn 4 và 5 [1].

THA được coi là yếu tố quyết định của sự tiến triển STM. Do vậy, việc kiểm soát huyết áp (HA) ở bệnh nhân STM được khuyến cáo ở mức HA mục tiêu <130/80 mmHg, hoặc thấp hơn 10 mmHg so với các phân tầng nguy cơ khác. Dù điều trị THA có thể ngăn ngừa nhiều biến chứng của STM, nhưng theo nhiều nghiên cứu việc kiểm soát HA vẫn còn kém ở các đối tượng này [2].

Đo HA cổ điển bằng HA kế thủy ngân, HA điện tử đều có nhiều sai số, nhất là không xác định được THA áo choàng trắng, THA ẩn giấu, THA trong lúc ngủ… khiến kiểm soát THA không tốt ở bệnh nhân này. Trong những năm gần đây, việc áp dụng HA lưu động (HALĐ) 24 giờ đã cho phép ước tính toàn diện về HA thực của bệnh nhân. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy HALĐ dự đoán các biến cố tim mạch tốt và tương quan chặt chẽ với tổn thương cơ quan đích.

Một ưu việt của HALĐ là phân loại HA “trũng và không trũng”, lần đầu được giới thiệu vào năm 1988 khi một phân tích hồi cứu cho thấy bệnh nhân THA không trũng có nguy cơ đột quỵ cao hơn bệnh nhân có trũng. Hình ảnh không trũng vào ban đêm liên quan với tiên lượng xấu như hẹp động mạch vành ở nam giới; người cao tuổi bị THA lâu năm, suy giảm nhận thức; có khối lượng thất trái trên siêu âm tim cao [3,4]. Theo nghiên cứu của Ida và cs, người không trũng mà HA bình thường không dự báo về các kết cục ở bệnh nhân STM, cho thấy việc kiểm soát HA là cần thiết để ngăn ngừa bệnh thận giai đoạn cuối chứ không phải điều chỉnh nhịp sinh học[5]. Kiểm soát HA chặt chẽ là cũng cần để giảm tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch, hạn chế sự tiến triển và tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân STM. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, HA phải được xác định chính xác. HALĐ hoặc một số hình thức theo dõi HA tại nhà nên được áp dụng rộng rãi hơn ở những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính và bệnh thận giai đoạn cuối [2].

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra mục tiêu nghiên cứu về tỷ lệ trũng, không trũng qua HALĐ và các yếu tố nguy cơ của tình trạng này nhằm có tiên lượng và điều trị tốt hơn cho bệnh nhân lọc thận.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân đang lọc thận tại bệnh viện Nhật Tân và nhóm chứng cùng giới tính, cùng độ tuổi. Chúng tôi có tất cả 83 bệnh nhân lọc thận, chỉ có 53 người đồng ý tham gia, nhưng có 3 người có bản ghi không đầy đủ nên bị loại trừ. Chúng tôi chọn nhóm chứng trong đội ngũ nhân viên y tế không bị STM có cùng độ tuổi và giới tính để giảm thiểu sai số. **Đối tượng loại trừ**: Các bệnh nhân không đồng ý nghiên cứu và các bảng ghi không đầy đủ (<75%).

Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Trong 3 tháng từ 02/6/2020 đến ngày 30/08/2020. Tại bệnh viện đa khoa Nhật Tân, tỉnh An Giang.

Cách đo: Các phương pháp đo HA 24 giờ đã được ghi lại bằng máy đo HALĐ WatchBP*03, sản xuất 2019. Máy đã được Hiệp hội THA châu Âu (ESH) và Hiệp hội Tim Hoa Kỳ chấp thuận. Thiết bị được mang ở cánh tay không thuận của người bệnh vào khoảng từ 8 giờ đến 16 giờ, và được lấy ra 24 giờ sau đó. Thiết bị được lập trình để ghi lại HA mỗi 30 phút vào ban ngày (6 giờ sáng đến 10 giờ tối) và 60 phút vào ban đêm (20 giờ tối đến 6 giờ sáng).

Các định nghĩa:

Trũng: được xác định bằng sự khác biệt giữa HATT trung bình ban ngày và HATT trung bình ban đêm. Nếu 10-20% là trũng bình thường, <10% là trũng ngược; 1-10% không trũng mà chúng tôi gọi là không trũng thực; >20% trũng cực độ. Ngoài trũng và không trũng bình thường như đã nói ở trên, còn có một số hình thái trũng khác [2,7]**.** *Trũng ngược***,** còn gọi là dốc đứng hay không trũng cực độ (reverse dipping, risers, extreme nondipper): HA tăng cao vào ban đêm và giảm vào ban ngày, có tiên lượng xấu nhất. *Trũng cực độ* (extreme dipper): Bệnh nhân bị tụt HA rõ rệt về đêm, có nguy cơ bị đột quỵ và thiếu máu cơ tim thầm lặng. Trũng cực độ hay gặp ở người bị xơ vữa động mạch, hoặc bị hạ HA quá mức do thuốc. Bệnh nhân thường THA quá mức buổi sáng, dễ gây nhồi máu não...

Ngoài ra còn có một vài thể khác như *trũng của giấc ngủ trưa*. Trũng này làm biến dạng tỷ suất ngày và đêm của HALĐ [2]. Ortega và cs [5] nhận thấy sau khủng hoảng kinh tế 2008 có mô hình THA do áp lực làm việc với biểu hiện *THA ẩn giấu và trũng* trên HALĐ.

Xử lý thống kê: Nhập và xử lý số liệu trên SPSS Statistics 20.0, dùng crosstabs để phân tích các biến định tính, dùng one way ANOVA để phân tích các biến liên tục. Dùng hồi qui logistic đa biến để xác định phân tích các biến có ý nghĩa thống kê. Ngưỡng có ý nghĩa thống kê khi p<0,05.

Đạo đức trong nghiên cứu: Tất cả người được nghiên cứu đều được thông báo chi tiết về nội dung và mục tiêu nghiên cứu và lấy ý kiến đồng thuận. Mọi thông tin cá nhân đều được bảo vệ bí mật. Người tham gia được miễn một phần viện phí.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1.*Giới tính trong nghiên cứu*

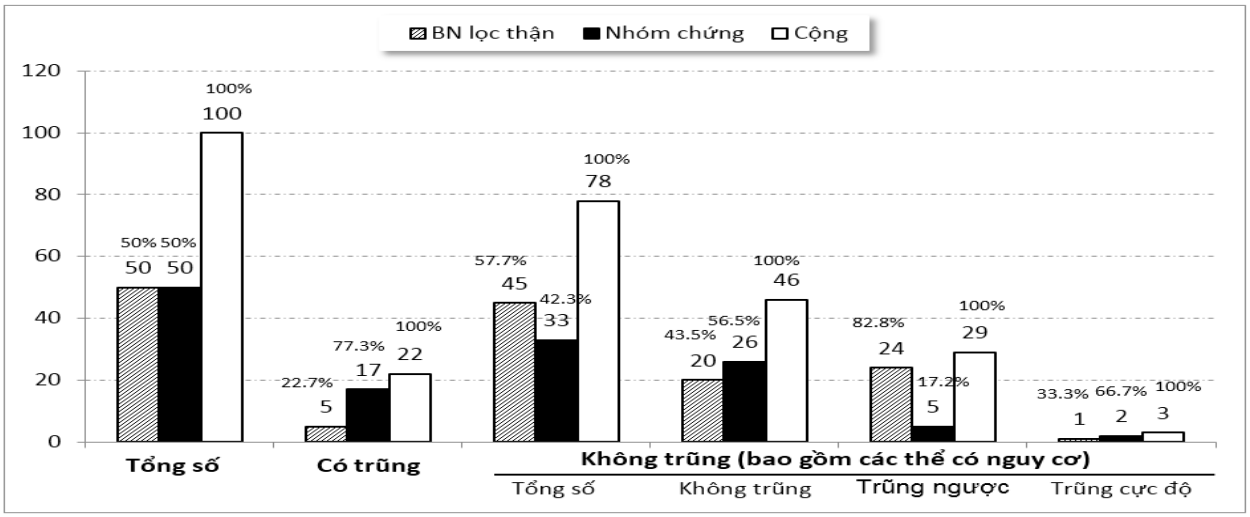
Giới tính	Tổng số	Có lọc thận	Tình trạng trũng		p
			Có	Không	
Nữ	62 (62%)	31 (50%)	16 (16%)	46 (46%)	0,241
Nam	38 (38%)	19 (50%)	6 (6%)	32 (32%)	
Cộng	100	50 (100%)	22 (22%)	78 (78%)	

Bảng 2.*Tuổi của 2 nhóm nghiên cứu và ý nghĩa của tình trạng trũng và không trũng*

Nhóm nghiên cứu	Tổng số	Tuổi trung bình	Có trũng	Không trũng	OR (KTC95%)	p
BN lọc thận	50	53,80±12,63	5 (10,0%)	45 (90,0%)	4,6 (1,5-13,8)	0,004
Nhóm chứng	50	53,82±12,54	17 (34,0%)	33 (66,0%)		
Cộng	100		22 (22,0%)	78 (78,0%)		

Bảng 3.*Tình trạng trũng trong nhóm lọc thận và nhóm chứng:*

Nhóm nghiên cứu	n	Có trũng	Không trũng* (bao gồm các thể có nguy cơ bệnh lý)			
			Tổng số	Không trũng thực	Trũng ngược	Trũng cực độ
BN lọc thận	50	5 (10%)	45 (90%)	20 (40%)	24 (48%)	1 (2%)
Nhóm chứng	50	17 (34%)	33 (66%)	26 (52%)	5 (10%)	2 (4%)
Cộng	100	22 (22%)	78 (78%)	46 (46%)	29 (29%)	3 (3%)



Hình 1.*Biểu đồ tình trạng trũng và không trũng ở 2 nhóm: lọc thận và nhóm chứng*

Bảng 4. ***Các yếu tố nguy cơ của trũng và không trũng***

Yếu tố nghiên cứu	Trũng* (n=22)	Không trũng* (n=78)	F	Giá trị p
Tuổi	55,9 ± 13,6	53,2 ± 12,2	0,790	0,376
HATT 24 giờ	116,0 ± 16,3	129,0 ± 21,0	7,186	0,009
HATT ban ngày	121,2 ± 16,7	129,8 ± 19,8	3,454	0,066
HATT ban đêm	105,0 ± 15,7	127,7 ± 25,1	16,165	0,000
HATTr 24 giờ	75,2 ± 11,8	70,7 ± 12,2	2,526	0,115
HATTr ban ngày	75,9 ± 11,5	73,9 ± 12,5	0,496	0,483
HATTr ban đêm	74,0 ± 13,5	63,9 ± 12,0	10,159	0.002
Nhịp tim 24 giờ	78,4 ± 10,6	75,5 ± 12,5	1,157	0,285
Nhịp tim ban ngày	80,9 ± 10,9	78,0 ± 11,7	1,138	0,289
Nhịp tim ban đêm	73,6 ± 10,9	69,3 ± 18,1	1,943	0,167
HAĐM (MAP) 24 giờ	86,4 ± 12,4	81,0 ± 12,8	3,164	0,078
HAĐM (MAP) ban ngày	87,2 ± 12,3	84,7 ± 13,5	0,700	0.405
HAĐM(MAP) ban đêm	84,6 ± 14,1	73,0 ± 12,8	12,056	0,001
Hiệu áp (PP) 24 giờ	53,8 ± 16,7	45,4 ± 8,8	5,149	0,025
Hiệu áp (PP) ban ngày	53,8 ± 16,2	47,2 ± 8,9	3,338	0,071
Hiệu áp (PP) ban đêm	53,7 ± 18,7	41,1 ± 8,9	9,262	0,003

*Ghi **chú:** Các số đo nêu trên đều là số trung bình

Bảng 5. ***Phân tích hồi qui logistic chỉ còn 2 biến số còn ý nghĩa thống kê***

Biến số	**Hệ số**	**Sai số chuẩn**	**Giá trị p**	**OR (KTC 95%)**
HATT 24 giờ	-0,664	0,168	0,000	0,515 (0,370-0,716)
HATT ban ngày	0,632	0,166	0,000	1,882 (1,360-2,605)
Constant	0,478	2,128	0,822	1,613

BÀN LUẬN

Để thuận tiện và tránh sai số, chúng tôi chọn nhóm chứng cùng giới tính và cùng độ tuổi với nhóm bệnh nhân lọc thận. Nhưng do không có đủ nhóm chứng nên có chênh nhau chút ít nhưng số tuổi trung bình không khác bao nhiêu giữa nhóm lọc thận và nhóm chứng

(53,80±12,63 và 53,82±12,54).Trong nghiên cứu này, mỗi nhóm có 50 người. Nữ phải lọc thận là 31 so với nam 19, nữ suy thận giai đoạn cuối cao gần gấp đôi nam (31 so với 19).

Các trường hợp không trũng, trũng ngược, trũng cực độ, chúng tôi xếp chung vào nhóm không trũng vì tất cả các thể bệnh này có thể có mặt ở các bệnh nhân nặng, các bệnh nhân có tổn thương cơ quan đích, thậm chí tử vong. Hơn nữa, có tác giả còn gọi trũng ngược là tình trạng không trũng cực độ (extreme non-dipping) hay dốc đứng (riser) [7].

Tình trạng trũng ở nhóm lọc thận chỉ chiếm 10% (5/50 người); không trũng chiếm 90% bao gồm không trũng thực 40%, trũng ngược 48% và trũng cực độ 2%. Trong khi nhóm chứng khỏe mạnh thì các tỷ lệ này lần lượt là 34%, 52%, 10% và 4%. Wang và cs nhận thấy ở người STM nhưng chưa chạy thận lần nào thì tần số của trũng, không trũng và trũng ngược lần lượt là 34,69%, 43,54% và 18,03%, không có trũng cực độ [4]. Nghiên cứu của chúng tôi ở nhóm người đang lọc thận thì tình trạng trũng khá thấp 10% so với nghiên cứu của Wang với 34,69% là hợp lý do Wang nghiên cứu ở người STM nhưng chưa lọc thận.

Nhóm không trũng chiếm đa số 90% (45/50) ở nhóm lọc thận, trong khi ở nhóm chứng có cùng độ tuổi thấp hơn 64% (33/50). Trong nhóm không trũng, có trũng ngược xảy ra nhiều nhất ở nhóm lọc thận với 48% so với nhóm chứng chỉ có 10%; trũng cực độ thì h iếm hơn: 1 ca ở nhóm lọc thận và 2 ca ở nhóm chứng. Nhóm lọc thận có dạng không trũng cao gấp 4,6 lần nhóm chứng, có ý nghĩa thống kê với p <0,004.

Khi xử lý bằng ANOVA, các yếu tố nguy cơ của tình trạng trũng và không trũng bao gồm: HATT 24 giờ, HATT ban đêm, HATTr ban đêm, HA trung bình ban đêm. Hiệu áp (PP)24 giờ, PP ban ngày và PP ban đêm.Tuy nhiên, khi sử dụng hồi qui logistic đa biến bao gồm tất cả các yếu tố nêu trên thì thấy chỉ còn 2 yếu tố có ý nghĩa thống kê là HATT 24 giờ và HATT ban ngày ảnh hưởng đến tình trạng không trũng: trong khi HATT 24 giờ làm giảm sự xuất hiện của tình trạng không trũng gần phân nửa [0,515 (0,370-0,716)] thì HATT ban ngày làm tăng tình trạng này gần gấp đôi [1,882 (1,360-2,605)]. HATT 24 giờ là HA trung bình của HA ngày và đêm nên luôn thấp hơn HA trung bình ban ngày. Theo Darr và cs [8], hoạt động giao cảm ở người bình thường giảm đi trong lúc ngủ khiến cho HATT, HATTr và cả nhịp tim đều giảm xuống và hình thành trũng. Ở một số bệnh nhân có bệnh tịm mạch, thận…hoạt động của hệ giao cảm bị rối loạn, hoạt động giao cảm không giảm xuống vào ban đêm và hình thành tình trạng không trũng và chính vì thế HATT ban ngày làm tăng tình trạng không trũng..

Trũng ngược xảy ra nhiều nhất: 24 người ở nhóm lọc thận và 5 trường hợp ở nhóm chứng. Đây là nhóm có tiên lượng xấu nhất cả về đột quỵ và biến cố trên tim cần chăm sóc và hạ HA tích cực. Theo Wang và cs [4] nghiên cứu trên 588 bệnh nhân STM chưa lọc thận thì thấy người bệnh với mô hình trũng ngược có tỷ lệ tử vong chung, tử vong tim mạch, các biến cố về thận và tim mạch đều cao hơn so với bệnh nhân có trũng (p<0,025). Do trũng ngược có liên hệ đến các kết cục xấu cần phải chăm sóc bằng cách hạ huyết áp tích cực.

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 3 trường hợp trũng cực độ, 1 bệnh nhân đang chạy thận và 2 bệnh nhân ở nhóm chứng. Theo nhiều nghiên cứu, trạng thái trũng cực độ, có nguy cơ bị đột quỵ nhưng không dẫn đến chết người và có thể gây thiếu máu cơ tim thầm lặng [5]. Như thế, trũng cực độ có nguy cơ bệnh lý trong STM có phần nhẹ hơn trũng ngược. Tuy nhiên vì số lượng trũng cực độ trong nghiên cứu của chúng tôi còn thấp (3 người) nên cần có các nghiên cứu sâu hơn nhằm xác định tầm quan trọng của loại trũng này

KẾT LUẬN

Các tình trạng trũng (dipping của HA) ở bệnh nhân lọc thận trong nghiên cứu của chúng tôi là 10% trũng; 90% không trũng trong đó bao gồm 40% không trũng, 48% trũng ngược và 2% trũng cực độ. HATT 24 giờ làm giảm sự xuất hiện của trạng thái không trũng, trong khi

HATT ban ngày làm tăng trạng thái này. Cần có nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tình trạng trũng và không trũng nhằm khắc phục, từ đó nâng cao sức khỏe cho người chạy thận.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Velasquez MT, Beddhu S, Nobakht E, Rahman M, Raj DS.** Ambulatory Blood Pressure in Chronic Kidney Disease: Ready for Prime Time?KI Reports (2016) 1, 94–104.
2. **Thompson AM, Pickering TG.** The role of ambulatory blood pressure monitoring in chronic and end-stage renal disease. Kidney International, Volume 70, issue 6, p1000-1007, Sep 02,2006.
3. **Erkek ET, Akin S, Ozgur Y, Aydin Z, BicikZ.** Comparison of Dipper and Non-Dipper Hypertension Patterns According to Chronic Kidney Disease Stage. Journal of Nephrology Advances. Vol-1 Issue 2 Pg. no.- 15.
4. **Wang C, Ye Z, Li Y, Zhang J, Zhang Q, Ma X, Peng H, Lou T.** Prognostic Value of Reverse Dipper Blood Pressure Pattern in Chronic Kidney Disease Patients notUndergoing Dialysis: Prospective Cohort Study**.** Scientific Reports|6:34932 | DOI: 10.1038/srep34932.
5. **Ortega SS, Vizcaino JA, Villalba NL, Fuentes MS, Damaso EO, Perez JCR**. Clinical Significance of Dipper Pattern in Hypertensive Patients. Biol Med (Aligarh), Volume 8 • Issue 6 • 1000323
6. **Ida T, Kusaba T, Kado H, Taniguchi T, Hatta T, Matoba S, Tamagaki K.** Ambulatory blood pressure monitoring-based analysis of long-term outcomes for kidney disease progression. *Scientific Reports* volume 9, Article number: 19296 (2019)
7. **Bloomfield D, Park A.** Night time blood pressure dip. World J Cardiol. 2015 Jul 26; 7(7): 373–376.
8. **Darr R, Bursztyn M, Pamporaki C, Peitzsch M.** Dipping in Ambulatory Blood Pressure Monitoring Correlates With Overnight Urinary Excretion of Catecholamines and Sodium. The Journal of Clinical Hypertension Vol 18 | No 9 | September 2016: 921-926.

ỨNG DỤNG NỘI SOI TRONG PHẪU THUẬT Ổ BỤNG TẠI BVĐK NHẬT TÂN

Hồ Trung Nghĩa, Nguyễn Hùng Tâm, Phạm Đặng Tấn Hưng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thường lách được bảo tồn tối đa sau khi vỡ do chấn thương, do lách có nhiều chức năng trong tạo máu, thực bào, tiêu hủy tế bào già và miễn dịch. Chức năng miễn dịch là chức năng quan trọng nhất của lách liên quan tới việc tạo kháng thể bảo vệ cơ thể chống nhiễm trùng, đặc biệt trên trẻ em. Y văn thế giới đã mô tả "Hội chứng nhiễm trùng tối cấp"(12), (15) trên trẻ em sau cắt lách, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Ở người lớn cũng có nguy cơ nhiễm trùng tiềm tàng sau cắt lách (14) Một nguy cơ khác là tăng tỷ lệ viêm tắc tĩnh mạch sâu do tăng tiểu cầu sau cắt lách cũng đã được mô tả (18)

Trong các nghiên cứu về bảo tồn lách sau chấn thương, đa số lách vỡ độ I, II, III đều được bảo tồn nếu không ảnh hưởng tới huyết động, hoặc sau truyền máu tối thiểu mà huyết động ổn.(2), (4), (16) Thường lách vỡ độ III, IV, V đều được cắt lách (bán phần, toàn phần). Các nghiên cứu về bảo tồn lách qua nội soi ít được báo cáo do tính chất khẩn cấp của tổn thương, hoặc do đặc thù điều kiện, trang thiết bị, cũng như khả năng phẫu thuật của các cơ sở y tế (1), (6).Chúng tôi xin báo 1 trường hợp vỡ lách độ III, huyết động sụt giảm, đã được bảo tồn trọn vẹn lách vỡ bằng đốt cầm máu nơi vỡ lách qua nội soi.

II. BÁO CÁO CA BỆNH

Bệnh nhân V. Văn H., nam, 56 tuổi, vào viện lúc 03 giờ 26 phút ngày 22/09/2020 do ngã cầu thang, va đập hạ sườn trái xuống đất. Vào viện trong tình trạng tỉnh, đau nhiều hạ sườn trái, huyết áp 110/70 mmHg, mạch 76 L/p. Cận lâm sàng ghi nhận vỡ lách độ II-III, (phân loại theo AAST: American Association For The Surgery of Trauma- Hiệp hội Phẫu thuật viên chấn thương Hoa kỳ), (8). Siêu âm thấy lách vỡ cực dưới, máu ổ bụng lúc lượng vừa, nhiều. XN hồng cầu (HC): 4,12-Hemoglobin(Hb): 13,4 –Hematocrit (Hct) 40.8 (04g20)→ HC: 3,65-Hb: 12.1-Hct: 36.3(5g49). Huyết áp (HA) 100/60 mmHg, Mạch (M) 95(7g15). Tiến hành truyền 01 đơn vị máu; HA 95/50 mmHg (7G30)-→ 80/50mmHg, M 100l/p (08 G); đo áp lực tĩnh mạch trung âm (CVP), dự trù 02 đơn vị máu và chuyển mổ cấp cứu. Quyết định mổ đốt cầm máu qua nội soi

Bệnh nhân được mê nội khí quản, nằm nghiêng phải 45 độ. Vào ổ bụng 04 trocar, ổ bụng nhiều máu tươi, máu cục, máu đen không đông. Khối máu tụ bao quanh lách có lẫn máu tươi được gỡ bỏ. Thám sát cực dưới lách bị vỡ nát, đường kính nơi vỡ #3-5 cm Do lách ở sâu nên phải cắt dây chằng đại tràng- lách bộc lộ rõ cực dưới lách đang chảy máu. Dùng đầu đốt lưỡng cực đốt nhiều lần nơi cực dưới lách vỡ đến khi không còn chảy máu. Rửa, hút lau sạch ổ bụng. phủ Surgicell bề mặt tổn thương. Đặt dẫn lưu dưới lách và Douglas ra da. Máu mất trong ổ bụng # 700-1000 ml, truyền thêm 02 đơn vị máu sau mổ. Sau mổ các thông số máu, huyết động ổn định, dẫn lưu ra máu cặn cũ. XN sau mổ HC: 3,44, Hb 10,8, Hct 33,2%. Sau 03 ngày rút dẫn lưu Douglas, sau 05 ngày rút dẫn lưu hố lách. Bệnh nhân xuất viện khỏe, ổn.

III. BÀN LUẬN

Trường hợp này ngay cả khi Huyết động diễn biến xấu nhưng các chỉ số khối máu gần như bình thường sau nhiều giờ, do khả năng cô đặc của máu cũng sau sự sụt giảm thể tích chung (3). Theo Trần Ngọc Dũng **(**1) đề nghị truyền tới 4 đơn vị máu trong vòng 24 giờ mà không cải thiện huyết áp mới mổ, theo chúng tôi là mạo hiểm, vì máu đã mất rất nhiều, nên sau khi

truyền 01 đơn vị mà huyết áp xuống 80/50 mmHg, chúng tôi quyết định mổ, và rõ ràng là phải truyền tổng cộng tới 04 đơn vị máu các chỉ số mới về bình thường sau mổ

Hầu hết các nghiên cứu về bảo tồn lách vỡ trong chấn thương bụng kín đều lựa chọn lách vỡ độ I, II, III (2), (3), (7) theo phân độ lách vỡ trên phim chụp Ct scan theo AAST (8), (12).

Một số báo cáo trong nước (2), (7), (8) hầu hết chọn các trường hợp vỡ lách có huyết động ổn để bảo tồn. Nghiên cứu hồi cứu tại BVTƯ Huế không thống kê được các trường hợp bảo tồn thất bại, phải chuyển mổ hở, vì các trường hợp này đều loại trừ khỏi nghiên cứu. Trong khi tại Bệnh viện Nhân dân (BVND) Gia định (7), một số ca nội soi chỉ đơn thuần là quan sát, thám sát, rồi quyết định không can thiệp hoặc chuyển mổ hở. Kể cả trong nghiên cứu của Trần Ngọc Dũng(1) tại Bệnh viện Hữu nghị (BVHN) Việt Đức, các trường hợp chảy máu tiếp diễn sau can thiệp mạch hoặc không can thiệp mạch, đều chuyển mổ hở để xử lý lách vỡ. Như vậy việc can thiệp lách vỡ qua phẫu thuật nội soi đều hầu như chưa có nơi nào báo cáo, mô tả. Việc chúng tôi cố gắng xử trí đốt cầm máu lách vỡ bằng đầu đốt lưỡng cực nhằm hạn chế mổ hở đến tối đa, nhằm phục hồi sau mổ nhanh, và ít di chứng nhất có thể cho bệnh nhân. Thực tế trong các nghiên cứu của BVND Gia định (7) và BVHN Việt Đức (1), nếu chú ý đến thống kê về hình thái tổn thương lách, thì việc đốt cầm máu lách là khả thi, trong điều kiện trang bị thông thường ở tất cả các phòng mổ hiện nay. Trước đây việc ứng dụng PTNS xử lý lách vỡ là rất thận trọng, ngay tại BVHN Việt- Đức, huyết áp phải ổn mới thực hiện phẫu thuật nội soi với tính chất thăm dò, thám sát.

Ở các trung tâm lớn, nếu trên phim Ct scan có dấu thoát mạch, thường có chỉ định chụp mạch máu xóa nền (11), để nếu có chỉ định sẽ can thiệp mạch cứu sống bệnh nhân mà không cần mổ. Nhưng bản thân việc can thiệp mạch cũng tiềm ẩn biến chứng muộn sau mổ (10): đó là hiện tượng phình và giả phình sau nút mạch, tổn thương mạch máu, có thể dẫn đến vỡ lách kỳ 2, mà tỷ lệ có thể tới 15-30 % (11). Với tình hình lách vỡ, huyết áp tụt như vậy việc chuyển bệnh lên tuyến trên tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Việc bảo tồn không mổ, ngoài ra, đòi hỏi theo dõi sát tại Khoa Hồi sức với các trường hợp vỡ lách lớn và mất nhiều máu (8), trong điều kiện thực tế BVĐK Nhật Tân cũng là khá mạo hiểm.

Trong trường hợp rốn lách chảy máu đốt khó cầm, trước đây chúng tôi cũng mổ khâu tăng cường sau đốt cầm máu mà mạch máu vùng rốn lách còn chảy. Đường rạch chúng tôi chọn là đường song song dưới hạ sườn trái, vào lách rất gần, và thực hiện kỹ thuật kiểu Hand assited, đường mổ chỉ khoảng 12 cm, cà cũng khâu thành công.

Về phác đồ điều trị vỡ lách, nói chung nếu huyết động ổn thì bất động. Nếu huyết động không ổn có thể mổ bảo tồn lách (mổ hở hoặc nội soi, khâu mô lách vỡ hoặc cắt lách bán phần), hoặc cắt lách khẩn cấp khi vỡ độ IV,V và huyết động sụt giảm nghiêm trọng. Khi cắt lách cố gắng giữ lại mô lách dù nhỏ (có tác giả còn cấy mô lách vào mạc nối) (5), Nói chung vỡ lách độ I, II bảo tồn không mổ gần như 100 %, vỡ độ IV, V cũng hầu như cắt lách 100%. Còn vỡ lách độ III, có thể bảo tồn khi máu chảy ít, có thể mổ cầm máu hoặc thậm chí cắt lách cũng tùy thuộc huyết động. Trong các nghiên cứu tại Việt nam, vỡ lách độ III có rối loạn huyết động thường không bảo tồn, mà thường cắt bỏ. Chúng tôi thấy vỡ lách nếu sụt giảm huyết động không trầm trọng, có thể mổ kiểm soát chảy máu qua nội soi, giúp bảo tồn lách, mà BN không phải chịu mổ hở với nhiều bất lợi khi vết mổ thường là rất dài. Theo chúng tôi, nếu truyền 02 đơn vị máu /24 giờ mà huyết động không ổn thì nên mổ nội soi sớm, không nên để kéo dài, mất máu vô ích và theo dõi rất căng thẳng và nguy hiểm.

IV. KẾT LUẬN

Với tình hình trang thiết bị hiện tại tại BVĐ K Nhật Tân, việc xử lý tổn thương lách vỡ qua phẫu thuật nội soi là hoàn toàn khả thi. Trong giai đoạn phát triển mới của bệnh viện, tiêu

chí của chúng tôi sẽ là ưu tiên phẫu thuật ít xâm hại, cố gắng kiểm soát tất cả các thương tổn vùng bụng bằng phẫu thuật nội soi, phấn đấu để bệnh nhân ít đau, mau phục hồi và có tính thẩm mỹ cao sau mổ. Trong vỡ tạng đặc nói riêng hay trong phẫu thuật các thương tổn vùng bụng khác, tiêu chí đó sẽ được cụ thể hóa như sau: bảo tồn, khi thất bại chuyển mổ nội soi; mổ nội soi có khó khăn sẽ mở đường nhỏ; cuối cùng mới là phẫu thuật mở thông thường- nhưng với đường mổ ngắn nhất có thể (Conservation→ Laparoscopic→ Hand assited→ Open.)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Trần Ngọc Dũng** (2019). *Nghiên cứu điều trị không mổ vỡ lách trong chấn thương bụng kín tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức,* Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà nội
2. **Phan Đình Tuấn Dũng, Hoàng Trọng Nhật Phương, Lê Quốc Phong** và cs. *Đánh giá kết quả bảo tồn chấn thương lách tại Bệnh viện Trung ương Huế giai đoạn 2006-20010.* Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh , tập 14, phụ bản số 2, 2010, 101-105.
3. **Trần Văn Đáng** (2010). *Nghiên cứu chỉ định và kết quả điều trị bảo tồn vỡ lách do chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.* Luận án Tiến sĩ Y học, Học Viện Quân Y.
4. **Trần Bình Giang** (2001). *Nghiên cứu phẫu thuật bảo tồn trong điều trị vỡ lách chấn thương tại Bệnh viện Việt Đức.* Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà nội.
5. **Trần Bình Giang, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Hùng** (2006). *Chỉ định và kết quả bước đầu điều trị bảo tồn không mổ chấn thương gan tại Bệnh viện Việt- Đức 2004-2005.* Tạp chí Ngoại khoa, 56, 97-104
6. **Phạm Gia Khánh, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thanh Tâm** (1995). *Nhận xét chẩn đoán và điều trị 128 trường hợp tổn thương tạng đặc tại Bệnh viện 103 và 108 trong 15 năm (1980-1995).* Tạp chí Ngoại khoa, 9, 137-148.
7. **Phạm Ngọc Lai, Phan Minh Trí, Nguyễn Thế Hiệp** (2001). *Điều trị bảo tồn lách do chấn thương tại Bệnh viện Nhân dân Gia định.* Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh, 5 (4), 123-127.
8. **Phạm Văn Thuyên** (2008). *Nghiên cứu không mổ vỡ lách do chấn thương tại Bệnh viện Việt- Đức giai đoạn 2006-2007.* Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà nội.
9. **Banerjee A., Duane T.M., Wilson S.P. et al** (2013). *Trauma center variation in splenic artery embolization and spleen salvage: a multicenter analysis.* Journal of Trauma and Acure Care Surgery, 75(1). 69-75
10. **Fitoz S., Atasoy C., Düşünceli E. et al** (2001). *Post – traumatic intrasplenic pseudoaneurysms with delayed rupture: Color Doppler sonographic and CT findings. Journal of clinical ultrasound,* 29(2), 102-104.
11. **I. Gheju, M. D. Venter, M. Beuran et al** (2013). *Grade IV blunt splenic injury–the role of proximal angioembolization. A case report and review of literature*. *Journal of medicine and life,* 6(4), 369.
12. **King H. and Shumacker H.B.** (1952). *Splenic studies: Susceptibility to infection after splenectomy performed in infancy*. *Annals of surgery*, 136(2), 239-242.
13. **Moore E.E., Cogbill T.H., Malangoni M. et al** (1996). *Scaling system for organ specific injuries. Current Opinion in Critical Care,* 2, 450-462.
14. **Peitzman A.B., Ferrada P. and Puyana J.C.** (2009). *Nonoperative management of blunt abdominal trauma: have we gone too far?* Surgical Infections (Larchmt). 10(5), 427-33.
15. **Peitzman A.B., Harbrecht B.G., Rivera L. et al** (2005). *Failure observation of blunt splenic injury in adults: variability in practice and of adverse consequences. Journal of the American College of Surgeons,* 201(2), 179-187.
16. **Subcommittee A.T.L.S., Tchorz K.M. and International ATLS working group** (2013). *Advanced trauma life support (ATLS®): The ninth edition. The Journal Of Trauma And Acute Care,* 74(5), 1363. Van der Vlies C. H., Hoekstra J., Ponsen K. J. et al (2012).

Impact of Splenic Artery Embolization on the Success Rate of Nonoperative Management for Blunt Splenic Injury. Cardiovascular and Interventional Radiology, 35(1), 76-81.

TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

Ngô Phi Nhựt Thi,
Nguyễn Thị Thanh Loan, Châu Thiên Bình

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ vi khuẩn phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm, đánh giá tình hình đề kháng kháng sinh từ các chủng vi khuẩn phân lập được. ***Đối tượng nghiên cứu:*** Các chủng vi khuẩn phân lập được từ tất cả các loại bệnh phẩm của bệnh nhân khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nhật Tân từ tháng 04/2018 đến 9/2020. Đặc điểm mẫu: Cầu khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm hiếu khí. **Phương pháp:** Hồi cứu, mô tả cắt ngang. **Kết quả:** Từ 2783 mẫu bệnh phẩm được nuôi cấy, có 856 mẫu dương tính chiếm 31%, 5 chủng vi khuẩn có tỷ lệ cao nhất tại Bệnh viện Nhật Tân là *E.coli* (49%), *S. aureus* (13%), *Klebsiella pneumoniae* (9%), *S.* coagulase (-) (5%), *Pseudomonas spp* (4%). Trong đó, ***E.coli*** đề kháng với hầu hết kháng sinh nhóm Cephalosporin, *S. aureus* Đề kháng cao với Benzylpenicillin (99%), Erythromycin (92%), Clindamycin (90%), Oxacillin (88%), *K. pneumoniae* đề kháng 100% với Ampicillin, *Pseudomonas. Spp* đề kháng cao nhất Levofloxacin (41%), *S. coagulase (-)* kháng với P-Benzylpenicillin (94%), Oxacillin (91%), Erythromycin (97%), Clindamycin (59%).

Từ khóa: Kháng kháng sinh, vi khuẩn

Viết tắt: AMR, Antimicrobial Resistance;

CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute (viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Phòng xét nghiệm)

ABSTRACT

Objective: Determine the rate of bacteria isolation from the patient samples, identify the antibiotic resistance situation from isolated species. **Research subjects:** Bacterial species isolated from all types of patient's medical examination and treatment at Nhat Tan General Hospital from April 2018 to september 2020. General features: Gram-positive cocci and aerobic gram-negative bacteria. **Methods:** Retrospective, descriptive and cross-sectional methods. **Results:** From 2783 cultured patient sample, 5 species of bacteria with the highest rate at Nhat Tan Hospital were E.coli (49%), S. aureus (13%), Klebsiella pneumoniae (9%), S. coagulase (-) (5%), Pseudomonas spp (4%). In which, E.coli is resistant to most Cephalosporin and S. aureus antibiotics High resistance to Benzylpenicillin.

(99%), Erythromycin (92%), Clindamycin (90%), Oxacillin (88%), K. pneumoniae 100% resistance to Ampicillin, Pseudomonas. Spp is most resistant to Levofloxacin (41%), S. coagulase (-) is resistant to P-Benzylpenicillin (94%), Oxacillin (91%), Erythromycin (97%), Clindamycin (59%).

ĐẶT VẤN ĐỀ

Thuốc kháng sinh có vai trò rất quan trọng trong điều trị, việc sử dụng quá liều và lạm dụng kháng sinh là nguyên nhân dẫn đến kháng kháng sinh (Antimicrobial Resistance - AMR). Ước tính đến năm 2050 tử vong do AMR lên đến 10 triệu người [6]. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ định điều trị, lựa chọn tác nhân hoặc thời gian điều trị kháng sinh là không chính xác trong 30% đến 50% trường hợp [7], đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến AMR.

Tại Việt Nam, số liệu báo cáo của 15 bệnh viện trực thuộc Bộ năm 2009, 30 - 70% vi khuẩn gram âm đã kháng với cephalosporin thế hệ 3 và thế hệ 4, gần 40-60% kháng với aminoglycosid và fluoroquinolon [1]. Do đó, việc khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh tại bệnh viện là rất cần thiết như một định hướng cho việc sử dụng kháng sinh hợp lý, góp phần giảm tỷ lệ kháng thuốc, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí cho người bệnh. Nghiên cứu này có 2 mục tiêu cụ thể:

- Xác định tỷ lệ vi khuẩn phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm
- Đánh giá tình hình đề kháng kháng sinh từ các chủng vi khuẩn phân lập được.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu:

Là các chủng vi khuẩn phân lập được từ tất cả các loại bệnh phẩm của bệnh nhân khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nhật Tân từ tháng 04/2018 đến 9/2020. Đặc điểm mẫu: Cầu khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm hiếu khí.

Tiêu chuẩn chọn mẫu: Có đủ kết quả định danh và kháng sinh đồ

Phương pháp: Hồi cứu, mô tả cắt ngang.

Phương tiện: Phân lập vi khuẩn từ bệnh phẩm trên môi trường Blood Agar và MacConkey. Định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ bằng hệ thống tự động Vitek2 compact. Kết quả xác định theo Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Phòng xét nghiệm (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI)

Xử lý số liệu: Số liệu được thu thập và phân tích bằng Excel

KẾT QUẢ

Trong tổng số 2783 mẫu bệnh phẩm được nuôi cấy, có 856 mẫu dương tính chiếm 31%, trong đó mẫu phân dương tính cáo nhất 89%, mẫu máu dương tính thấp nhất 13%. 5 chủng vi khuẩn có tỉ lệ cao nhất là *E.coli*, *S. aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *S.* coagulase (-), *Pseudomonas spp.*

Bảng 1. Tỷ lệ vi khuẩn phân bố theo bệnh phẩm.

Vi khuẩn	Máu		Mủ		Nước tiểu		Đàm		Dịch		Phân		Phết họng	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
E.coli	65	32	85	31	70	77	3	7	3	60	196	82	0	0
S. aureus	18	9	86	31	3	3	3	7	1	20	0	0	1	50
K.pneum	19	9	21	8	5	6	0	0	0	0	20	8	0	0
S. coagulase (-)	30	15	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50
Pseudomonas spp	2	1	22	8	2	2	12	29	0	0	0	0	0	0
Vi khuẩn khác	69	34	51	19	11	12	24	57	1	20	23	10	0	0
Tổng	203		274		91		42		5		239		2	

E.coli và *S. aureus* có trong hầu hết các mẫu bệnh phẩm; trong đó *E.coli* chiếm ưu thế trong phân, dịch, nước tiểu với tỷ lệ lần lượt là 82%, 77%, 60%. *S. aureus* trong phết họng (50%), mủ (31%), dịch (20%). *Pseudomonas spp* chủ yếu là *Ps.aeruginosa* chiếm ưu thế trong các bệnh phẩm đàm 29%.

Bảng 2. Tỷ lệ AMR của vi khuẩn *E.coli*

Kháng sinh	n	R	%R
Ampicillin	317	290	91
Trimethoprim/Sulfamethoxazole	323	233	72
Cefazolin	316	208	66
Levofloxacin	324	212	65
Ciprofloxacin	324	209	65
Ceftazidime	324	196	60
Ceftriaxone	317	191	60
Cefepime	318	177	56
Ampicillin/Sulbactam	316	153	48
Gentamicin	323	152	47
Tobramycin	324	51	16
Piperacillin/Tazobactam	321	28	9
Ertapenem	317	13	4
Imipenem	311	7	2
Amikacin	324	2	1
Nitrofurantoin	317	2	1

Vi khuẩn E.coli đề kháng cao với Ampicillin (91%), còn nhạy cảm khá tốt với Amikacin, Imipenem, Nitrofurantoin

Bảng 3. Tỷ lệ AMR của *Staphylococcus aureus*

Kháng sinh	n	R	%R
Benzylpenicillin	106	105	99
Erythromycin	106	97	92
Clindamycin	106	95	90
Oxacillin	106	93	88
Tetracycline	106	75	71
Trimethoprim/Sulfamethoxazole	106	43	41
Gentamicin	106	34	32
Ciprofloxacin	106	31	29
Levofloxacin	106	30	28
Moxifloxacin	106	26	25
Vancomycin	106	7	7
Rifampicin	106	2	2
Linezolid	106	1	1
Quinupristin/Dalfopristin	106	1	1
Nitrofurantoin	106	0	0

Staphylococcus aureus đề kháng 99% với Benzylpenicillin, cũng đề kháng khá cáo với Erythromycin, Clindamycin, Oxacillin nhưng còn nhay cảm với Nitrofurantoin, Linezolid, Vancomycin,

Bảng 4. Tỷ lệ AMR của *Klebsiella pneumoniae*

Kháng sinh	n	R	%R
Ampicillin	60	60	100
Cefazolin	60	25	42
Trimethoprim/Sulfamethoxazole	60	25	42
Ceftriaxone	60	21	35
Ampicillin/Sulbactam	60	21	35
Cefepime	60	20	33
Ciprofloxacin	60	18	30
Levofloxacin	60	18	30
Gentamicin	60	17	28
Tobramycin	60	12	20
Nitrofurantoin	60	9	15
Piperacillin/Tazobactam	60	7	12
Ertapenem	60	5	8
Imipenem	57	2	3

Vi khuẩn *Klebsiella pneumoniae* đề kháng 100% với Ampicillin nhưng còn nhạy cảm khá tốt với Amikacin, Imipenem

Bảng 5. Tỷ lệ AMR của *Pseudomonas. spp*

Kháng sinh	n	R	%R
Levofloxacin	32	13	41
Ciprofloxacin	32	8	25
Gentamicin	31	5	16
Imipenem	30	4	13
Ceftazidime	32	3	9
Cefepime	32	3	9
Amikacin	32	2	6
Tobramycin	32	2	6
Piperacillin/Tazobactam	31	2	6

Pseudomonas spp chủ yếu là *Pseudomonas aeruginosa* tỷ lệ đề kháng thấp, nhạy cảm tốt với Amikacin, Ceftazidime, Cefepime.

Bảng 6. Tỷ lệ AMR của *S. coagulase (-)*

Kháng sinh	n	R	%R
P-Benzylpenicillin	32	30	94
Oxacillin	32	29	91
Erythromycin	32	24	75
Clindamycin	32	19	59
Trimethoprim/Sulfamethoxazole	32	17	53
Tetracycline	32	16	50
Levofloxacin	32	15	47
Ciprofloxacin	32	14	44
Moxifloxacin	32	8	25
Rifampicin	32	6	19
Gentamicin	32	5	16
Vancomycin	32	3	9
Linezolid	32	2	6
Quinupristin/Dalfopristin	32	1	3
Nitrofurantoin	32	0	0

S. coagulase (-) đề kháng cao nhất với P-Benzylpenicillin, Oxacillin còn nhạy cảm với tốt với Nitrofurantoin, Linezolid, Vancomycin

BÀN LUẬN

Các loại vi khuẩn thường gặp tại bệnh viện:

5 chủng vi khuẩn có tỷ lệ phân lập được cao nhất tại Bệnh viện Nhật Tân là *E.coli* (49%), *S. aureus* (13%), *Klebsiella pneumoniae* (9%), *S.* coagulase (-) (5%), *Pseudomonas spp* (4%). Đây cũng là những chủng vi khuẩn chiếm ưu thế tại Bệnh viện Sản nhi An Giang 2019-2020 [4] *E.coli* (41,82%), *Enterobacter* (33,05%), *S. coagulase (-)* (9,95%), *S. aureus* (2,78%), *Pseudomonas spp* (0.86%). Cũng gần giống tại Bệnh viện Bình An 2010 [2], Bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức năm 2013 [3].

Theo Marchaim và cs [5] các mầm bệnh đa kháng thuốc phổ biến nhất được phân lập trong các ICU bao gồm Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA), cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE), Pseudomonas aeruginosa kháng carbapenem, Acinetobacter baumannii và Enterobacteriaceae sản xuất beta-lactamase phổ rộng. Enterobacteriaceae kháng carbapenem cũng đang gia tăng tỷ lệ lưu hành.

Tỷ lệ dương tính thấp nhất ở bệnh phẩm máu (13%), điều này phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân: đã sử dụng kháng sinh phổ rộng trước đó, lượng máu không đủ vi khuẩn mọc (mặc dầu Khoa đã trang bị hệ thống nuôi cấy tự động), phần lớn các trường hợp là cấy 1 lần.

Tỷ lệ AMR của vi khuẩn:

- ***E.coli* (bảng 2)**

  Là vi khuẩn gặp nhiều nhất qua các năm khi phân lặp tại bệnh viện, trong nghiên cứu này chiếm 49%, năm 2017 là 34% đề kháng với hầu hết kháng sinh nhóm Cephalosporin kể cả thế hệ 4 (cefepim là 56%), thấp hơn tại bệnh viện Sản Nhi là 73,58% [6], còn nhạy

cảm tốt với Amikacin (99%), Imipenem (97%), Nitrofurantoin (96%), Ertapenem (96%), Piperacillin/Tazobactam (85%).

- ***Staphylococcus aureus*** **(bảng 3)**

  Là vi khuẩn gây bệnh đứng hàng thứ 2 và là vi khuẩn thường gây nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Đề kháng cao với Benzylpenicillin (99%), Erythromycin (92%), Clindamycin (90%), Oxacillin (88%), còn nhạy cảm tốt với Nitrofurantoin (100%), Linezolid (99%), Vancomycin (93%), Rifampicin (97%). Kháng sinh hiện nay được khuyến cáo để điều trị bước một là vancomycin. Tỷ lệ *S. aureus* đề kháng với Vancomycin rất hiếm xảy ra, cho đến nay chỉ còn vài trường hợp trên phạm vi toàn cầu có đề kháng với Vancomycin [4].

- ***Klebsiella pneumoniae*** **(bảng 4)**

  Là vi khuẩn chiếm ưu thế nhất trong họ *Enterobacteriaceae* đề kháng 100% với Ampicillin nhưng còn nhạy cảm khá tốt với Amikacin (100%), Imipenem (90%), Ertapenem (92%). Kết quả này tương tự như nghiên cứu của bệnh viện Bình An 2010 [4].

- ***Pseudomonas. Spp*** **(bảng 5)**

  Đề kháng cao nhất Levofloxacin (41%), nhạy cảm khá tốt Amikacin (94%) Imipenem (87%), Tobramycin (84%), Gentamicin và Cefepime (81%). Trong nghiên cứu này vi khuẩn ưu thế trong chủng này là *Ps. Aeruginosa.*

- ***S. coagulase (-)*** **(bảng 6)**

  Một số kháng sinh còn nhạy tốt với *S. coagulase (-)* là Nitrofurantoin (100%), Quinupristin/Dalfopristin (97%), Vancomycin (88%). Kháng với P-Benzylpenicillin (94%), Oxacillin (91%), Erythromycin (97%), Clindamycin (59%), các tỷ lệ đề kháng này cũng tương đương bệnh viện Sản Nhi lần lượt là 95,65%, 94,12%, 82,22%, 60% [4], riêng Gentamicin 72% cao hơn tại bệnh viện Nhật Tân (16%).

KHUYẾN NGHỊ

- Trong các trường hợp có nghi ngờ nhiễm khuẩn cấy máu sớm nhất khi có thể.
- Hiện tại đã đưa vào sử dụng hệ thống cấy máu tự động và sử dụng chai cấy máu có độ nhạy cao, tuy thời gian cấy máu không được rút ngắn nhiều, nhưng kết quả có độ tin cậy cao, nên xem lại thời điểm cho cấy máu và cấy máu trên 1 lần.
- Các chủng vi khuẩn này là các vi khuẩn thường xuyên được phân lập tại bệnh viện qua các năm chủ yếu từ các mẫu mủ. Do đó, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cần chặt chẽ nhất là vệ sinh tay trong chăm sóc bệnh nhân.
- Theo Marchaim và cs [5] nhiễm khuẩn hay xảy ra ở các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) vì nơi này bệnh nhân thường được đặt ống thông khá phổ biến và các mầm bệnh đa kháng thuốc khó tiệt trừ được phân lập với tần suất ngày càng tăng do tăng áp lực kháng sinh chọn lọc. Ngoài ra bệnh nhân thường có các bệnh đi kèm, thời gian nằm viện dài ngày, tiếp xúc thường xuyên với nhân viên y tế và điều trị bằng thuốc kháng sinh đều làm tăng nguy cơ xâm nhập và nhiễm các mầm bệnh đa kháng thuốc. Nhiễm các sinh vật như vậy có liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong, thời gian nằm viện và chi phí bệnh viện. Dự phòng nhiễm khuẩn bệnh viện là phải tuân thủ tốt vệ sinh tay, đề phòng tiếp xúc cho những bệnh nhân có sinh vật kháng thuốc, giảm thiểu việc nhập viện và can thiệp không cần thiết. Khử trùng môi trường tốt, giảm các biện pháp can thiệp, tắm bằng chlorhexidine chi nhân viên y tế và bệnh nhân ở ICU, khử nhiễm có chọn lọc, giám sát tích cực các mầm bệnh nhất định và giảm sử dụng ống thông. Sử dụng kháng sinh hạn

chế và thận trọng nhằm làm giảm áp lực chọn lọc thúc đẩy sự xuất hiện của các chủng vi khuẩn kháng thuốc.

THAM KHẢO

1. **Báo cáo sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh tại 15 bệnh viện Việt Nam năm 2008-2009** (Report on AB use and resistance in 15 hospitals in Vietnam 2008-2009).
2. **Mai Nguyễn Ngọc Trác**. Nghiên cứu tình hình đề kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại bệnh viện Bình An Kiên Giang năm 2010. 2013. Tạp chí Y dược học – Trường Đại học Y Dược Huế - Số 14. p 35-42.
3. **Lê Thị Kim Hương, Nguyễn Đỗ Phúc**. Khả năng đề kháng kháng sinh của một số vi khuẩn thường gặp ở bệnh nhân nhiễm trùng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. 2014. Y học Tp. Hồ Chí Minh. Tập 14, phụ bản số 6, p 326 – 331.
4. **Lê Thanh Trúc, Lê Thị Giáng Kiều, Nguyễn Thoại Bình, Nguyễn Minh Thông**. Khảo sát vi khuẩn, mức độ đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn phân lập tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang năm 2019-2020. Kỷ yếu hội nghị khoa học kỷ thuật năm 2020. p 208 - 218
5. **Marchaim D, Kaye K, Harris A, Mitty J. Infections and antimicrobial resistance in the intensive care unit**: Epidemiology and prevention. UpToDate. Oct 2020.
6. **The Review on Antimicrobial Resistance Chaired by Jim O'Neill**
7. **December 2014C Lee Ventola. The Antibiotic Resistance Crisis**, 2015. 40 (4) P277-283

KHẢO SÁT TỶ LỆ MỔ LẤY THAI THEO NHÓM PHÂN LOẠI ROBSON TẠI BỆNH VIỆN NHẬT TÂN NĂM 2020

Dương Thị Nhan, Trịnh Thanh Nhung, Ngụy Khiêm Thắng, Nguyễn Thị Huệ, Trương Thanh Thanh

Mục tiêu: Tỷ lệ mổ lấy thai (MLT) ngày càng tăng ở bệnh viện Nhật Tân cũng như nhiều bệnh viện khác, việc phân loại MLT theo Robson là cần thiết nhằm giảm thiểu tỷ lệ này. **Đối tượng nghiên cứu:** Các sản phụ đến sanh tại bệnh viện Nhật Tân từ ngày 15/11/2019 cho đến 14/11/2020. **Phương pháp nghiên cứu:** Hồi cứu mô tả. **Kết quả:** Tỷ lệ MLT trong năm 2020 là 49,1% (518/1.054). Kích cỡ của mỗi nhóm so với tổng số sản phụ đến sanh xếp từ thấp đến cao như sau: nhóm 4 với 4,7%; nhóm 2 với 12,6%; nhóm 5 với 17,3%; nhóm 1 với 24,2% và nhóm 3 với tỷ lệ 34,9%. Về tỷ lệ MLT của mỗi nhóm biến thiên từ 68,4% lên đến 100% bao gồm các nhóm 2, 4, 5, 6, 7 và 9. Đóng góp MLT của mỗi nhóm vào tỷ lệ MLT chung chỉ có 5 nhóm đầu có đóng góp đang kể và tỷ lệ MLT chung từ 3,9% lên đến 16,7% bao gồm các nhóm: 4, 1, 3, 2 và 5. Các nhóm còn lại có tỷ lệ thấp nên không bàn luận. **Kết luận**: Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy MLT xảy ra nhiều nhất ở nhóm 2, 4, 5, 6 và 9. Nhưng đóng góp nhiều nhất vào tỷ lê MLT chung là các nhóm từ 1 đến 5. Vậy muốn giảm tỷ lệ MLT thì nên tìm cách giảm MLT ở các sản phụ thuộc các nhóm này.

Từ khóa: Mổ lấy thai, phân loại Robson về mổ lấy thai.

SUMMARY: Survey of cesarean section rate by Robson classification group at Nhat Tan Hospital in 2019. Objective: The rate of cesarean section is increasing at Nhat Tan hospital as well as many other hospitals, the cesarean section classification according to Robson is necessary to reduce this rate. **Study subjects**: Pregnant women delivered birth at Nhat Tan Hospital from November 15, 2019 to November 14, 2020. **Research method**: Retrospective description. **Results**: Rate of cesarean section in 2020 will be 49.1% (518/1,054). The size of each group relative to the total number of women born to birth ranged from low to high as follows: group 4 with 4.7%; group 2 with 12.6%; group 5 with 17.3%; group 1 with 24.2%; and group 3 with rate 34.9%. The cesarean section rate of each group varied from 68.4% up to 100%, including groups 2, 4, 5, 6, 7 and 9. The cesarean section contribution rate of each group to the general cesarean section rate had only the first 5 groups. having significant contributions and overall cesarean section rate from 3.9% up to 16.7% including groups: 4, 1, 3, 2, and 5. The rest of the groups have low rates. Conclusion: Our study found that cesarean section occurs the most in groups 2, 4, 5, 6, and 9. But the most contributors to the overall cesarean section rate are groups from 1 to 5. Therefore, in order to reduce the cesarean section rate, it is necessary to find ways to reduce the cesarean section rate in these groups of the pregnant women.

Keywords: cesarean section, **Robson classification for caesarean section**

ĐẶT VẤN ĐỀ

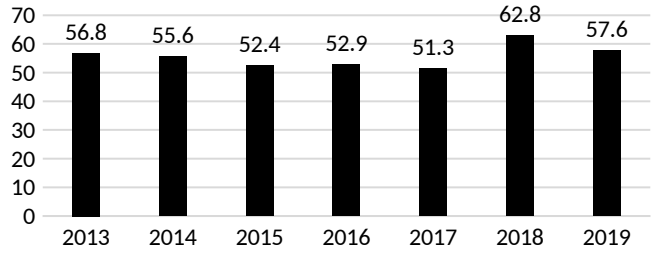
Tỷ lệ MLT ngày càng tăng lên ở nhiều nước phát triển cũng như đang phát triển do nhiều lý do. Tỷ lệ MLT hiện là một mối quan tâm chủ yếu về sức khỏe cộng đồng và tạo ra các cuộc tranh luận trên toàn thế giới do những rủi ro tiềm ẩn của bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tỷ lệ MLT đã tăng đều nhưng không đi kèm với lợi ích nào đáng kể cho mẹ và thai nhi. Ngược lại, một khi vượt quá một ngưỡng nhất định, việc tăng tỷ lệ sinh mổ có thể liên quan đến việc tăng tỷ lệ mắc bệnh của mẹ và chu sinh [1]. Để giảm thiểu xu hướng này và đề ra các biện pháp nhằm giảm hoặc tăng tỷ lệ CS khi cần thiết, cần phải có công cụ theo dõi và so sánh tỷ lệ CS trong cùng một bệnh cảnh theo thời gian và giữa các bệnh cảnh khác nhau [2]. Năm

2011 của Torloni và cs khảo sát 27 hệ thống phân loại MLT đã xác định hệ thống phân loại 10 được Robson đề xuất vào năm 2001 là phù hợp nhất để so sánh tỷ lệ MLT. Hệ thống của Robson xếp loại tất cả trường hợp sinh mổ vào 10 nhóm trên cơ sở các thông số: tiền sử sản khoa (số lần sanh và sinh mổ trước đó), khởi phát chuyển dạ (tự phát, giục sanh hoặc sinh mổ trước khi bắt đầu chuyển dạ), ngôi thai (ngôi đầu, mông, hoặc ngang), số trẻ sơ sinh và tuổi thai (sinh non hoặc đủ tháng). Mỗi sản phụ có thể được phân loại ngay lập tức trên cơ sở một vài biến được nhận. Hệ thống này giúp giám sát, kiểm toán và tìm ra một phương pháp so sánh được tiêu chuẩn hóa giữa các tổ chức, quốc gia và các thời điểm [1,2,6].

Hệ thống phân loại này nên áp dụng trên bình diện quốc tế và nó cũng hữu ích cho các bác sĩ lâm sàng, quản lý cơ sở, y tế công cộng chính quyền và bản thân phụ nữ. Một hệ thống như vậy phải đơn giản, có liên quan về mặt lâm sàng, có trách nhiệm giải trình, có thể tái tạo và có thể kiểm chứng. Tuyên bố của WHO về phân loại Robson như một tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá, theo dõi và so sánh sinh mổ trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe qua thời gian, và giữa các cơ sở [2].

Ở Việt Nam, tỷ lệ MLT cũng ngày càng tăng, Nguyễn Đức Hinh và cs đã viện dẫn các tỷ lệ MLT ở Viện Bả vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh như sau: 1961, 8,3%; 1970, 9.6%; 1978, 16,7% và 1983-1985, 12,9%. Các tỷ lệ này tương đương với thống kê ở Pháp và Mỹ cùng thời kỳ [3].

Hình 1. Tỷ lệ MLT từ năm 2013 đến năm 2019 tại bệnh viện Nhật Tân.



Do tình hình chung, tỷ lệ MLT tại khoa Phụ Sản bệnh viện Nhật Tân trong các năm qua ngày càng tăng: 2013, 56,8%; 2014, 55,6%; 2015; 52,4%; 2016, 52,9%; 2017, 51,3%; 2018, 62,8%; 2019, 57,6%. Bởi thế, chúng tôi quyết tâm áp dụng phương pháp phân loại Robson nhằm nhận biết một số vấn đề trong chỉ định MLT và qua đó rút ra một số giải pháp làm giảm tỷ lệ MLT.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các sản phụ vào sanh tại khoa Phụ Sản, bệnh viện Nhật Tân, Châu Đốc, An Giang trong thời gian nghiên cứu.

Tiêu chuẩn chọn: Các sản phụ đến sanh thường hoặc sanh mổ tại bệnh viện Nhật Tân. **Tiêu chuẩn loại trừ**: Thai lưu, thai <28 tuần.

Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu mô tả.

Cỡ mẫu: Toàn bộ sản phụ đến sanh tại khoa Phụ Sản trong 1 năm.

Thời gian nghiên cứu: Một năm, từ 15/11/2019 cho đến 14/11/2020

Phân loại 10 nhóm sản phụ theo Robson

TT	Phân loại Robson
1	Con so, đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần, chuyển dạ (CD) tự nhiên
2	Con so, đơn thai, ngôi đầu >37 tuần, khởi phát chuyển dạ hoặc MLT trước chuyển dạ
3	Con rạ (không có vết mổ cũ, VMC), đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần, chuyển dạ tự nhiên
4	Con rạ (không VMC), đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần, khởi phát CD hoặc MLT trước CD

5	Có VMC, đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần
6	Tất cả con so, ngôi mông
7	Tất cả con ra, ngôi mông (cả VMC)
8	Tất cả đa thai (bao gồm VMC)
9	Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm VMC)
10	Tất cả các trường hợp đơn thai, ngôi đầu ≤36 tuần (bao gồm VMC)

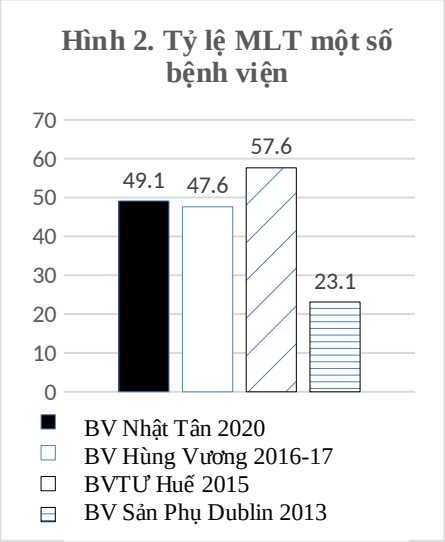
Cách tính

- Kích cỡ mỗi nhóm % = (Số sản phụ mỗi nhóm/Tổng số sản phụ) x100
- Tỷ lệ MLT mỗi nhóm %= (số MLT/tổng số của nhóm đó) x 100
- Góp vào MLT mỗi nhóm vào tỷ lệ chung MLT=(Số MLT mỗi nhóm/Tổng số MLT)x100

Xử lý thống kê: Nhập số liệu vào Excel, xử lý thống kê bằng SPSS Statistics 20.0.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

TT	Phân loại 10 nhóm theo Robson	Tỷ lệ MLT từng nhóm của một số bệnh viện			
		BV Nhật Tân 2020 49.1%	BV Hùng Vương 2016-17 [4] 47.6%	BVTƯ Huế 2015[5] 57,57%	BV Phụ Sản Ireland 2013 [6] 23,1%
1	Con so, đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần, CD tự nhiên	21,5	40.4	35,28	7,1
2	Con so, đơn thai, ngôi đầu >37 tuần, khởi phát chuyển dạ hoặc MLT trước chuyển dạ	89,5	72,8	82,68	35,9
3	Con rạ (trừ có VMC), đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần, CD tự nhiên	20,7	13,1	25,69	1,2
4	Con rạ (trừ VMC), đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần, khởi phát CD hoặc MLT trước CD	82,0	66,0	40,35	13,8
5	Có VMC, đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần	96,7	89,6	97,63	68,1
6	Tất cả con so ngôi mông	100,0	94,3	92,32	93.8
7	Tất cả con ra ngôi mông (cả VMC)	68,4	97,7	84,67	89.9
8	Tất cả đa thai (VMC)	50,0	85,1	71,72	65.7
9	Tất cả ngôi bất thường (cả VMC)	100,0	100,0	100,0	100,0
10	Tất cả các trường hợp đơn thai, ngôi đầu ≤36 tuần (cả VMC)	45,5	39,8	83,59	30,7



BV Nhật Tân 2020
BVTƯ Huế 2015
BV Hùng Vương 2016-17
BV Sản Phụ Dublin 2013

Bảng 2. ***So sánh phân loại Robson trong MLT về tỷ lệ MLT trong từng nhóm với các tác giả trong và ngoài nước***

TT	**Phân loại 10 nhóm theo Robson**	Số MLT/TS thai phụ mỗi nhóm 518/1054(49.1%)	Kích cỡ mỗi nhóm (%)	Tỷ lệ MLT của nhóm (%)	Góp vào MLT mỗi nhóm, 49,1%
1	Con so, đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần, CD tự nhiên	55/256	24,2	21,5	5,2
2	Con so, đơn thai, ngôi đầu >37 tuần, khởi phát chuyển dạ hoặc MLT trước chuyển dạ	119/133	12,6	89,5	11,3
3	Con rạ (trừ có VMC), đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần, CD tự nhiên	76/368	34,9	20,7	7,2
4	Con rạ (trừ VMC), đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần, khởi phát CD hoặc MLT trước CD	41/50	4,7	82,0	3,9
5	Có VMC, đơn thai, ngôi đầu, >37 tuần	176/182	17,3	96,7	16,7
6	Tất cả con so ngôi mông	11/11	1	100,0	1,0
7	Tất cả con ra ngôi mông (cả VMC)	13/19	1,8	68,4	1,2
8	Tất cả đa thai (VMC)	2/4	0,4	50,0	0.2
9	Tất cả ngôi bất thường (cả VMC)	20/20	1,9	100,0	1.9
10	Tất cả các trường hợp đơn thai, ngôi đầu ≤36 tuần (cả VMC)	5/11	1	45,5	0,5

BV Nhật Tân 2020
BVTƯ Huế 2015
BV Hùng Vương 2016-17
BV Sản Phụ Dublin 2013
BV Nhật Tân 2020
BVTƯ Huế 2015
BV Hùng Vương 2016-17
BV Sản Phụ Dublin 2013

BÀN LUẬN

Về tỷ lệ MLT ở các sản phụ đến sanh tại bệnh viện Nhật Tân.

Trong thời gian nghiên cứu 1 năm từ 15/11/2019 cho đến 14/11/2020, có 1.054 sản phụ đến sinh tại bệnh viện Nhật Tân. Trong đó có 518 sản phụ phải MLT, chiếm tỷ lệ 49,1% trong năm 2020. Tỷ lệ này được xem là thấp nhất trong các năm vừa qua: 2013, 56,8%; 2015; 52,4%; 2018, 62,8%, 2019, 57,6%. Tỷ lệ MLT năm 2020 giảm một phần là do chúng tôi kiểm tra từng trường hợp MLT mỗi ngày về tính hợp lý của từng ca MLT. Khi so sánh với các bệnh viện trong nước thì có phần khập khiễng vì các bệnh viện có một hạng khác nhau, và thời điểm nghiên cứu khác nhau, nhưng so với bệnh viện Trung Ương Huế vào năm 1015 [5], thì tỷ lệ MLT là 57,57%, bệnh viện Hùng Vương năm 2016-17 [4] thì tỷ lệ này là 47,6%. Trong khi đó, trong nghiên cứu của chính Robson và cs vào năm 2013 tại bệnh viện Phụ Sản Quốc gia ở Dublin, Ireland [6] thì MLT chỉ chiếm 23,1%. Điều này cho thấy tỷ lệ MLT ổ bệnh viện chúng tôi cũng như cả nước còn quá cao dù chúng tôi đã cố gắng nhiều để giảm tỷ lệ này. Giảm tỷ lệ sinh mổ từ lâu đã là mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới khi khuyến cáo tỷ lệ MLT không quá 15% tổng số ca sinh [2].

Về tỷ lệ kích cỡ mỗi nhóm so với tổng số sản phụ đến sanh

Nghiên cứu của chúng tôi thì từ cao đến thấp như sau: nhóm 3 với tỷ lệ 34,9%; nhóm 1 với 24,2%; nhóm 5 với 17,3%; nhóm 2 với 12,6%; nhóm 4 với 4,7%. Các nhóm còn lại từ nhóm 6 đến nhóm 10 thấp nhất chỉ biến thiên từ 0,4 đến 1,9. Các tỷ lệ này khá phù hợp với nghiên cứu của Hoàng Ngọc Tú ở bệnh viện Trung Ương Huế [5] với các tỷ lệ này lần lượt là: nhóm 3, 25,1%; nhóm 1, 23,5%; nhóm 5, 20,2%; nhóm 2, 12,3%; nhóm 4, 7,3%. Các nhóm từ 6-10 biến thiên từ 0,8 đến 4,7. Trình tự này cũng giống với nghiên cứu của Robson và cs năm 2013 [6] ở 5 nhóm đầu. các nhóm từ 6-10 biến thiên từ 0,5 (nhóm 9) đến 3,9 (nhóm 10). Nghiên cứu của Đoàn Vũ Đại Nam và Nguyễn Duy Tài ở bệnh viện Hùng Vương [4] thì hơi khác 5 nhóm đầu theo thứ tự từ cao xuống thấp: nhóm 1, 3, 5, 2 và 4. Các nhóm từ 6 đến 10 cũng tương tự từ 0,7 đến 1,8%, chỉ duy nhất nhóm 10 với 7%.

Về tỷ lệ MLT của mỗi nhóm

Ở bệnh viện Nhật Tân từ nhóm sau đây biến thiên từ 68,4% lên đến 100% bao gồm các nhóm 2, 4, 5, 6, 7 và 9. Các nhóm còn lại biến thiên từ thấp nhất 21,5 nhóm 1 lên đến 50% ở nhóm 8. Bệnh viện Hùng Vương [4] biến thiên từ 66% cho đến 100% gồm các nhóm sau đây: 4, 2, 8, 5, 6, 7 và 9. Còn lại biến thiên từ 13,1 đến 40,4 bao gồm các nhóm: 3, 10 và 1. Bệnh viện Trung Ương Huế biến thiến từ 71,72% lên đến 100% gồm các nhóm sau đây: 8, 2, 7, 10, 6, 5 và 9; còn lại biến thiên từ 25,69 đến 40,35 bao gồm các nhóm 3, 1 và 4 [5]. Nghiên cứu ở Dublin [6] cho thấy tỷ lệ MLT của mỗi nhóm cao từ 65,7% đến 100% bao gồm các nhóm 8, 5, 7, 6 và 9; còn lại biến thiên từ 1,2% lên đến 35,9% bao gồm các nhóm 3, 1, 4, 10 và 2.

Đóng góp MLT của mỗi nhóm vào tỷ lệ MLT chung.

BV Nhật Tân chỉ có 5 nhóm đầu có đóng góp đang kể và tỷ lệ MLT chung từ 3,9% lên đến 16,7% bao gồm các nhóm: 4, 1, 3, 2 và 5. Các nhóm còn lại biến thiên từ 0,2 đến 1,9 bao gồm các nhóm: 8, 10, 6, 7 và 9. Bệnh viện Hùng Vương [4] biến thiên từ 2,8% cho đến 15,1% gồm các nhóm sau đây: 10, 3, 2, 1 và 5. Còn lại biến thiên từ 0,7% đến 2% bao gồm các nhóm: 9, 8, 6, 7 và 4. Bệnh viện Trung Ương Huế [5] biến thiến từ 2,95% lên đến 19,73% gồm các nhóm sau đây: 4, 6, 3, 1, 2, 5; còn lại biến thiên từ 0,8 đến bao gồm các nhóm 9, 7, 8 và 10. Nghiên cứu ở Dublin cho thấy tỷ lệ MLT của mỗi nhóm cao từ 1,5% đến 7,8% bao gồm các nhóm 4, 8, 1, 6, 2 và 5; còn lại biến thiên từ 0.5% lên đến 1,4% bao gồm các nhóm 3, 9, 10 và 7 [6].

KẾT LUẬN: Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy MLT xảy ra nhiều nhất ở nhóm 2, 4, 5, 6 và 9. Nhưng đóng góp nhiều nhất vào tỷ lê MLT chung là các nhóm từ 1 đến 5. Vậy muốn giảm tỷ lệ MLT thì nên tìm cách giảm ở các sản phụ thuộc nhóm này.

THAM KHẢO

1. **Vogel JP, Betrán AP, Vindevoghel N, Souza JP, Torloni MT, Zhang J, Tunçalp Ö, Mori R, Morisaki N, Panozo EOP, Hernandez BH, Pérez-Cuevas R, Qureshi Z, Gülmezoglu AM, Temmerman M**. On behalf of the WHO Multi-Country Survey on Maternal and Newborn Health Research Network. Use of the Robson classification to assess caesarean section trends in 21 countries: a secondary analysis of two WHO multicountry surveys. Lancet Glob Health 2015; 3: e260–70.
2. **World Health Organization**. Robson classification Implementation manual.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259512/9789241513197-eng.pdf;jsessionid=AF3D95E4BFA6D6A4ACDAAFAE4BFABD22?sequence=1
3. **Nguyễn Đức Hinh, Dương Tử Kỳ,** Nhận xét 247 trường hợp mổ lấy thai ở khoa Sản bệnh viện Bạch Mai**. Y học Việt Nam, số 1-2005, trg 1-6**
4. **Đoàn Vũ Đại Nam, Nguyễn Duy Tài.** Khảo sát tỷ lệ mổ lấy thai theo nhóm phân loại của Robson tại bệnh viện Hùng Vương 2016-2017. Y học TP Hồ Chí Minh, phụ bản tập 22, sồ 1, 2018.
5. **Hoàng Ngọc Tú, Bạch Cẩm Ân, Phan Viết Tâm, Phan Lê Vy Phương, Ngô Hoàng Hiếu, Nguyễn Thị Đông Hiền.** Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai theo phân loại Robson tại bệnh viện Trung Ương Huế. https://www.tailieumienphi/nghien-cuu-chi-dinh-mo-lay-thai-theo-phan-loại- robson-tai-benh-vien-trung-uong-h-x1ofuq.html.
6. **Robson M, Murphy M, Byrne F.** Quality assurance: The 10-Group Classification System (Robson classification), induction of labor, and cesarean delivery. National Maternity Hospital, Dublin, Ireland. International Journal of Gynecology and Obstetrics 131 (2015) S23–S27

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG GULLAIN BARRE ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIÊN NHẬT TÂN

Đỗ Thị Quốc Trinh

TÓM TẮT. Nhân một trường hợp hội chứng Guillain Barré (GBS) được chẩn đoán tại bệnh viên Nhật Tân. GBS xảy ra trên toàn thế giới với tỷ lệ mắc chung là 1 đến 2 trường hợp trên 100.000 mỗi năm. Đây là một bệnh tự miễn mà nguyên nhân đích thực chưa được xác định. GBS là một bệnh cấp tính gây bệnh viêm đa dây thần kinh tiến triển nhanh chóng với biểu hiện yếu hoặc liệt. Một số thể bệnh lúc đầu liệt chân và tay sau đó tiến triển đến cơ hô hấp và mặt. Điều trị bằng thay huyết tương, globulin miễn dịch truyền tình mạch và chăm sóc tích cực có thể giúp bệnh nhân khỏi gần như hoàn toàn.

SUMMARY. One case of Guillain Barré syndrome was diagnosed at Nhat Tan Hospital. This disease occurs worldwide with an overall incidence of 1 to 2 cases per 100,000 per year. It is an autoimmune disease for which the true cause is unknown. GBS is an acute, rapidly progressive polyneuropathy with weakness or paralysis. Some forms of the disease at first paralyzed limbs and then progressed to the respiratory muscles and face. Treatment with plasma replacement, intravenous immunoglobulins, and intensive care can almost completely heal the patient.

TỔNG QUAN

Các bệnh đa dây thần kinh qua trung gian miễn dịch cấp tính được phân loại dưới tên gọi chung là hội chứng Guillain-Barré (GBS), theo tên tác giả của những mô tả ban đầu về bệnh. GBS là một bệnh cấp tính một pha gây ra bệnh viêm đa dây thần kinh tiến triển nhanh chóng với biểu hiện yếu hoặc liệt.

Trong lịch sử, GBS được coi là một rối loạn đơn lẻ. Hiện nay nó được công nhận là một hội chứng không đồng nhất với một số dạng biến thể. Các dạng chủ yếu là:

- Bệnh đa dây thần kinh hủy myelin do viêm cấp tính (AIDP), hay gặp ở châu Âu và Mỹ
- Hội chứng Miller Fisher (MFS), Bệnh thần kinh sợi trục vận động cấp tính (AMAN) đến các cơ, hay gặp ở châu Á
- Bệnh thần kinh sợi trục vận động và cảm giác cấp tính (AMSAN).
- Hội chứng liệt hướng lên Landry Guillain-Barré: Một dạng nặng của hội chứng Guillain-Barre. Rối loạn này thường bắt đầu với một căn bệnh giống như cảm cúm, dẫn đến suy nhược cơ thể nói chung, nhưng sau đó được đặc trưng bởi tình trạng tê liệt tiến triển nhanh chóng bắt đầu ở chân và tay, và có thể di chuyển lên ảnh hưởng đến cơ thở và mặt [5]

Mỗi dạng GBS có các đặc điểm lâm sàng, sinh lý bệnh và bệnh lý phân biệt.

Hội chứng Guillain-Barré (GBS) xảy ra trên toàn thế giới với tỷ lệ mắc chung là 1 đến 2 trường hợp trên 100.000 mỗi năm. Trong khi tất cả các nhóm tuổi đều bị ảnh hưởng, tỷ lệ mắc bệnh tăng khoảng 20 phần trăm với mỗi 10 năm tăng tuổi sau thập kỷ đầu tiên của cuộc đời. Ngoài ra, tỷ lệ mắc bệnh ở nam cao hơn một chút so với nữ [4]

TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Bệnh nhân nữ, MSBN 2000297947, MSVV 20100913, 70 tuổi, nghề nghiệp già yếu, vào viện lúc 7 giờ 56 phút, ngày 22/10/2020 vì tê yếu hai chân

Bệnh nhân đến khám và nhập viện với bệnh sử khởi phát 1 ngày bị tê yếu hai chân còn đi lại được kèm huyết áp cao, không khó thở, ăn uống được, không sốt, có điều trị không giảm

tê yếu nên nhập viện. Bệnh nhân nhập viện 2 ngày triệu chứng tê yếu lan dần lên hai tay, không tự ngồi và đi lại được kèm nói khó, nuốt sặc, bí tiểu. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, liệt tứ chi tương tự cách nay hơn 10 năm kéo dài khoảng 1 tháng rồi hồi phục hoàn toàn, không rõ chẩn đoán, chỉ điều trị ở BV Huyện.

Qua thăm khám lúc nhập viện: Bệnh tỉnh, HA 162/97 mmHg, mạch 72 lần/ phút, nhịp thở 19 lần/ phút, N/độ 36.7 độ C, than tê hai chân, ho khan ít, không yếu liệt, cổ mềm, Tim đều; Phổi trong; Bụng mềm. **Chẩn đoán sơ bộ ban đầu:** Tăng huyết áp – Cơn hạ canxi – Tê và mất cảm giác phân ly

Bệnh nhân được điều trị nội khoa: dùng thuốc hạ áp và bổ sung vitamin và được chỉ định xét nghiệm thường quy và hình ảnh ghi nhận kết quả chỉ có tăng cholesteron máu, Xquang phổi: tổn thương choán chổ mờ, có liềm khí phía trên kèm xơ xung quanh vùng hạ đòn trái nghĩ u nấm/ tổn thương phổi cũ. CTScane sọ não : Hiện không thấy đậm độ bất thường nhu mô não trên phim không cản qunag

Từ ngày thứ 2 đến thứ 6 sau nhập viện, sức cơ tứ chi của bệnh nhân yếu tiến triển tăng dần, bệnh nhân đã được hội chẩn lại. sau khi khám lại lâm sàng tỉ mĩ ghi nhận: Sức cơ tứ chi 1/5, tê nhiều tay chân đều hai bên, giảm cảm giác sờ, cảm giác đau bình thường từ chân đến cổ, không mất cảm giác theo khoanh tủy, kèm nuốt khó, nói ngọng, đàm nhiều khạc yếu, bí tiểu phải đặt sonde tiểu, phản xạ gân xương (-), Babinski (-), dồng tử đều hai bên KT # 2mm, PXAS (+), cổ mềm và được đề nghị chọc dò tủy sống và đo điện cơ tay chân. Kết quả cho thấy dịch não tủy có hiện tượng phân ly đạm tế bào (protein 262 mg/L; Bạch cầu =0) - Điện cơ: Kéo dài thời gian tiềm + Giảm tốc độ dẫn truyền vận động tay chân, mất đáp ứng cảm giác tay chân (hình ảnh điển hình của GBS)

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là Hội chứng Guillain Barre, được hội chẩn chuyển viện tuyến trên để thay huyết tương hay truyền globulin miễn dịch.

BÀN LUẬN

Chẩn đoán GBS theo tiêu chuẩn của Ashbury và comblath năm 1990:

Lâm sàng: Các đặc điểm cần thiết cho chẩn đoán:

1. Có sự yếu cơ tiến triển dần dần của cả chân và tay.

2. Có giảm hoặc mất phản xạ.

- Các đặc điểm lâm sàng hỗ trợ thêm cho chẩn đoán:

3. Tiến triển của các triệu chứng trong nhiều ngày đến 4 tuần.

4. Có tính chất đối xứng của các dấu hiệu.

5. Các triệu chứng hay dấu hiệu cảm giác thường là nhẹ.

6. Tổn thương dây thần kinh sọ (liệt thần kinh mặt hai bên).

7. Bắt đầu phục hồi sau 2-4 tuần sau khi ngừng tiến triển.

8. Rối loạn chức năng thần kinh tự chủ.

9. Không có sốt lúc khởi bệnh.

Cận lâm sàng:

10. Dịch não tủy: Protein tăng, tế bào <10/mm^3

11. Điện cơ: giảm tốc độ dẫn truyền thần kinh hay block dẫn truyền

Xét nghiệm tìm kháng thể IgG trong huyết thanh với GQ1b rất hữu ích cho việc chẩn đoán MFS.

Bệnh nhân của chúng tôi thỏa các tiêu chuẩn 1,2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11 theo tiêu chuẩn của Ashbury và comblath.

Chẩn đoán phân biệt của GBS bao gồm các bệnh đa dây thần kinh cấp tính khác, bệnh đa dây thần kinh do viêm mãn tính khử myelin và các bệnh về tủy sống, điểm nối thần kinh cơ và cơ. Chẩn đoán phân biệt của biến thể MFS của GBS bao gồm đột quỵ thân não, bệnh não Wernicke và viêm não thân não.

GBS được cho là kết quả của phản ứng miễn dịch đối với bệnh nhiễm trùng trước đó, phản ứng chéo với các thành phần thần kinh ngoại vi do một số vi khuẩn có cấu trúc bắt chước các thành phần của dây thần kinh. Đáp ứng miễn dịch có thể hướng tới myelin hoặc sợi trục của dây thần kinh ngoại vi, dẫn đến việc hủy myelin và các dạng GBS theo sợi trục. các nhiễm trùng tiền căn thường gặp trong GBS và được cho là nguyên nhân kích hoạt phản ứng miễn dịch dẫn đến bệnh viêm đa dây thần kinh cấp tính. Khoảng 2/3 bệnh nhân có tiền sử nhiễm trùng đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa trước đây gồm Campylobacter jejuni, Cytomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và virus Zika cũng có liên quan đến GBS. Một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân phát triển GBS sau chủng ngừa, phẫu thuật, chấn thương và cấy ghép tủy xương [4]

Về điều trị:

- Chăm sóc hỗ trợ là cực kỳ quan trọng trong hội chứng Guillain-Barré (GBS) vì có đến 30% bệnh nhân bị suy hô hấp cấp do liết cơ hô hấp cần thở máy. Ngoài ra, rối loạn chức năng tự trị nghiêm trọng (rối loạn nhịp tim, liệt ruột cơ năng, bí tiểu tiện,..) xảy ra ở khoảng 20% và cần được theo dõi tại đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU). [3]
- Đau xảy ra ở khoảng 2/3 số bệnh nhân trong đợt GBS và thường phải điều trị.
- Phương thức chính của liệu pháp điều chỉnh bệnh đối với GBS là thay huyết tương và truyền tĩnh mạch globulin miễn dịch (IVIG) trong vòng 4 tuần kể từ khi khởi phát triệu chứng thần kinh (độ IA). Khi cả hai liệu pháp đều có sẵn như nhau và không có chống chỉ định cho cả hai, khuyến cáo điều trị bằng IVIG (độ 2B). Các phương pháp điều trị là tương đương và cải thiện kết quả. Điều trị giúp rút ngắn thời gian phục hồi từ 40 đến 50 %. [3]
- Đối với bệnh nhân người lớn bị GBS, được khuyến cáo không nên điều trị bằng glucocorticoid (độ 1A).

Tỷ lệ bệnh nhân GBS phục hồi vào thời điểm 06 tháng và 12 tháng sau khi chẩn đoán lần lượt là khoảng 80 và 84%. Vào một năm, khoảng 60% bệnh nhân phục hồi hoàn toàn sức mạnh vận động, trong khi các vấn đề vận động nghiêm trọng vẫn tồn tại ở khoảng 14%. Khoảng 5 đến 10% bệnh nhân GBS có một đợt điều trị kéo dài với vài tháng phụ thuộc vào máy thở và hồi phục rất chậm và không hoàn toàn [3]

Khoảng 10% bệnh nhân GBS có nguy cơ tái phát. Họ sẽ mắc các bệnh lý thần kinh mạn tính (CIDP) [3]

KẾT LUẬN

Hội chứng Guillain–Barré (GBS) là một bệnh lý thần kinh tự miễn tiến triển cấp tính nặng có thể dẫn đến tử vong cũng như để lại những di chứng nặng nề nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Đến nay nguyên nhân đích thực của bệnh vẫn chưa xác định rõ, người ta chỉ tìm thấy bệnh có mối liên quan với một số yếu tố như: nhiễm khuẩn, nhiễm virus, tiêm chủng chấn thương hay phẫu thuật. Phương thức chính của liệu pháp điều chỉnh

bệnh đối với GBS là thay huyết tương và truyền tĩnh mạch globulin miễn dịch (IVIG) trong vòng 4 tuần kể từ khi khởi phát triệu chứng thần kinh và chăm sóc hỗ trợ là cực kỳ quan trọng trong hội chứng Guillain-Barré.

THAM KHẢO

1. **Bộ Y Tế. Hội chứng Guillain Barre.** Hướng dẫn chẩn đoán xử trí và hồi sức tích cực, 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015, trang 132.
2. **Vriesendorp FJ, Shefner JM, Targoff IN, Eichler AF.** Guillain-Barré syndrome in adults: Clinical features and diagnosis, Uptodate, Oct 2020.
3. **Vriesendorp FJ, Shefner JM, Eichler AF**. Guillain-Barré syndrome in adults: Treatment and prognosis, Uptodate, Oct 2020.
4. **Vriesendorp FJ, Shefner JM, Goddeau RP.** Guillain-Barré syndrome: Pathogenesis, Uptodate, Oct 2020.
5. **Adel K. Afifi.** The Landry-Guillain-Barré Strohl Syndrome 1859 to 1992 A Historical Perspective. J Family Community Med. 1994 Jan-Dec; 1(1): 30–34

MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERID

Đỗ Thị Quốc Trinh

TÓM TẮT

Một trường hợp viêm tụy cấp do tăng triglyceride (HTG). HTG được coi là một nguy cơ đáng kể đối với viêm tụy cấp khi nồng độ >1000 mg/dL (11,3 mmol/L). Chẩn đoán sớm về viêm tụy cấp do HTG là quan trọng để được điều trị thích hợp và ngăn ngừa các đợt tái phát.

SUMMARY

A case of acute pancreatitis due to hypertriglyceridemia (HTG). HTG is considered to be a significant risk for acute pancreatitis when concentrations> 1000 mg / dL (11.3 mmol / L). Early diagnosis of HTG-induced acute pancreatitis is important for proper treatment and prevention of relapses

TỔNG QUAN

Tăng triglycerid máu (HTG) là một trong những nguyên nhân của viêm tụy cấp, chiếm từ 1 đến 14% của tất cả các trường hợp viêm tụy cấp và lên đến 56% các trường hợp khi mang thai. Nguy cơ phát triển viêm tụy cấp là khoảng 5% với triglycerid >1000 mg/dL (11,2 mmol/L) và 10 đến 20% với triglycerid> 2000 mg/dL (22,6 mmol/L) [1]

Tăng triglycerid máu (HTG) được xác định bằng mức triglycerid huyết thanh lúc đói >150 mg/dL (1,7 mmol /L). HTG được phân loại như sau:

- Nhẹ (150 đến 199 mg / dL 1,7 đến 2,2 mmol / L)
- Trung bình (200 đến 999 mg / dL, 2,3 đến 11,2 mmol / L)
- HTG nặng (1000 đến 1999 mg / dL, 11,3 đến 22,5 mmol / L)
- HTG rất nặng (≥2000 mg / dL,> 22,6 mmol / L)

Ở Việt Nam, Viêm tụy cấp được biết từ năm 1939, nhưng chưa có tác giả nào nghiên cứu về tình trạng rối loạn lipid máu ở bệnh nhân viêm tụy cấp, đến năm 2011 Nguyễn Thị Hồng Vân bệnh viện Bạch Mai nghiên cứu về đặc điểm rối loạn lipid máu ở bệnh nhân viêm tụy cấp tại khoa Tiêu Hóa, tỷ lệ rối loạn lipid máu ở bệnh nhân viêm tụy cấp 52.4%, trong đó tăng triglyceride 81.9%, triglyceride tăng rất cao 30.3% [3]

HTG được coi là một nguy cơ đáng kể đối với viêm tụy cấp khi nồng độ >1000 mg / dL (11,3 mmol /L) [1]

TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, MSBN: 2000294823, MSVV: 20/100809, nghề nghiệp công chức – viên chức, địa chỉ: Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang. Vào viện 14 giờ 10 phút ngày 19/10/2020.

Bệnh nhân đến khám và nhập viện với bệnh sử đau bụng và nôn ói một ngày trước nhập viện. Đau khởi phát đột ngột và đau nhiều vùng thượng vị. Không có yếu tố làm tăng hoặc giảm đau, kèm nôn ói 5 lần, lượng nhiều, không lẫn máu, không sốt. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp thai kì, viêm dạ dày.

Qua thăm khám, tần số mạch là 96 lần/phút, huyết áp 156/106 mmHg, tần số hô hấp là 19 lần/phút và bệnh nhân không sốt và có mất nước nhẹ. Không ghi nhân ban vàng ở da. Qua khám bụng, ghi nhận ấn đau thượng vị nhiều, bụng chướng hơi, nhu động ruột bình thường. Chúng tôi chẩn đoán sơ bộ là viêm dạ dày cấp – theo dõi viêm túi mật cấp – Đau bụng trên rốn – Trào ngược dạ dày thực quản.

Bệnh nhân được điều trị nội khoa: Truyền dịch, PPI, chống nôn và giảm co thắt cơ trơn đường tiêu hóa. Xét nghiệm: Bạch cấu 12650/mm3, Neu 82.7%, glucose sau ăn 203 mg/dl, HbA1C 11.01%, eGFR 75 ml/ phút/ 1.73m2, amylase 13209U/L, Lipase 1133 U/L; Cholesteron TP 36.1 mmol/L, HDL 0.6 mmol/L, LDL 9.6 mmol/L, Triglycerid 14.2 mmol/L, siêu âm bụng ghi nhận đầu tụy phù nề d=4.7 cm, có phản âm dày không đồng nhất, thâm nhiễm mỡ và tụ dịch quanh tụy – Gan nhiễm mỡ độ 2 => **Chẩn đoán xác dịnh:** Viêm tụy cấp ngày 2 do tăng triglyceride máu

Bệnh nhân vẫn được điều trị Nội khoa, dung them kháng sinh Ceftriaxon. Điều trị giảm triglycerid bằng insulin truyền tĩnh mạch. Qua gần 24 giờ điều trị nội khoa, bệnh nhân còn đau bụng, nhợn ói, sonde dạ dày còn ra dịch, tổng lượng dịch truyền khoảng 4000ml/ 23 giờ, tiểu 1500ml/ 16 giờ nhập viện, bụng chướng hơi, ấn đau thượng vị. Xét nghiệm lần 2 Triglycerid 14.1 mmol/L, eGFR 43.7 ml/ phút/ 1.73m2, K+ 3.3 mmol/L, được chẩn đoán: Viêm tụy cấp ngày 3 do tăng triglyceride máu – Tổn thương thận cấp – Đái tháo đường type 2 – Nhiễm trùng tiêu hóa – Gan nhiễm mỡ độ 2 – Hạ kali máu – Tiên lượng nặng có chỉ định thay huyết tương, nên hội chẩn lãnh đạo chuyển viện tuyến trên điều trị tiếp.

BÀN LUẬN

Tăng triglyceride máu là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của viêm tụy cấp. Chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglyceride khi nồng độ triglyceride huyết thanh > 1000 mg/dl (11.2 mmol/L). Bệnh nhân của chúng tôi có triglyceride huyết thanh 1267 mg/dl (14.2 mmol/L).

Tăng triglyceride máu có thể là nguyên phát: kết quả của các rối loạn di truyền khác nhau dẫn đến rối loạn chuyển hóa lipid máu làm tăng triglycerid nghiêm trọng và tăng nguy cơ viêm tụy cấp gồm: Rối loạn lipid máu loại I (chylomicrons cao), IV (lipoprotein tỷ trọng rất thấp (VLDL)) và V (chylomicrons cao và VLDL). Tăng triglyceride máu thứ phát do các nguyên nhân mắc phải như đái tháo đường kiểm soát kém – nhiễm ceton do đái tháo đường, thuốc (estrogen, tamoxifen,olanzapine,thiazide,..), mang thai, rượu, suy giáp. Ở bệnh nhân của chúng tôi, có tiền sử tăng huyết áp thai kì, tiền sử gia đình không ghi nhận về rối loạn tăng lipid máu, và được phát hiện đái tháo đường type 2 sau khi nhập viện.

Chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu cũng giống như các nguyên nhân khác của viêm tụy cấp và cần có hai trong ba tiêu chuẩn sau: khởi phát cấp tính, dai dẳng, dữ dội, đau thượng vị thường lan ra sau lưng, tăng lipase huyết thanh hoặc amylase cao hơn ba lần hoặc lớn hơn giới hạn trên của mức bình thường và các phát hiện đặc trưng của viêm tụy cấp trên hình ảnh (chụp cắt lớp vi tính có chất cản quang, chụp cộng hưởng từ hoặc siêu âm qua ổ bụng). Triệu chứng lâm sàng gợi ý tăng triglyceride máu là ban vàng (xanthomas) ở cánh tay, chân, lưng và mông và gan lách to do thâm nhiễm mỡ. Bệnh nhân của chúng tôi nhập viện vì đau bụng nhiều kèm nôn ói, không ghi nhận ban vàng, xét nghiệm amylase 13209 U/L, Lipase 1133 U/L; siêu âm bụng ghi nhận đầu tụy phù nề d=4.7 cm, có phản âm dày không đồng nhất, thâm nhiễm mỡ và tụ dịch quanh tụy – Gan nhiễm mỡ độ 2.

Bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng triglycerid có xu hướng bị viêm tụy nặng hơn so với những bệnh nhân bị viêm tụy do nguyên nhân khác. Mức độ tăng triglycerid có liên quan đến mức độ nặng của viêm tụy cấp, nồng độ triglyceride càng cao thì tỷ lệ viêm tụy cấp nặng càng tăng. Bệnh nhân tăng triglycerid máu có nhiều khả năng bị suy cơ quan dai dẳng hơn so với bệnh nhân có triglycerid bình thường (40% so với 17%) [1]

Ở nồng độ triglycerid cao, huyết thanh trở nên có màu trắng sữa (màu trắng đục). Nồng độ triglyceride tăng cao có thể thay đổi các phép đo thông thường của natri, amylase và lipoprotein tỷ trọng thấp. Nồng độ triglyceride > 500 mg/dL (5,6 mmol / L) có thể gây ra

mức amylase bình thường giả, có thể do nhiễu của kết quả đo nhiệt lượng (calorimetric). Việc pha loãng nối tiếp mẫu amylase huyết thanh có thể làm giảm nhiễu triglyceride [1]

Về cơ chế bệnh sinh: sự phân hủy triglycerid thành các axit béo tự do độc hại (FFA) bởi các lipase tuyến tụy là nguyên nhân gây ra nhiễm độc mỡ trong viêm tụy cấp. Mức độ nghiêm trọng của viêm tụy cấp ở bệnh nhân tăng triglycerid máu (HTG) phụ thuộc vào cả phản ứng viêm do chính viêm tụy gây ra, cộng với tổn thương do nhiễm độc chất béo do thủy phân triglycerid.

Xử trí ban đầu bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng triglyceride bao gồm chăm sóc hỗ trợ bằng cách hồi sức bằng dịch, kiểm soát đau và hỗ trợ dinh dưỡng và giảm nồng độ triglycerid huyết thanh xuống <500 mg / dL (5,6 mmol / L).

- Ở những bệnh nhân có mức triglycerid huyết thanh> 1000mg / dL cộng với lipase> 3 lần giới hạn trên của mức bình thường và có dấu hiệu hạ calci huyết, nhiễm acid lactic, dấu hiệu nặng hơn của viêm hệ thống hoặc rối loạn chức năng cơ quan, hoặc suy đa cơ quan,được đề nghị điều trị bằng phương pháp thay huyết tương (2C). Nồng độ triglycerid nên được theo dõi mỗi chu kỳ thay huyết tương và ngưng khi nồng độ triglyceride <500 mg / dL (5,6 mmol / L).
- Ở những bệnh nhân không có các dấu hiệu nêu trên, được đề nghị bắt đầu điều trị bằng insulin truyền tĩnh mạch (2C), với tốc độ 0,1 đến 0,3 đơn vị / kg / giờ. Ở những bệnh nhân có lượng đường trong máu từ 150 đến 200 mg / dL, chúng tôi thực hiện bổ sung glucose qua đường tĩnh mạch với dịch truyền dextrose 5% riêng biệt để ngăn ngừa hạ đường huyết. Nồng độ triglycerid nên được theo dõi sau mỗi 12 giờ. Đường huyết thanh nên được đo mỗi giờ và phải điều chỉnh lượng truyền insulin / 5% dextrose cho phù hợp. Nên ngừng truyền insulin khi mức triglycerid <500 mg / dL (5,6 mmol / L).
- Khi nồng độ triglycerid <500 mg / dL (5,6 mmol / L), bệnh nhân cần điều trị lâu dài để ngăn ngừa viêm tụy tái phát và ngăn ngừa các biến chứng khác của tăng triglycerid. Điều này bao gồm cả dung thuốc (gemfibrozil 600 mg hai lần mỗi ngày) và thay đổi chế độ ăn uống (ví dụ, chế độ ăn hạn chế chất béo và đường đơn giản). Các can thiệp không dùng thuốc khác bao gồm giảm cân ở bệnh nhân béo phì, tập thể dục nhịp điệu, tránh ăn đường đậm đặc và các loại thuốc làm tăng mức triglycerid huyết thanh và kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt ở bệnh nhân đái tháo đường.
- Bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng triglycerid nên được đánh giá xem có nguyên nhân thứ phát gây tăng triglycerid máu hay không. Đối với bệnh nhân tăng triglycerid máu không rõ ràng do nguyên nhân thứ phát, người nhà cần được kiểm tra nồng độ triglycerid lúc đói.

KẾT LUẬN

Tăng triglycerid máu (HTG) là một nguyên nhân quan trọng của viêm tụy cấp. Nhận biết lâm sàng sớm về viêm tụy cấp do HTG là quan trọng để đưa ra liệu pháp điều trị thích hợp và ngăn ngừa các đợt tiếp tục.

THAM KHẢO

1. **Gelrud A, Whitcomb DC, Friedman LS, Grover S**, Hypertriglyceridemia-induce acute pancreatitis, Uptodate, sep 2020.
2. **Bộ Y Tế.** Viêm tụy cấp năng. Hướng dẫn chẩn đoán xử trí và hồi sức tích cực, 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015, trang 102.
3. **Nguyễn Gia Bình, Hoàng Đức Chuyên**, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm tụy cấp do tăng triglyceride, Báo cáo kết quả đề tài cấp cơ sở, Bệnh viện Bạch Mai, 2012.

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC SỐT CỦA NGƯỜI MẸ CÓ CON DƯỚI 6 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG NĂM 2020

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Hồng Gấm

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sốt là tình trạng thường xảy ra với trẻ em đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi. Có nhiểu cách phân loại sốt như sốt nhẹ, sốt vừa và sốt cao. Việc phát hiện sớm biểu hiện sốt của trẻ em giúp cho việc phòng ngừa co giật ở trẻ. Vì vậy, việc chăm sóc trẻ đúng cách trong giai đoạn trẻ sốt là rất quan trọng.

Theo dõi thân nhiệt giúp đánh giá tình trạng của người bệnh, khi có các trị số bất thường để có biện pháp xử trí kịp thời

Gia đình là nơi phát hiện trẻ sốt đầu tiên, khi trẻ sốt cao nếu người mẹ không biết cách xử trí và chăm sóc trẻ sốt sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng của trẻ.

Nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Yến (2013) có kết quả tỷ lệ trẻ sốt cao là 78,7%, 17,6 % bà mẹ có hành vi hỗ trợ hạ sốt cho trẻ chưa đúng, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ nếu có co giật xảy ra.[9]

Nghiên cứu của tác giả Thân Thị Uyên (2018) cho thấy tỷ lệ trẻ co giật do sốt cao 66,9% và sốt gây co giật trong 24 giờ đầu [6]

Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này đề "khảo sát kiến thức và thực hành chăm sóc sốt của bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại khoa Nội nhi Bệnh viện Sản Nhi năm 2020" nhằm tìm hiểu kiến thức, thực hành chăm sóc sốt và các yếu tố liên quan đến thực hành đúng của các bà mẹ khi chăm sóc trẻ sốt.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát

Xác định tỷ lệ kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến chăm sóc sốt của bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại khoa Nội nhi của Bệnh viện Sản Nhi năm 2020.

Mục tiêu cụ thể

Xác định tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng trong chăm sóc sốt ở trẻ dưới 6 tuổi tại khoa Nội nhi của Bệnh viện Sản Nhi năm 2020

Xác định tỷ lệ bà mẹ thực hành đúng trong chăm sóc sốt ở trẻ dưới 6 tuổi tại khoa Nội nhi của Bệnh viện Sản Nhi năm 2020

Xác định các yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc sốt của bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại khoa Nội nhi của Bệnh viện Sản Nhi năm 2020

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Nhiệt độ trung bình của cơ thể: từ $36,5^0$C - 37^0C

Cơ chế gây sốt: Do ảnh hưởng tác nhân gây bệnh kích thích trung tâm điều nhiệt dẫn đến thay đổi điểm điều nhiệt làm tăng sản nhiệt, giảm thải nhiệt dẫn đến trẻ sốt.

Sốt có nhiều biểu hiện khác nhau: sốt nhẹ: 37,5^{0}C đến 38,5^{0}C, sốt vừa: 38,5^{0}C đến 39,5^{0}C, sốt cao: 39,5^{0}C đến 40^{0}C và sốt rất cao: trên 40^{0}C.

Có nhiều vị trí đo thân nhiệt của trẻ: như trán, nách, hậu môn.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích

2.2 Cở mẫu

Với $z_{\alpha/2}$ = 1,96

d = 0,05 (sai số tương đương)

p = 10,9%

n = 138.

2.3 Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thời gian: Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Khoa Nội Nhi – Bệnh viện Sản Nhi An Giang

2.4 Phương pháp chọn mẫu: thuận tiện

2.5 Đối tượng nghiên cứu:

Những bà mẹ có con dưới 6 tuổi đang điều trị nội trú tại khoa Nội Nhi có biểu hiện sốt trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020.

Tiêu chuẩn chọn vào:

Tất cả những bà mẹ có con dưới 6 tuổi có biểu hiện sốt trong thời gian điều trị nội trú tại khoa Nội Nhi của Bệnh viên Sản Nhi An Giang

Đồng ý tham gia nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ:

Những bà mẹ mù chữ, người dân tộc thiểu số không hiểu tiếng Việt.

Những trường hợp trẻ có biểu hiện nặng trong thời gian tham gia nghiên cứu.

Không đồng ý tiếp tục tham gia trong thời gian nghiên cứu.

2.6 Phương pháp thu thập số liệu

Liên hệ với điều dưỡng trưởng khoa cho phép tiến hành thu thập số liệu.

Liên hệ với những bà mẹ có con dưới 6 tuổi để giải thích mục đích nghiên cứu và đồng ý tham gia nghiên cứu.

Nghiên cứu viên tiến hành phỏng vấn thử nghiệm trên 6 bà mẹ và chỉnh sửa bộ câu hỏi cho phù hợp.

Sau khi đồng ý tham gia nghiên cứu, bà mẹ được phát phiếu phỏng vấn, thời gian buổi phỏng vấn từ 5 – 10 phút.

Khảo sát thực hành: Bà mẹ tiến hành thực hành quy trình lau mát cho trẻ, nghiên cứu viên quan sát và cho điểm.

Phân tích số liệu và báo cáo kết quả.

2.7 Công cụ nghiên cứu:

Bảng câu hỏi khảo sát về kiến thức và thực hành chăm sốt của bà mẹ theo giáo trình chăm sóc sức khỏe trẻ em của cho đối tượng Cao đẳng Điều dưỡng của Bộ Giáo Dục Việt Nam năm 2016 và Giáo trình Bệnh học trẻ em của Lê Thị Mai Hoa. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014. [4], [5].

2.8 Các biến số trong nghiên cứu:

Biến số về kiến thức của bà mẹ về chăm sóc sốt cho trẻ: Kiến thức đúng là khi người mẹ trả lời đúng 70% tổng điểm kiến thức, nếu dưới 70% là kiến thức chưa đúng.

Biến số về thực hành chăm sóc trẻ sốt: Thực hành chăm sóc sốt đúng là khi bà mẹ thực hành đúng 70% tổng điểm của quy trình, thực hành dưới 70% tổng điểm của quy trình là thực hành chưa đúng.

2.9 Phương pháp phân tích số liệu:

Số liệu sau khi thu thập được mã hóa và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0

3. Y đức trong nghiên cứu

Nghiên cứu được thông qua hội đồng Khoa học kỹ thuật của trường Cao Đẳng Y Tế An Giang, và sự chấp thuận của Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

Người tham gia nghiên cứu phải được giải thích mục tiêu và lợi ích khi tham gia nghiên cứu và tự nghiện đồng ý tham gia nghiên cứu.

Nghiên cứu này chỉ là phỏng vấn trên người mẹ, hoàn toàn không có thủ thuật xâm lấn trên trẻ.

Tất cả những thông tin của người tham gia nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, báo cáo, phân tích số liệu chỉ nhằm phục vụ cho nghiên cứu, ngoài ra không dùng với mục đích nào khác

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng tham gia

Nội dung	Số lượng (n)	Tỷ lệ (%)
Tuổi của đối tượng tham gia nghiên cứu		
Dưới 30 tuổi	92	66,6
Từ 30 tuổi trở lên	46	33,4
Trình độ học vấn người mẹ		
Tiểu học	94	68,1
Trung học cơ sở	17	12,3
Nguồn cung cấp thông tin về chăm sóc sốt		
Báo, đài	22	15,9
Tìm hiểu trên internet	36	26,0
Người thân	33	23,9
Cán bộ y tế	47	34,0

Độ tin cậy của công cụ nghiên cứu

Cobach’s Anpha	Chỉ số
Kiến thức	0,73
Thực hành	0,79

Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức có độ tin cậy là 0,73 và thực hành là 0,79.

3.2. Kiến thức về chăm sóc sốt cho trẻ

Nội dung	Số lượng (n)	Tỷ lệ (%)
Đúng	57	41,3
Chưa đúng	81	58,7
Tổng	138	100

Nhận xét: Dựa vào bảng trên cho thấy, bà mẹ có kiến thức đúng về chăm sóc sốt cho trẻ chiếm tỷ lệ 41,3%, thấp hơn những bà mẹ có kiến thức chưa đúng là 58,7%. Điều này nói lên đa số bà mẹ có kiến thức chưa đúng về cách chăm sóc sốt cho trẻ.

3.3. Thực hành chăm sóc sốt của bà mẹ

Nội dung	Số lượng (n)	Tỷ lệ (%)
Đúng	43	31,1
Chưa đúng	95	68,9
Tổng	138	100

Nhận xét: Dựa vào bảng trên cho thấy kết quả là đa số bà mẹ thực hành chăm sóc sốt chưa đúng chiếm tỷ lệ rất cao 68,9%, người mẹ thực hành chăm sóc đúng là 31,1%.

3.4. Mối liên quan giữa đặc điểm chung của đối tượng tham gia và thực hành chăm sóc sốt

Đặc điểm	Thực hành		Tổng	OR (95% CI)	P
	Đúng	Chưa đúng			
	n (%)	n (%)	n (%)		
Tuổi					
Dưới 30 tuổi Từ 30 tuổi trở lên	25 (19,0) 18 (12,1)	67 (47,6) 28 (21,3)	92 (66,6) 46 (33,4)	3,520 (1,249-3,380)	0,016
Trình độ học vấn					
Tiểu học Trên tiểu học	16 (11,5) 27 (19,6)	78 (56,6) 17 (12,3)	94 (68,1) 44 (31,9)	0,336 (0,115-0,980)	0,043
Ngồn cung cấp thông tin					
Cán bộ y tế Khác	29 (18,8) 14 (10,2)	18 (15,2) 77 (55,8)	47 (34,0) 91 (66,0)	0,241 (0,141-0,458)	0,001

Nhận xét: Dựa vào kết quả trên cho thấy: Các yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc sốt của bà mẹ là độ tuổi, trình độ học vấn và nguồn cung cấp thông tin, đều có ý nghĩa thống kê vời giá trị p lần lượt là: 0,016; 0,043; 0,001.

3.5 Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành chăm sóc sốt

Kiến thức	Thực hành		Tổng	OR (95% CI)	P
	Đúng	Chưa đúng			
	n (%)	n (%)	n (%)		
Đúng Chưa đúng	26 (19,0) 17 (12,1)	31 (22,3) 64 (46,6)	57 (41,3) 81 (58,7)	1,296 (2,597-26,751)	0,049
Tổng	43 (31,1)	95 (68,9)	138(100)		

Nhận xét: Dựa vào bảng trên cho thấy, tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng thực hành chăm sóc trẻ sốt tốt hơn những bà mẹ có kiến thức đúng và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê p=0,049.

CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN

Qua nghiên cứu này cho thấy đa số những bà mẹ có con dưới 5 tuổi nằm trong nhóm tuổi dưới 30 tuổi, những bà mẹ trong nhóm tuổi dưới 30 tuổi thực hành chăm sóc đúng cao hơn những bà mẹ nằm trong nhóm từ 30 tuổi trở lên và có ý nghĩa thông kê (p< 0,05), nghiên cứu chúng tôi tương đồng với nghiên cứu của tác giả Võ Thị Tiến (2012) cho kết quả là nhóm tuổi dưới 30 tuổi thực hành chăm sóc tốt hơn nhóm khác và có ý nghĩa thống kê p< 0,05. [8]

Trình độ hiện tại, nhóm bà mẹ có trình độ trên tiểu học thực hành chăm sóc sốt tốt hơn nhóm khác và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê p = 0,043. Nghiên cứu chúng tôi tương đồng với nghiên cứu của Võ Thị Tiến (2012) cho kết quả là những bà mẹ có trình độ từ cấp II trở lên thực hành chăm sóc trẻ sốt tốt hơn so với những nhóm khác và có ý nghĩa thống kê (p<0,05).[8]

Qua nghiên cứu cho thấy, nguồn cung cấp thông tin về cách chăm sóc sốt những bà mẹ nhận được chủ yếu từ cán bộ y tế chiếm tỷ lệ cao hơn nhóm khác (34,0%), những bà mẹ được cung cấp thông tin bởi cán bộ y tế thực hành chăm sóc tốt hơn những bà mẹ nhận thông tin từ nguồn khác gấp 0,2 lần và có ý nghĩa thống kê p<0,05

Qua khảo sát 138 bà mẹ có con dưới 5 tuổi, tỷ lệ người mẹ có kiến thức đúng có tỷ lệ 41,3%, kiến thức chưa đúng là 58,7%. Nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ thấp hơn nghiên cứu của Đặng Thị Hồng Khánh (2017) về thực hành chăm sóc sốt của các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017 có tỷ lệ là 52,7%.[3]

Tỷ lệ bà mẹ thực hành đúng là 31,1%. Nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ bà mẹ thực hành chăm sóc sốt cho trẻ cao hơn nghiên cứu của tác giả Đoàn Thị Ngọc Diệp (2012), có kết quả là tỷ lệ bà mẹ thực hành chăm sóc đúng là 15%.

Qua nghiên cứu cho thấy, những người mẹ có kiến thức đúng thực hành chăm sóc tốt hơn so với nhóm còn lại cao gấp 1,2 lần và có ý nghĩa thống kê p < 0,05. Nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với nghiên cứu của tác giả Đặng Thị Hồng Khanh (2017) cho kết quả kiến thức và thực hành tương quan đồng biến gấp 1,2 lần và có ý nghĩa thống kê p<0,05.[3]

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Tỷ lệ người mẹ dưới 30 tuổi là 66,6%, trình độ của bà mẹ đa số là tiểu học chiếm tỷ lệ 68,1%.

Tỷ lệ người mẹ có kiến thức đúng 41,3% kiến thức chưa đúng là 58,7%

Tỷ lệ người mẹ thực hành đúng đúng 31,1% kiến thức chưa đúng là 68,9%

Các yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc của bà mẹ là: nhóm tuổi, trình độ học vấn, nguồn cung cấp thông tin và kiến thức về chăm sóc sốt của bà mẹ.

KIẾN NGHỊ

Điều dưỡng khoa Nội nhi cần tập trung tư vấn cho người chăm sóc trẻ về các biện pháp lau ấm cho trẻ giúp cho trẻ mau hồi phục, hạn chế các biến chứng và tăng sự tin tưởng của gia đình đối với bệnh viện.

Giáo viên hướng dẫn lâm sàng nhi cần tăng cường hướng dẫn cho sinh viên cách tư vấn và hướng dẫn cho người nhà các biện pháp chăm sóc sốt cho những người chăm sóc trẻ tại bệnh viện giúp trẻ mau hồi phục sức khỏe và giúp gia đình bé giảm lo lắng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Đoàn Thị Ngọc Diệp** (2012) khảo sát thực hành của bà mẹ có con bị sốt co giật tại khoa cấp cứu Bệnh viện nhi đồng 2 năm 2012.

2. **Cao Xuân Đĩnh** (2012) Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, điện não đồ và hiệu quả dự phòng co giật do sốt ở trẻ em năm 2012.

3. **Đặng Thị Hồng Khanh** (2017) về thực hành chăm sóc trẻ sốt của các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương và một số yếu tố liên quan năm 2017.

4. **Giáo trình Bệnh học trẻ em của Lê Thị Mai Hoa**. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014.

5. **Giáo trình điều dưỡng cơ sở giành cho đào tạo cử nhân điều dưỡng năm 2018**.

6. **Thân Thị Quyên** (2018) Khảo sát yếu tố nguy cơ liên quan đến sốt cao co giật ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi năm 2018.

7. **Đinh Thị Diễm Thúy** (2012) Khảo sát hiệu quả khả năng phát hiện bệnh tay chân miệng diễn biến nặng bằng tờ theo dõi mỗi giờ được sử dụng cho thân nhân bệnh nhi tại khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2012.

8. **Võ Thị Tiến** (2012) Kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ về phòng chống bệnh tay chân miệng tại nhà.

9. **Phạm Hải Yến** (2013) Nghiên cứu đặc điểm sốt của trẻ nhập viện và một số biểu hiện về hành vi, kiến thức của các bà mẹ khi có con bị sốt tại khoa Nhi Bệnh viện Quân Y 103 năm 2013.